



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE
MESTRADO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE**

ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA MAMEDE

**ASPECTOS BIOPSIKOSSOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS
IDOSAS PRATICANTES DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS**

**CAMPINA GRANDE
FEVEREIRO/2026**

ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA MAMEDE

**ASPECTOS BIOPSIKOSSOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS
IDOSAS PRATICANTES DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS**

Dissertação apresentada ao
Programa de Pós-graduação em
Psicologia da Saúde (UEPB), nível
Mestrado, como requisito para
obtenção do título de Mestre em
Psicologia da Saúde.

Linha de Pesquisa: Processos
Psicossociais e Saúde

Orientador(a): Profa. Dra. Carlúcia Ithamar Fernandes Franco

**CAMPINA GRANDE
FEVEREIRO/2026**

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

M264a Mamede, Ana Caroline Pereira da Silva.

Aspectos biopsicossociais e qualidade de vida em pessoas idosas praticantes de atividades artísticas e culturais [manuscrito] / Ana Caroline Pereira da Silva Mamede. - 2026.

123 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Carlucia Ithamar Fernandes Franco, Departamento de Fisioterapia - CCBS".

1. Qualidade de vida. 2. Envelhecimento. 3. Funcionalidade. 4. Promoção de saúde. I. Título

21. ed. CDD 305.26

ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA MAMEDE

ASPECTOS BIOPSISSOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS
IDOSAS PRATICANTES DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da Saúde da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestra em Psicologia
da Saúde

Linha de Pesquisa: Processos
psicossociais e saúde.

Aprovada em: 25/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Carlucia Ithamar Fernandes Franco** (***.063.774-**), em **07/04/2026 11:45:58** com chave **7d84bace329011f19f689a63f4e314d8**.
- **Edil Ferreira da Silva** (***.864.734-**), em **07/04/2026 11:40:48** com chave **c4d55d26328f11f1bc1096a5dec6d3d8**.
- **Flávio Lúcio Almeida Lima** (***.364.624-**), em **16/04/2026 15:47:45** com chave **c1e46cf639c411f190db52667920de80**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 28/04/2026

Código de Autenticação: 58f658



À minha mãe, Eliane Norberto - sei que seu coração transborda de alegria ao me ver
concluir essa etapa de Pós-Graduação.
Ao meu esposo Voltaérys Mamede e nossos filhos, Ester e Timóteo, por quem e para
quem são todos os meus esforços, dedico.

AGRADECIMENTOS

Nenhum trabalho é passível de ser realizado sozinho, este não foi diferente. Tenho muito a quem agradecer;

Ao meu Deus, pois por meio dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a Glória!

Ao meu esposo e companheiro de vida, Voltaérys Mamede e a nossos amados filhos Ester e Timotéo Mamede, obrigada por impulsionarem a conclusão desta etapa, sem vocês nada disso seria possível, vocês são os meus “para quem”, sempre serão minha motivação diária, sem vocês eu não teria chegado à este momento.

À minha orientadora Carlúcia Ithamar Fernandes Franco, a quem sempre serei grata pela orientação não apenas no Mestrado, mas desde a graduação, obrigada por todos os ensinamentos e amizade durante a caminhada até aqui.

Ao meu irmão em Cristo, professor Doutor Suenildo Jósemo, que de forma tão solícita colaborou em toda a análise estatística nesta pesquisa.

Aos professores e a todo o corpo docente, coordenação e secretaria que compõe o Mestrado em Psicologia da Saúde da UEPB, por todos os ensinamentos, discussões e atravessamentos, à vocês, minha gratidão.

À toda a equipe que auxiliou no desenvolvimento desta pesquisa nas pessoas de Sérgio de Faria Lopes, colega mestrado, Maria Gabriela Silva, Sara Rainara, Thamires Nunes, Heloisa Almeida, Eloíza Barbosa e Catarina Aragão, alunas de Iniciação Científica e Samir Souza, Fisioterapeuta.

Aos meus colegas de turma, que dividiram comigo toda essa caminhada.

Aos que fazem o Centro Artístico e Cultural da UEPB (CAC/UEPB) nas pessoas de José Cristóvão de Andrade - Pró-Reitor de Cultura da UEPB; Patrícia Maria Silva Lucena - Diretora do CAC/UEPB; Caio César Ferreira Gonçalves - professor da Oficina de Violão;

e demais colaboradores do CAC, obrigada pela parceria, colaboração e incentivo à pesquisa.

À todos os alunos do CAC/UEPB, que de forma tão solícita contribuíram para a realização deste trabalho.

Aos meus amados irmãos em Cristo da Igreja Batista Regular no Alto Branco pelas orações e incentivo diários.

À UEPB e a CAPES e o CNPq pelo incentivo à Pesquisa e Pós-Graduação.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

"Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas; glória, pois, a Ele eternamente.

Amém" (Romanos 11:36)

RESUMO

O aumento da população idosa e as particularidades que esta faixa etária apresenta apontam para a necessidade de melhor elucidar os fatores Biopsicossociais e a Percepção de Qualidade de Vida destes indivíduos. A Funcionalidade é definida como sendo a combinação da Capacidade Física e Mental, favorecida ou não pelo contexto que está inserido e apresenta relação direta com a percepção de Qualidade de Vida, juntamente com a Cognição e o Estado Emocional. As Atividades Artístico Culturais configuram-se como uma estratégia não farmacológica que promovem o prazer, a socialização, o bem-estar e a melhoria da saúde física e mental. O objetivo desta pesquisa é avaliar as repercussões das Atividades Artístico Culturais, sob os aspectos Biopsicossociais e a Qualidade de Vida em pessoas idosas. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico, com abordagem quali-quantitativa; instrumentos de coleta de dados: *Checklist da CIF – Adaptada*; *Mini Exame de Estado Mental (MEEM)*; *Inventário de Depressão de Beck (BDI)*; *Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A)*; *Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20)*; *World Health Organization Quality of Life” – Bref (WHOQOL – Bref)*. Os resultados apontam que a Percepção de qualidade de vida pode ser modulada de acordo com os aspectos Biopsicossociais; há uma relação inversamente proporcional entre a qualidade de vida e Ansiedade e Depressão; além de observar-se que a funcionalidade tem papel fundamental na percepção de qualidade de vida na pessoa idosa; no que refere-se a cognição, observou-se sugestivo comprometimento cognitivo leve. Conclui-se que as atividades artísticas e culturais constituem uma importante ferramenta para promoção de saúde nos aspectos estudados e melhora na percepção de qualidade de vida na pessoa idosa.

Palavras chave: qualidade de vida; envelhecimento; funcionalidade; saúde; promoção de saúde.

ABSTRACT

The growing elderly population and the specific characteristics of this age group highlight the need to better understand the biopsychosocial factors and perceived quality of life among older adults. Functionality is defined as the combination of physical and mental capacity, influenced by contextual factors, and is directly related to quality of life perception, along with cognition and emotional status. Artistic and cultural activities are considered non-pharmacological strategies that promote pleasure, socialization, well-being, and improvements in physical and mental health. This study aimed to evaluate the impact of artistic and cultural activities on biopsychosocial aspects and quality of life in older adults. This is a cross-sectional, descriptive, and analytical study with a mixed-methods (qualitative and quantitative) approach. Data collection instruments included the adapted International Classification of Functioning Checklist (ICF Checklist), Mini-Mental State Examination (MMSE), Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Anxiety Scale (HAM-A), Clinical-Functional Vulnerability Index (CFVI-20), and the World Health Organization Quality of Life – Bref (WHOQOL-Bref). The results indicate that quality of life perception can be modulated by biopsychosocial factors; there is an inverse relationship between quality of life and levels of anxiety and depression; functionality plays a fundamental role in quality of life perception among older adults; and findings suggest mild cognitive impairment. It is concluded that artistic and cultural activities constitute an important tool for health promotion in the studied asp contribute to improved quality of life perception in older adults.

Keywords: quality of life; aging; functionality; health; health promotion.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Características das informações sociodemográficas	33
Tabela 2	Distribuição do grau de escolaridade	39
Tabela 3	Análise do Teste de Levene	40
Tabela 4	Avaliação do Teste de Kolmogorov-Smirnov	41
Tabela 5	Análise da Correlação entre os instrumentos estudados	41
Tabela 6	Análise de Variância para as dominâncias MEEM, Woqhol e IVCF-20 nas atividades artísticas de dança e instrumentos musicais	43
Tabela 7	Análise Multivariada – Análise de Componentes Principais (PCA/ACP)	44
Tabela 8	Perfil Funcional – Grupo 1 (Dança) e Grupo 2 (Instrumentos Musicais)	50
Tabela 9	Características das informações sociodemográficas	74
Tabela 10	Distribuição de acordo com o grau de escolaridade	81
Tabela 11	Avaliação da homoscedasticidade das Variâncias – Teste de Levene	82
Tabela 12	Teste de Kolmogorov-Smirnov	83
Tabela 13	Análise da correlação entre as variáveis estudadas – Correlação de Pearson	84
Tabela 14	Análise de Variância	85
Tabela 15	Análise Multivariada – Análise dos componentes principais (PCA)	88

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- ABVD's - Atividades Básicas de Vida Diárias
- AIVD's - Atividades Instrumentais de Vida Diárias
- AVDs - Atividades de Vida Diárias
- CAC/UEPB - Centro Artístico e Cultural da Universidade Estadual da Paraíba
- CI – Capacidade Intrínseca
- CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde
- DM - *Diabetes Mellitus*
- DSS - Determinantes Sociais em Saúde
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística
- HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica
- OMS - Organização Mundial de Saúde
- OPAS - Organização Panamericana de Saúde
- PCA/ACP – Análise de Componentes Principais
- PC/CP – Componente Principal
- QV - Qualidade de vida
- QVRS - Qualidade de Vida Relacionada a Saúde
- WHO - World Health Organization

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Sessões do IVCF-20 que obtiveram maior porcentagem de respostas indicativas de fragilidade	51
Quadro 2 Análise das Médias por Domínios e facetas do WOQHOL-Bref	53
Quadro 3 Análise da distribuição da percepção de Qualidade de Vida (QV)	93

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1	Análise da autopercepção de saúde	35
Gráfico 2	Distribuição de Condições de Saúde	36
Gráfico 3	Auto Percepção de Segurança alimentar	38
Gráfico 4	Distribuição do ponto de corte por escolaridade através do MEEM – Dança	47
Gráfico 5	Distribuição do ponto de corte por escolaridade através do MEEM - Instrumentos Musicais	48
Gráfico 6	Distribuição de condições de Saúde	76
Gráfico 7	Avaliação da Autopercepção de Saúde Mental	77
Gráfico 8	Análise da frequência de condições de Saúde Mental	78
Gráfico 9	Autopercepção de Segurança alimentar	80

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	14
2	OBJETIVO GERAL	19
2.1	Objetivos Específicos	19
3	HIPÓTESE	20
4	ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	21
5	MANUSCRITO 1	22
6	MANUSCRITO 2	62
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	103
	REFERÊNCIAS	105
	APÊNDICE A – CHEKLIST DA CIF ADAPTADA	108
	APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM PROJETO DE PESQUISA	110
	APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL EM CUMPRIR OS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 466/2012 E / OU RESOLUÇÃO Nº 510 DE 2016 DO CONEP/CNS/MS (TCPR)	111
	APÊNDICE D – TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS DE ARQUIVO OU PRONTUÁRIOS (TCDA).....	112
	ANEXO A – MINI EXAME DE ESTADO MENTAL (MEEM)	113
	ANEXO B – INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK-II (BDI-II).....	114
	ANEXO C – ESCALA DE ANSIEDADE DE HAMILTON	116
	ANEXO D – WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE” – BREF (WHOQOL – BREF)	118

1 APRESENTAÇÃO

O envelhecimento é um processo natural o qual todo ser humano está sujeito. Existem inúmeras teorias sobre porque e como ocorre. Inerentemente complexo, o envelhecimento é caracterizado por inúmeras alterações anatomofisiológicas que se dão em diferentes níveis da hierarquia biológica, compondo uma série de mudanças moleculares e celulares, de múltiplos tecidos (Amorim, *et al.*, 2022; Da Costa, *et al.*, 2016).

O envelhecimento tem sido atribuído a ligações cruzadas moleculares (Bjorksten, 1968), danos induzidos por radicais livres (Harman, 1993), alterações nas funções imunológicas (Effros, 2005), encurtamento dos telômeros (Kruk *et al.*, 1995) e a presença de genes de senescência no DNA (Warner *et al.*, 1987). Mais recentemente, no entanto, uma teoria unificada abrangendo genes, desempenho de manutenção genética e sistemas de reparo está se tornando cada vez mais aceita (Rattan, 2006). (Da Costa, *et al.*, 2016)

Ao longo do tempo, diversas teorias surgiram visando melhor explicar esse processo. Recentemente, a teoria do desenvolvimento ao longo da vida (*Life-Span*), proposta por Paul Baltes, tem sido amplamente utilizada como referencial teórico em pesquisas científicas sobre envelhecimento, ao conceber esse processo como multidimensional, plástico e influenciado por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Essa abordagem sustenta que o envelhecimento envolve simultaneamente ganhos e perdas, sendo possível a manutenção e até o aprimoramento de determinadas capacidades por meio de estratégias adaptativas, como o modelo de Seleção, Otimização e Compensação (SOC). Estudos empíricos indicam que a adoção dessas estratégias está associada a melhores desfechos em funcionalidade, cognição e bem-estar subjetivo em pessoas idosas, reforçando a importância de intervenções que estimulem a adaptação ativa ao longo da vida (Baltes & Baltes, 1990; Freund & Baltes, 2002; Martin *et al.*, 2015). Nesse contexto, a teoria *Life-Span* fornece uma base conceitual robusta para investigações que buscam compreender os determinantes do envelhecimento saudável e subsidiar práticas de promoção da saúde voltadas à população idosa.

De acordo com o censo demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 14,7% da população brasileira é idosa, perfazendo um total de 31,2 milhões de indivíduos acima de 60 anos no país. Segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros atualmente é de 73,3 anos, podendo ser aumentada ou diminuída de acordo com os aspectos biopsicossociais pertinentes a cada indivíduo (IBGE, 2022).

Nesta perspectiva, o termo “Saúde” foi definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como sendo “*o estado de pleno bem estar físico, psíquico e social e não a ausência de doença*” (Organização Mundial de Saúde, 1947). Desta forma, a saúde deve ser contemplada por meio de uma perspectiva holística e de abordagem interdisciplinar. Diante desta perspectiva, o modelo biopsicossocial visa oferecer assistência de uma forma holística, não apenas concentrando-se no tratamento de doenças, mas no cuidado integral ao indivíduo (De Marco, *et al*, 2003).

Mendes (1966, p 237), definiu saúde como sendo o resultado de um processo de produção social que expressa a Qualidade de Vida (QV) como uma condição de existência humana, no seu viver cotidiano, individual ou coletivamente. Tal definição aborda as dimensões subjetivas que permeiam à saúde, indo de encontro aos modelos estritamente curativistas vigentes da época, que abordavam a saúde apenas por meio da presença ou ausência de doenças. Neste âmbito, o Modelo Biopsicossocial, propõe ações integrativas e interdisciplinares, contemplando o ser humano para além do biológico (OMS, 2020).

Diante desta perspectiva, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), publicada pela OMS em 2001, proporcionou uma linguagem unificada e padronizada, que permite identificar as dimensões que afetam a QV e que definem o estado de saúde das pessoas, possibilitando classificar o estado de saúde não apenas a partir da doença, mas, melhor definindo as consequências da doença, do contexto e das condições de vida, sendo, portanto, um passo crucial para a concretização de um novo paradigma da saúde da pessoa idosa, ao elucidar os múltiplos processos que acompanham o envelhecimento (OMS, 2020; Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS, 2020).

Ademais, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem como finalidade primordial recuperar, manter e promover a autonomia e a independência das pessoas idosas, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL-Ministério da Saúde, 2006).

É importante ressaltar que os Determinantes Sociais em Saúde (DSS), que se referem à um conjunto de acontecimentos, fatos, situações e/ou comportamentos da vida econômica, social, ambiental, política, governamental, cultural e subjetiva de cada indivíduo, são de fundamental importância para o entendimento e elaboração de estratégias de atuação na saúde e melhora da QV da pessoa idosa, pois afetam positiva ou

negativamente a saúde individual, de segmentos sociais, populações e/ou territórios (OMS, 2021).

“Os DSS são determinantes estruturais e condições da vida cotidiana responsáveis pela maior parte das iniquidades em saúde entre os países e internamente. Eles incluem distribuição de poder, renda, bens e serviços e as condições de vida das pessoas, e o seu acesso ao cuidado à saúde, escolas e educação; suas condições de trabalho e lazer; e o estado de sua moradia e ambiente” (OMS, 2021)

Um outro aspecto intimamente relacionado com a percepção de QV na pessoa idosa é a funcionalidade/capacidade funcional, na qual observa-se o conceito de Capacidade Intrínseca (CI) proposto em 2015 pela OMS, no intuito de delinear e compreender o que determina o envelhecimento saudável. Na pessoa idosa, a CI é definida como sendo a combinação da capacidade física e mental, favorecida ou não pelo contexto o qual o indivíduo está inserido - à saber, os DSS (OMS, 2015; OMS, 2020; OPAS, 2020). Os principais domínios da CI de uma pessoa referem-se à capacidade locomotora; vitalidade; capacidade psicológica; capacidade cognitiva; capacidade auditiva; e capacidade visual. (OPAS, 2020)

A capacidade locomotora diz respeito à capacidade física da pessoa de locomover-se de um lugar ao outro. A partir da Política Nacional de Saúde de 2019 estima-se que no Brasil cerca de 34,7% das pessoas idosas possuem dificuldade permanente de caminhar ou subir degraus, sendo que apenas 6,7% utilizam ou têm acesso a algum aparelho auxiliar (como cadeira de rodas, próteses ou órteses e bengalas ou muletas) (OPAS, 2020). Uma importante causa de limitações físicas é a perda de massa muscular esquelética relacionada à idade - sarcopenia. Além disso, estudos sugerem que a coordenação motora, o acoplamento excitação-contração, a integridade esquelética e outros fatores relacionados aos sistemas nervoso e musculoesquelético são criticamente importantes para o desempenho físico em pessoas idosas (Tieland, Trouwborst e Clark, 2017).

A vitalidade diz respeito aos fatores fisiológicos do indivíduo que podem levar à perda de CI (OPAS, 2020). A capacidade psicológica por sua vez, está fortemente atrelada aos outros domínios da CI, uma vez que a perda da habilidade funcional muitas vezes contribui para a manifestação de sintomas depressivos e/ou ansiedade e vice-versa. As capacidades auditiva e visual referem-se ao pleno funcionamento dos sistemas auditivo, vestibular e visual. Ademais, a capacidade cognitiva está ligada à memória e à capacidade de concentração e resolução de problemas, resumindo-se às funções mentais superiores (OPAS, 2020).

Quanto à cognição na pessoa idosa, compreende um conjunto de funções mentais superiores, incluindo memória, atenção, linguagem, funções executivas e velocidade de processamento, que podem apresentar mudanças ao longo do envelhecimento, tanto em condições normais quanto patológicas (Harada et al., 2013). Estudos recentes indicam que o envelhecimento cognitivo está associado a alterações neurobiológicas, como redução da plasticidade sináptica, mudanças estruturais cerebrais e processos neuroinflamatórios, os quais contribuem para o declínio cognitivo progressivo e heterogêneo entre indivíduos (Hou et al., 2019; Livingston et al., 2020). Entretanto, evidências sugerem que fatores modificáveis, como atividade física, engajamento social, estimulação cognitiva e participação em atividades culturais e artísticas, podem atuar como fatores protetores, favorecendo a manutenção das funções cognitivas e retardando o aparecimento de demências (WHO, 2020; Livingston et al., 2020). Dessa forma, a cognição constitui um componente central da funcionalidade e da qualidade de vida na pessoa idosa, influenciando diretamente a autonomia, a participação social e o bem-estar psicossocial.

No que concerne à saúde psicológica, três aspectos do bem-estar subjetivo podem ser distinguidos: bem-estar avaliativo (ou satisfação com a vida), bem-estar hedônico (sentimentos de felicidade, tristeza, raiva, estresse e dor) e bem-estar eudemônico (senso de propósito e significado na vida) (Steptoe, Deaton e Stone, 2015). A *Gallup World Poll*, uma pesquisa contínua em mais de 160 países, elucidou uma relação em forma de U entre o bem-estar avaliativo e a idade em países de alta renda de língua inglesa, com os níveis mais baixos de bem-estar nas idades de 45 a 54 anos; os entrevistados da América Latina apresentaram diminuição do bem-estar com a idade. Pessoas idosas com problemas de saúde, como afecções cardíacas, artrite e doença pulmonar crônica mostraram níveis aumentados de humor deprimido e bem-estar hedônico e eudemônico prejudicado (Steptoe, Deaton e Stone, 2015).

Estudos prévios alertaram que dentre as maiores preocupações das pessoas idosas ativas, estão a solidão e o esquecimento diário, sugerindo que os transtornos afetivos e depressivos têm um impacto negativo na QV desta população (Hussenoeder, et al, 2020). De igual modo, a interação e o apoio social estão relacionados à satisfação com a vida e ao bem-estar físico e mental (Marsillas, et al, 2017), e que as relações sociais adequadas podem determinar o sucesso pessoal associado à felicidade e QV (Lés, et al, 2019; Leon, Mangin e Ballesteros, 2020; Gargaccio, et al, 2022).

Ademais, os Modelos Multidimensionais Globais de Envelhecimento Ativo fazem uso de modelos distintos, tais como: QV, cognição, saúde mental e autoavaliação da saúde física; saúde física, suporte social, saúde psicológica e a prática de atividades de lazer; ambientes favoráveis ao envelhecimento, dentre outros (Hsu, 2020; Gargaccio, *et al*, 2022). Desta forma, as atividades de cunho artístico e cultural (música, arte, dança, etc) tem sido foco de estudos podendo configurar-se como uma estratégia não farmacológica que promove bem estar, convívio social, melhora nos aspectos cognitivos, emocionais e funcionais na pessoa idosa.

Diante do exposto, esta pesquisa apresenta seu foco no Envelhecimento e Qualidade de Vida em pessoas idosas, trazendo aspectos da Funcionalidade, Cognição e Estado emocional nesta população, estabelecendo uma correlação entre os resultados encontrados e a prática de atividades de cunho artístico e cultural como um aspecto que, possivelmente, modula a QV nesta população.

Ademais, a Psicologia da Saúde apresenta seu foco no estilo de vida das pessoas, no processo saúde/doença, buscando compreender o papel das variáveis psicológicas sobre a manutenção da saúde, o desenvolvimento de doenças e comportamentos associados à elas (Ribeiro, 2011). Portanto, a Psicologia da Saúde é o fundamento sob o qual esta pesquisa está alicerçada, a qual aborda a integração social, a neuroplasticidade positiva - funcional e cognitiva, e atividade e participação, gerados por meio do envolvimento dos participantes da pesquisa em atividades de cunho Artístico-Cultural.

Diante deste cenário justifica-se a importância da realização desta pesquisa para analisar as variáveis do comportamento motor, por meio da avaliação de funcionalidade, das funções mentais superiores, através da análise do perfil cognitivo, além do estado emocional, por meio de um rastreio de sintomas de Depressão e Ansiedade e como estas variáveis reverberam na QV dos participantes da pesquisa, podendo favorecer a aplicação de Políticas Públicas em Saúde neste domínio e contribuir para o arcabouço científico.

2 OBJETIVO GERAL

Analisar os aspectos biopsicossociais, funcionalidade, cognição e estado emocional e correlacionar com a percepção de qualidade de vida em pessoas idosas praticantes de atividades artísticas e culturais.

2.1 Objetivos Específicos

- Correlacionar cognição, funcionalidade e Qualidade de Vida em pessoas idosas;
- Correlacionar cognição, estado emocional e Qualidade de Vida em pessoas idosas.

3 HIPÓTESE

Pressupõe-se que exista associação significativa entre funcionalidade, cognição e estado emocional com a percepção de qualidade de vida em pessoas idosas, sendo essa relação positiva para funcionalidade e cognição e negativa para sintomas de ansiedade e depressão.

Ademais, hipotetiza-se que a participação em atividades artísticas e culturais esteja relacionada a melhores desfechos biopsicossociais e, conseqüentemente, a uma melhor percepção de qualidade de vida.

4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação de mestrado está estruturada em dois capítulos que abordarão os seguintes tópicos: I – O primeiro capítulo está alinhado ao primeiro objetivo específico listado acima, o qual investigará as associações entre Funcionalidade, Cognição e Qualidade de Vida em pessoas idosas; II – O segundo capítulo corresponde ao segundo objetivo específico da dissertação e investigará as associações entre a cognição, estado emocional e percepção da QV em pessoas idosas. O presente estudo pode não só apresentar as relações e influências que os aspectos biopsicossociais tem sob a QV da pessoa idosa, como também identificar potenciais não farmacológicos nas atividades artísticas desempenhadas pelos participantes, assim como nortear futuras intervenções neste domínio.

5 MANUSCRITO 1

Ana Caroline Pereira da Silva MAMEDE ¹; Carlúcia Ithamar Fernandes FRANCO¹.

¹ *Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde (PPGPS) - Universidade Estadual da Paraíba, 351 Baraúnas St., Bodocongó, Campina Grande-PB, 58429-500, BR*

Corresponding author: acpsilva02@gmail.com/ ana.caroline.silva@aluno.uepb.edu.br

ENTRE NOTAS E TONS: COGNIÇÃO, FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS IDOSAS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

RESUMO

O envelhecimento populacional brasileiro tem avançado de maneira acelerada, demandando estratégias capazes de promover saúde, autonomia e bem-estar entre pessoas idosas. Este estudo teve como objetivo analisar as correlações entre funcionalidade e cognição e a percepção de qualidade de vida (QV) em pessoas idosas participantes de atividades artístico-culturais. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, de delineamento transversal, realizada com 39 pessoas idosas participantes de oficinas de dança e de instrumentos no CAC-Procult/UEPB. Foram utilizados os seguintes instrumentos: *Checklist* da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) adaptada, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) e o *WHOQOL-BREF*. A amostra foi composta majoritariamente por mulheres, com média de idade de 70,7 anos com presença significativa de doenças crônicas. Observou-se elevada prevalência de fragilidade e pré-fragilidade, bem como desempenho cognitivo abaixo do ponto de corte esperado para a escolaridade. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre as modalidades artísticas quanto aos escores de cognição, funcionalidade e QV. A análise de correlação indicou ausência de associação significativa entre cognição e QV, enquanto a fragilidade funcional apresentou correlação negativa moderada com a QV. A análise multivariada demonstrou que a QV foi o principal fator explicativo da variabilidade dos dados. Após análise dos resultados, sugere-se que as atividades artísticas investigadas configuram estratégias promissoras de engajamento social e promoção do bem-estar, sendo a fragilidade funcional o principal fator associado à pior percepção de qualidade de vida em pessoas idosas.

Palavras-chave: Envelhecimento; Qualidade de Vida; Cognição; Funcionalidade; Saúde.

ABSTRACT

Population aging in Brazil has advanced rapidly, demanding strategies to promote health, autonomy, and well-being among older adults. This study aimed to analyze the correlations between functionality, cognition, and perceived quality of life (QoL) in older adults participating in artistic and cultural activities. This is a cross-sectional study with

a mixed-methods (qualitative and quantitative) approach, conducted with 39 older adults engaged in dance and musical instrument workshops at CAC-Procult/UEPB. The following instruments were used: the adapted International Classification of Functioning Checklist (ICF Checklist), the Mini-Mental State Examination (MMSE), the Clinical-Functional Vulnerability Index (CFVI-20), and the World Health Organization Quality of Life – Bref (WHOQOL-BREF). The sample consisted predominantly of women, with a mean age of 70.7 years and a significant presence of chronic conditions. A high prevalence of frailty and pre-frailty was observed, as well as cognitive performance below the expected cutoff for educational level. No statistically significant differences were found between artistic modalities regarding cognition, functionality, and QoL scores. Correlation analysis indicated no significant association between cognition and QoL, whereas functional frailty showed a moderate negative correlation with QoL. Multivariate analysis revealed QoL as the main factor explaining data variability. These findings suggest that the investigated artistic activities are promising strategies for social engagement and well-being promotion, with functional frailty being the primary factor associated with poorer quality of life perception in older adults.

Keywords: Aging; Quality of life; Cognition; Functionality; health.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, diversos estudos têm demonstrado que o comportamento e o estilo de vida dos indivíduos, especialmente, quando considerados dentro do contexto sociocultural em que estão inseridos, exercem impacto significativo sobre o desenvolvimento e/ou agravamento de diversas doenças (Ribeiro, 2011). Nesse contexto, a Psicologia da Saúde tem se dedicado a compreender de que forma fatores intrínsecos (biológicos e psicológicos) e extrínsecos (ambientais e sociais) influenciam o processo saúde-doença.

O envelhecimento, por sua vez, é caracterizado pela redução progressiva da reserva funcional dos diversos sistemas fisiológicos, comprometendo a capacidade do organismo em manter a homeostase diante de estressores internos ou externos. Essa limitação adaptativa contribui para o declínio do desempenho físico e pode favorecer o surgimento de alterações cognitivas, aumentando a vulnerabilidade funcional e psicossocial da pessoa idosa (Chagas e Rocha, 2012).

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, observa-se um crescimento expressivo da população idosa, acompanhado do aumento da expectativa de vida (IBGE, 2022). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2025, a população mundial de pessoas com 60 anos ou mais já ultrapassa 1,1 bilhão, e deve alcançar 1,4 bilhão em 2030, sendo que entre 2015 e 2050, a proporção de pessoas com 60+ deve praticamente dobrar, passando de cerca de 12% para 22% da população mundial. Diante deste cenário, é fundamental analisar as condições nas quais esse envelhecimento populacional ocorre. No que concerne o cenário brasileiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo Demográfico de 2022, a população brasileira com 60 anos ou mais perfaz 15,6% da população total, destes 55,7% eram mulheres e 44,3% eram homens.

Observa-se que em países desenvolvidos, o processo de envelhecimento tende a se dar de forma gradual, geralmente associado à ampliação do acesso à saúde, melhorias na infraestrutura habitacional, saneamento básico, condições de trabalho e segurança alimentar. No Brasil, o envelhecimento populacional acontece em meio a um cenário de profundas desigualdades sociais, instabilidade econômica, acesso limitado a serviços de saúde e aumento dos índices de pobreza, o que compromete significativamente a Qualidade de Vida (QV) dessa população (IBGE, 2022; OPAS, 2020).

Neste aspecto, a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) foi definida como sendo a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais está inserido, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (OMS, 2020). Para que haja uma QVRS satisfatória, é necessário que o indivíduo experimente bem-estar físico, psicológico e social. Nessa perspectiva, aspectos como funcionalidade e desempenho cognitivo exercem papel central, influenciando diretamente nesta percepção.

A Funcionalidade consiste na capacidade do indivíduo de realizar, de maneira autônoma e independente, atividades essenciais para a manutenção da vida cotidiana, tais como mobilidade, autocuidado, comunicação e interação social. No contexto do envelhecimento, a preservação da funcionalidade é um dos principais determinantes da QV e da manutenção da independência na pessoa idosa (World Health Organization [WHO], 2015). Entre os componentes fisiológicos que sustentam essa funcionalidade, a força muscular desempenha um papel central. Evidências científicas indicam que a força muscular, particularmente a força de membros inferiores, está fortemente associada à capacidade de marcha, equilíbrio postural e prevenção de quedas em pessoas idosas (Cruz-Jentoft *et al.*, 2019).

No processo de envelhecimento observa-se a sarcopenia, que consiste na perda natural da massa e da força muscular, afetando aproximadamente 10% a 27% desta população (Bahat & Cruz-Jentoft, 2021). A sarcopenia está intimamente relacionada ao declínio funcional, comprometendo a realização de atividades básicas da vida diária (ABVDs) e aumento do risco de dependência, institucionalização e mortalidade precoce (Dhillon e Hasni, 2017).

O declínio funcional, portanto, é um processo multifatorial que resulta da interação entre alterações fisiológicas, presença de comorbidades crônicas e fatores psicossociais. Esse processo torna a pessoa idosa progressivamente mais vulnerável à perda da autonomia e à dependência de cuidados, impactando negativamente o bem-estar físico, emocional e social, além de reduzir significativamente, sua QV (Oliveira *et al.*, 2019; WHO, 2020). Barbosa, *et al.*, (2022) postularam que mesmo pessoas idosas, que detêm autonomia e independência, podem apresentar comprometimento na capacidade funcional e experimentar declínios importantes a partir de diferentes eventos, tais como quedas, descompensação de doenças crônicas, infecções, entre outras.

Neste sentido, o Ministério da Saúde propõe a estratificação da funcionalidade na população idosa em três categorias: pessoas idosas independentes e autônomas para a realização das ABVDs; pessoas idosas com necessidade de adaptação ou supervisão para a realização das ABVDs e pessoas idosas dependentes para a realização das ABVDs (Ministério da Saúde, 2018). Conforme se dá o processo de envelhecimento fisiológico, há uma tendência à diminuição da capacidade funcional e cognitiva do indivíduo, que pode ser impulsionada por fatores genéticos, culturais, econômicos, além de seus hábitos de vida, escolaridade e a presença de doenças (Barbosa, *et al.*, 2022).

O declínio cognitivo, por sua vez, é um distúrbio progressivo frequentemente associado ao processo de envelhecimento, caracterizando-se por prejuízos em funções mentais superiores, tais como memória, atenção, linguagem, raciocínio e tomada de decisão (Wu et al., 2021). Embora algumas alterações cognitivas possam ser consideradas parte do envelhecimento fisiológico, o comprometimento cognitivo em estágios mais avançados, as demências, representam condições que afetam significativamente a funcionalidade e a autonomia da pessoa idosa (Charchat-Fichman, *et al.*, 2005).

Estudos mostraram que o declínio cognitivo está fortemente associado ao aumento da dependência funcional, pois interfere na capacidade da pessoa idosa de planejar, executar e controlar as ABVDs, incluindo o manejo de medicamentos, finanças e cuidados pessoais (Petersen *et al.*, 2018). O comprometimento cognitivo está relacionado a um maior risco de quedas, hospitalizações e mortalidade, sendo, portanto, um importante marcador de fragilidade no envelhecimento (Livingston *et al.*, 2020).

A qualidade de vida na pessoa idosa, por sua vez, é um constructo multidimensional que engloba a percepção subjetiva do indivíduo sobre sua posição na vida, considerando fatores físicos, psicológicos, sociais, ambientais e culturais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida está diretamente relacionada ao contexto sociocultural e aos valores individuais, sendo influenciada por condições de saúde, autonomia funcional, suporte social, participação social e bem-estar emocional. Estudos recentes indicam que a qualidade de vida na pessoa idosa está associada à manutenção da funcionalidade, ao engajamento em atividades significativas, à participação social e à presença de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo (Steptoe et al., 2015; León et al., 2020). Além disso, intervenções baseadas em atividades físicas, cognitivas e culturais têm demonstrado impacto positivo na percepção de bem-estar e satisfação com a vida, contribuindo para a promoção da saúde e a prevenção de incapacidades na população idosa (Leś et al., 2019).

Diante do avanço do envelhecimento populacional e de seus impactos na funcionalidade e cognição, a detecção precoce e o manejo adequado do declínio funcional e cognitivo tornam-se estratégias fundamentais para mitigar os efeitos negativos associados, promovendo um envelhecimento ativo, saudável e melhor percepção da QV na pessoa idosa. Neste contexto, abordagens não farmacológicas têm ganhado destaque na literatura, especialmente, aquelas voltadas ao estímulo cognitivo, físico, emocional e social, como as atividades artísticas e culturais.

As intervenções de cunho artístico e cultural, tais como, dança, teatro, música, pintura, e etc, têm demonstrado benefícios significativos na promoção da saúde física e mental, na preservação da autonomia e no fortalecimento dos vínculos sociais em populações idosas (Noice *et al.*, 2014; Fancourt & Finn, 2019), constituem, portanto, elementos essenciais na formação da identidade individual e coletiva, sendo também poderosos instrumentos de promoção da saúde e bem-estar.

Evidências mostraram que a participação em atividades artísticas pode reduzir sintomas depressivos, melhorar a autoestima e o desempenho cognitivo, além de ampliar o senso de propósito e pertencimento social entre pessoas idosas (Fancourt *et al.*, 2020; Camic *et al.*, 2021). Tais práticas, ao integrarem os domínios físicos, emocionais e culturais da experiência humana, favorecem uma abordagem holística no cuidado à pessoa idosa, especialmente, em contextos de prevenção e reabilitação.

Desta forma, as práticas artísticas e culturais devem ser reconhecidas como estratégias complementares ao cuidado em saúde, com potencial para promover não apenas a reabilitação funcional e cognitiva, mas também a valorização da história de vida e da subjetividade da pessoa idosa, uma vez que a participação é um dos três pilares da estrutura política da OMS para uma sociedade de envelhecimento ativo (Fu, Li e Mao, 2018).

Portanto, observa-se que as atividades artísticas e culturais promovem benefícios na cognição, funcionalidade e melhoram a percepção de qualidade de vida em pessoas idosas, devido à sua influência positiva na plasticidade cerebral. Desta forma, observa-se a importância e a necessidade da realização desta pesquisa, para melhor compreender os aspectos da funcionalidade e cognição das pessoas idosas que participam de modalidades artísticas e culturais, a saber dança e prática de instrumentos musicais como encontra-se a percepção de QV dessas pessoas idosas, podendo estabelecer uma relação entre funcionalidade, cognição e percepção de qualidade de vida.

Ressalta-se que a realização de pesquisas dessa natureza contribui para a compreensão e consolidação de estratégias acessíveis e eficazes voltadas à promoção do envelhecimento saudável. Ademais, tais estudos evidenciam e valorizam o papel de espaços que desenvolvem atividades artístico-culturais, como centros artísticos e culturais comunitários, ampliando não apenas sua relevância científica, mas também social. Esses ambientes configuram-se como importantes cenários de promoção de saúde, inclusão e participação social, ao mesmo tempo em que reconhecem e valorizam as trajetórias de vida das pessoas idosas e a memória coletiva desses espaços.

OBJETIVOS

Geral

Investigar os aspectos biopsicossociais: Funcionalidade, Cognição e a percepção da qualidade de vida em pessoas idosas participantes de atividades artístico-culturais.

Específicos

- Caracterizar as informações sociodemográficas e situação de saúde;
- Investigar o nível da Funcionalidade; o perfil cognitivo; percepção de QV;
- Avaliar a correlação entre a Funcionalidade e Cognição *versus* QV;

METODOLOGIA

Tipo de Pesquisa

Esta pesquisa foi realizada segundo uma abordagem qualiquantitativa, através de estudo transversal, populacional.

Delimitação dos Participantes da Pesquisa

A amostra foi não probabilística, dada por acessibilidade (Setia, 2016; Andrade, 2021) e composta por pessoas idosas participantes de Atividades Artístico-Culturais do CAC da ProCult/UEPB, compondo um total de 39 participantes.

“O pesquisador recruta os participantes que são facilmente acessíveis em um ambiente clínico (...). Além disso, em tal ambiente clínico, o pesquisador abordará todos os pacientes que encontrar. Eles são informados sobre o estudo e todos aqueles que consentiram em participar do estudo são avaliados quanto à elegibilidade. Se eles atenderem aos critérios de inclusão (e não precisarem ser excluídos de acordo com os critérios), eles serão recrutados para o estudo.” (SETIA, 2016)

CrITÉRIOS de Inclusão

- Indivíduos com 60 anos ou mais, do sexo masculino e do sexo feminino;
- Participantes de atividades artístico-culturais do CAC/UEPB;

CrITÉRIOS de Exclusão

Foram excluídos pessoas idosas que apresentarem os seguintes aspectos:

- Disfunção visual, auditiva, linguagem, cognitiva e/ ou funcional que impedíssem a realização dos instrumentos;
- Patologias psiquiátricas associadas que impedíssem a realização dos instrumentos.

Local de Realização da Pesquisa

Foi realizada na sede do Centro Artístico Cultural (CAC) da ProCult/UEPB, na Avenida Getúlio Vargas, Nº44, Centro de Campina Grande/PB.

O Centro Artístico e Cultural da Universidade Estadual da Paraíba (CAC/UEPB), criado em 2004, configura-se como um importante espaço de promoção da cultura, da educação e da inclusão social, articulando atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à comunidade acadêmica e à população em geral. Por meio da oferta de oficinas, cursos e projetos nas áreas de música, dança, teatro e artes visuais, favorece o acesso democrático à produção artística e estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas, funcionais e socioemocionais.

Destaca-se, ainda, seu papel na promoção do envelhecimento ativo, ao proporcionar às pessoas idosas oportunidades de participação social, expressão cultural e fortalecimento de vínculos, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dessa população.

Instrumentos de Coleta de Dados

Para realização da Pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos:

- *Checklist da CIF – Adaptada*; Trata-se de uma *Checklist* das categorias principais da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde. Consiste de uma ferramenta prática para extrair e registrar informação sobre a funcionalidade e a incapacidade de um indivíduo. Foi utilizado nesta pesquisa as partes da *Checklist* que referem-se à Informação Sociodemográfica e Situação de Saúde (*Checklist* da CIF © OMS, Setembro 2003) (Apêndice 1).
- *Mini Exame de Estado Mental (MEEM)* – Teste de triagem amplamente utilizado para avaliar a função cognitiva por ser rápido, de fácil aplicação, não requerendo material específico. Avalia os seguintes domínios: orientação espacial, temporal, memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho. O MEEM é um somatório de pontos de 7 categorias que podem variar de 0 a 30, sendo os maiores escores relacionados a melhores desempenhos cognitivos (pontos de corte para esta pesquisa: 20 pontos para aletrados; 25 pontos para idosos com um a quatro anos de estudo; 26,5 pontos para idosos com cinco a oito anos de estudo; 28 pontos para aqueles com 9 a 11 anos de estudo 29 pontos para aqueles com mais de 11 anos de estudo - Brucki *et al*, 2003) (Fostein et al. 1975). (Anexo 1)

- *Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20)* - Desenvolvido para identificar rapidamente pessoas idosas frágeis ou em risco de fragilidade no contexto da atenção primária à saúde no Brasil. Consiste em 20 questões que avaliam múltiplos domínios, como cognição, humor, mobilidade, comunicação, comorbidades e suporte social. O estudo de validação do IVCF-20 demonstrou alta correlação com a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), considerada padrão-ouro na identificação de fragilidade, além de apresentar elevada confiabilidade e consistência interna. (Moraes, et al, 2016) (Apêndice 2)
- *World Health Organization Quality of Life” – BREF (WHOQOL – BREF)* - Trata-se da versão abreviada do instrumento de avaliação de qualidade de vida desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Composto por 26 itens, ele abrange quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. (Fleck et al, 2000 - Referência da versão validada para o Brasil) (Anexo 3).

Procedimentos de Coleta de Dados

Visando melhor organização das atividades a serem executadas na pesquisa, o procedimento de coleta de dados foi dividido em quatro etapas:

- Etapa I: Apresentação da Pesquisa e assinatura do Termo de Autorização Institucional para Uso e Coleta de Dados em Arquivos (TAICDA) por parte da Coordenadora do CAC da PROCULT/UEPB. Seguindo, a equipe, teve acesso a lista de matriculados no CAC com a obtenção dos contatos de email e/ou telefone. Dando continuidade, foi realizada a apresentação da pesquisa aos pessoas idosas praticantes de atividades artísticas culturais do CAC e a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
- Etapa II: Após anuência ao TCLE foram aplicados os instrumentos: *Checklist* da CIF–Adaptado (Informação Socioemográfica e Situação de Saúde); Mini Exame de Estado Mental (MEEM).
- Etapa III: Aplicação do instrumento IVCF-20;
- Etapa IV: Aplicação do instrumento *World Health Organization Quality of Life” – Bref (WHOQOL – BREF)* .

Análise dos Dados

Os dados obtidos foram analisados por meio da Estatística Descritiva. As variáveis qualitativas nominais foram expressas em frequência e porcentagem e apresentadas por meio de gráficos e tabelas; as variáveis qualitativas ordinais foram apresentadas através de porcentagem e mediana, apresentadas por meio de gráficos e Boxplot, respectivamente; para as variáveis quantitativas contínuas foi feito a média, desvio padrão e erro padrão da média; por fim, as variáveis quantitativas discretas foram analisadas por meio do teste ANOVA e Teste de Médias. Para as análises específicas foram feitas análises multivariadas e Análises fatoriais.

As análises quantitativas foram processados através do *Software* Estatístico *Palaeontological Statistics* (PaSt), versão 1.81 (HAMMER et al., 2008)

Aspectos Éticos da Pesquisa

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB (CEP-UEPB) e, qualquer coleta de dados só foi realizada mediante a aprovação do projeto por parte do CEP-UEPB. Os participantes receberam explicações a respeito do estudo e, ao concordarem com a participação, preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde/MS que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos informando e garantido a confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos.

O participante da pesquisa recebeu pessoalmente o TCLE e após preenchimento deste em concordância com a participação, incluído na pesquisa. O Registro de Aceite do TCLE foi fornecido mediante preenchimento de formulário nas salas de aulas do CAC/UEPB, a via do participante foi ofertada mediante cópia das respostas no momento seguinte em que respondeu ao formulário. Ressalta-se que o convite para participar da pesquisa foi individual e esclarecido ao candidato a participante de pesquisa, que antes de responder às perguntas do pesquisador, era necessário a sua anuência ao TCLE, desta forma o participante de pesquisa teve acesso às perguntas somente depois de dado o seu consentimento.

Tendo em vista que os dados (*Email/Telefone*) para acesso aos participantes foram adquiridos junto à Coordenação do CAC da PROCULT/UEPB, os pesquisadores responsáveis também garantiram a assinatura do Termo De Autorização Institucional Para Uso e Coleta De Dados Em Arquivos (TAICDA). Visando garantir a total confidencialidade dos contatos dos participantes, estes ficaram em posse apenas dos pesquisadores responsáveis, sem haver qualquer tipo de divulgação externa destes dados. É do conhecimento dos pesquisadores que o acesso não autorizado a essas informações caracteriza uma violação de dados, resultando em roubo de identidade ou violação de requisitos de conformidade frente ao governo ou a setores regulatórios.

Foi garantido ao participante de pesquisa o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo também se retirar da pesquisa a qualquer momento. Visando resguardar a confiabilidade dos participantes, os dados publicados serão com a utilização de um sistema de classificação alfanumérico (letras, números), não contendo nome dos participantes e a divulgação dos resultados será feita em eventos e/o publicações.

Foi assinado, o Termo de Compromisso do Pesquisador Responsável, em que o mesmo assume cumprir fielmente as diretrizes regulamentadoras emanadas das Resoluções Nº 466/12 e No 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, ao (s) sujeito(s) da pesquisa e do Estado.

O pesquisador responsável também assinou a Declaração de Concordância com Projeto de Pesquisa, em que compromete-se verificar o desenvolvimento do projeto e cumprir os itens dispostos na Resolução Nº466 sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos. Quanto à autorização do local para realização da pesquisa, foi assinado o Termo de Autorização Institucional (TAI) pelo (a) responsável pela PROCULT/UEPB, além da assinatura do Termo de Autorização Institucional para Uso e Coleta de Dados em Arquivos (TAICDA) por parte da Coordenadora do CAC da PROCULT/UEPB.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Caracterização das Informações Sociodemográficas Através da *Checklist* da CIF Adaptada em pessoas idosas participantes de Atividades Artísticas Culturais

Após análise dos dados, verificou-se que participaram da pesquisa 39 pessoas idosas, os quais, após serem esclarecidos acerca do estudo e anuência ao TCLE, responderam a *Cheklis*t da CIF-Adaptada, que contemplou as características sociodemográficas e situação de saúde. A prevalência foi de mulheres, com predominância de brancos, conforme **Tabela 1**. Esses resultados corroboram com os dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2023) acerca da feminização do envelhecimento, uma vez que as mulheres formam a maioria da população idosa e as estimativas apontam que elas vivem, em média, de cinco a sete anos a mais que os homens. No total das pessoas com 60 anos ou mais no Brasil, 56% são mulheres (17,8 milhões) e 44% são homens (14,2 milhões), conforme os dados do Censo de 2022 (IBGE, 2022).

Os participantes da pesquisa foram agrupados em duas modalidades de atividades artístico-culturais, a saber, dança e instrumentos musicais. Dentre aqueles que praticavam dança, 6,9% eram do sexo masculino e 93,1% do sexo feminino; dentre os que praticavam instrumentos musicais, 20% eram do sexo masculino, enquanto 80% do sexo feminino.

Tabela 1 *Características das Informações Sociodemográficas*

Variável	Categoria	Frequência (n)	(%)
Sexo	Feminino	35	89,74
	Masculino	4	10,26
Cor	Branca	22	56,41
	Parda	17	43,59
Moradia	Própria	32	82,05
	Alugada	7	17,95

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

No que diz respeito a moradia, observou-se que a maior parte dos participantes da pesquisa possui moradia própria, compondo 82,05 % da população estudada, o que reflete um ponto positivo no que refere-se aos Determinantes Sociais em Saúde (DSS). Santos *et al* (2024), avaliaram múltiplas dimensões da insegurança habitacional — custo do aluguel (sobrecarga), deslocamento forçado por aumento de aluguel, estabilidade da moradia (mudanças frequentes/tenure), e condições do entorno (violência, poluição) — e associam esses fatores (DSS) a desfechos de saúde em idosos (qualidade de vida, solidão, cognição e sono) e destaca explicitamente a vulnerabilidade de idosos locatários com renda fixa frente a despesas de moradia crescentes.

A média de idade das pessoas idosas foi de 70,71 anos, porém é importante salientar que houveram indivíduos com idades entre 60 e 88 anos. A mediana se deu em 69,5 e o desvio padrão sendo $s=7,093$. Dentre os que praticavam Dança, a média de idade foi de 70,8 anos; para aqueles que praticavam instrumentos musicais a média de idade ficou em 69,7. Thiel *et al* (2024) realizaram um ensaio clínico randomizado com 55 indivíduos com Comprometimento Cognitivo Leve através de uma intervenção de dança esportiva, onde a média de idade foi de 70,7 e 62% dos participantes sendo mulheres. Neste aspecto os dados encontrados nesta pesquisa corroboram com Thiel *et al* (2024) no que diz respeito a idade e participação maior do público feminino.

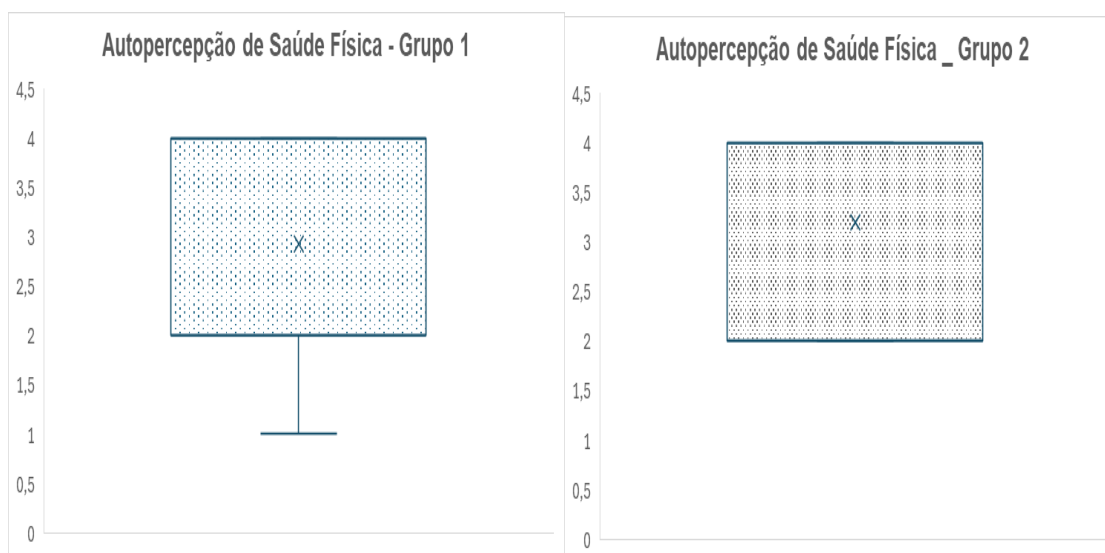
Situação de Saúde através da Checklist da CIF-Adaptada

Para as etapas subsequentes da análise dos dados, os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos, Grupo 1: Dança - formado por pessoas idosas que faziam alguma modalidade de dança como atividade artística; Grupo 2: Instrumentos Musicais - composto pelos pessoas idosas que participavam de alguma aula de aprendizado e prática de instrumentos musicais. O Grupo 1 (Dança) foi composto por 29 pessoas idosas; enquanto que o Grupo 2 (Instrumentos Musicais) comportou 10 pessoas idosas que faziam aulas de violão (N=8) e/ou pandeiro (N=2).

No que concerne a percepção de saúde física (saúde do corpo), obtida através da *Checklist da CIF- Adaptada* (considerando os últimos 30 dias antes do dia da coleta dos dados), verificou-se que as pessoas idosas participantes do Grupo 2 (instrumentos musicais) apresentaram uma autopercepção da saúde física melhor em relação as pessoas idosas do Grupo 1 (Dança). Nota-se que os participantes do Grupo 2, mostraram valor de média de 3,2 estando entre moderada e boa percepção de saúde física, entretanto, os participantes do Grupo 1 apresentaram média de 2,93, configurando-se em uma percepção entre regular e moderada. Conforme observa-se no **Gráfico 1**.

Gráfico 1 *Análise da Autopercepção de Saúde*

(Referência dos últimos 30 dias antes da coleta dos dados)



Legenda: Ruim= 1/ Regular=2/ Moderada=3/ Boa=4/ Muito Boa=5)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

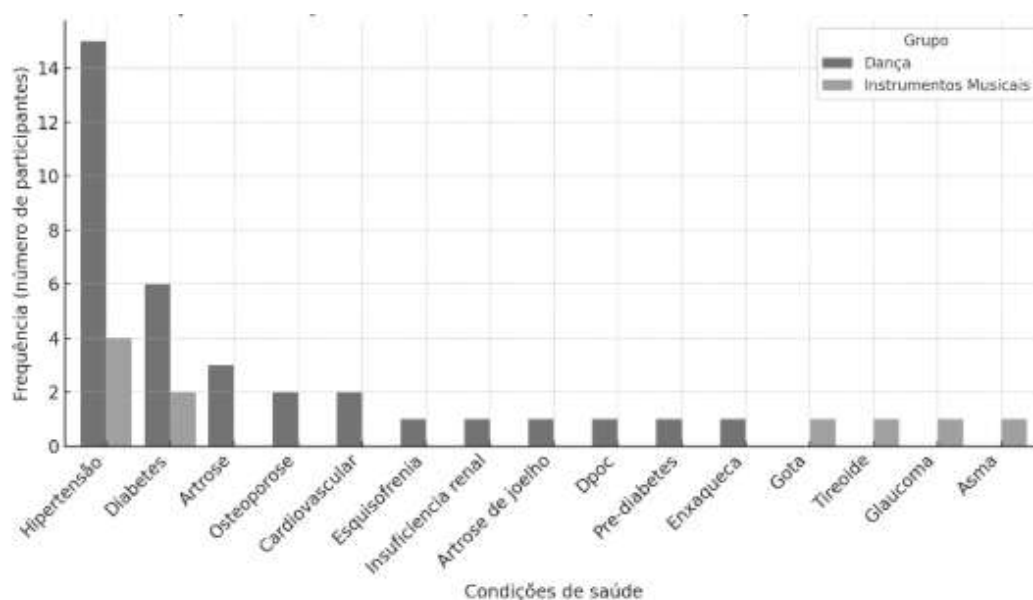
Nesta perspectiva, Ambegaonkar *et al* (2022), realizaram um ensaio clínico com pessoas idosas (>65 anos) comparando participantes de programas comunitários de dança, música (ukulele) e um grupo controle. Foram medidas a saúde física (“Short Physical Performance Battery¹”) e saúde mental antes, ao fim do programa e um mês depois. Todos os grupos melhoraram, mas não houve diferença significativa entre os grupos de dança e música em muitas medidas físicas, embora o grupo dança possa apresentar vantagens em alguns domínios funcionais.

¹ [Short Physical Performance Battery](#) (SPPB) é um teste que avalia a capacidade funcional e o desempenho físico de pessoas idosas, especialmente a força dos membros inferiores e o equilíbrio. Ele inclui três testes: equilíbrio estático, velocidade da marcha e sentar-levantar de uma cadeira, que são somados para gerar uma pontuação total que varia de 0 a 12. Uma pontuação mais baixa indica maior risco de quedas, declínio funcional e problemas em atividades da vida diária.

Da mesma forma, Kim *et al* (2025) revisaram sistematicamente o impacto de exercícios com música na saúde física e emocional de idosos frágeis que vivem na comunidade. Os autores concluíram que os exercícios realizados com música podem ajudar a melhorar a saúde física e emocional de idosos frágeis e potencialmente reduzir o impacto da fragilidade. Verifica-se diante de diferentes desfechos em relação aos benefícios do uso de música e dança como estratégias não farmacológicas que auxiliem na melhora da função física em pessoas idosas, são necessárias mais pesquisas rigorosas, com amplas amostras, para melhor assegurar os benefícios destas modalidades.

No que se refere especificamente à presença de doenças crônicas, a Hipertensão Arterial foi a doença com maior prevalência nos dois grupos (Grupo 1: 48,27%; Grupo 2: 40%) seguida pela Diabetes Mellitus (Grupo 1: 24,13%; Grupo 2: 20%) , conforme observa-se no Gráfico 2. A literatura é concisa no que diz respeito a co-ocorrência de múltiplas doenças crônicas, condição que está consistentemente associada à pior QV.

Gráfico 2 *Distribuição de condições de saúde*



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Wilk *et al*, 2023 analisaram a QV via escala CASP-12², relacionando multimorbidade e limitações funcionais com QV ao longo do tempo, concluindo que a presença de multimorbidade implica pior QV e maior risco de limitações funcionais, com efeitos variáveis conforme a faixa etária (50–64 vs. ≥ 65). De igual modo, Hodek, Ruhe e Greiner (2009) realizaram um estudo com 2.120 idosos (~76 anos), utilizando EQ-5D³ e SF-8⁴, demonstrando que a multimorbidade reduz significativamente a QV, especialmente nos domínios físicos. Doenças cardiovasculares, cerebrais, periféricas e musculoesqueléticas exerceram impacto mais severo

Determinantes Sociais em Saúde Através da Checklist da CIF – Adaptada

Quando questionados acerca da percepção de segurança alimentar, dado relevante no que concerne a fragilidade da pessoa idosa e os DSS, evidenciou-se que nas pessoas idosas do Grupo 1, a média foi de 3,24, ou seja, entre moderada e boa; no que concerne ao Grupo 2, os participantes apresentaram média de 3,6 ficando no mesmo intervalo do Grupo 1, porém sendo um pouco mais próximo de boa, enquanto o Grupo 1 encontra-se mais próximo de moderada, conforme observa-se no **Gráfico 3**.

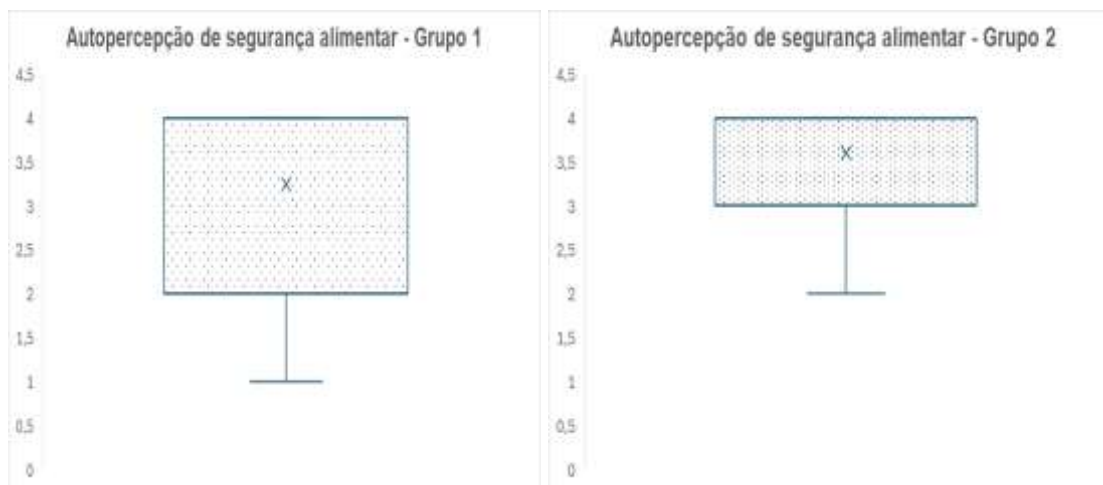
² A escala CASP-12 - versão curta do CASP-19 (Hyde, Wiggins, Higgs & Blane, 2003) - compreende quatro domínios: Controle, Autonomia, Auto-realização e Prazer. Esta escala de QV valoriza atitudes e comportamentos pró ativos e reflexivos e considera que as necessidades humanas constituem pré-requisitos da participação dos indivíduos na sociedade.

³ O EQ-5D (EuroQol 5 Dimensions) é um instrumento padronizado para medir a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e consiste em um sistema descritivo de cinco dimensões (mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor/desconforto, ansiedade/depressão) e uma Escala Visual Analógica (EQ-VAS), que capta a autoavaliação da saúde do respondente (Balestroni e Bertolotti, 2012)

⁴ [SF-8 \(Short Form-8\)](#) - é um questionário que avalia a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) dos indivíduos.

Gráfico 3 Auto Percepção de Segurança Alimentar

(Referência: Mínimo de 3 refeições diárias nos últimos 30 dias antes da coleta dos dados)



Legenda: Ruim= 1/ Regular=2/ Moderada=3/ Boa=4/ Muito Boa=5.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Pérez-Zepeda *et al.* (2016) classificaram segurança alimentar em quatro níveis: seguro, insegurança leve, moderada e grave e concluíram que a insegurança alimentar moderada e grave está significativamente associada à fragilidade na pessoa idosa. De acordo com esta classificação, os participantes desta pesquisa estariam, em sua maioria inclusos como “seguros” ou em “insegurança alimentar leve”. No Brasil, o direito à alimentação está previsto na Constituição Federal e é reforçado pela Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. é, portanto, dever do Estado adotar políticas públicas e ações necessárias para garantir a segurança alimentar e nutricional de todos os cidadãos.⁵

No que refere-se ao acesso aos serviços de saúde, as pessoas idosas participantes de ambos os grupos, a prevalência se deu no uso do Sistema Único de Saúde (SUS) (Grupo 1: 65,61% e Grupo 2: 80%), os demais utilizam algum convênio/plano de saúde e/ou consultas particulares. Estudos mostraram que pessoas idosas que vivem em áreas urbanas tem maior acesso aos serviços de saúde e que o grau de escolaridade também influencia neste aspecto, de forma que quanto maior o grau de instrução, maior será a procura pelos serviços de saúde, o que corrobora com os dados desta pesquisa em que o grau de escolaridade é um fator importante a ser verificado, conforme Tabela 2 (Oliveira *et al* 2022; Almeida *et al*, 2020).

⁵ Lei 11.346/2006 - Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências.

Análise do Grau de Instrução das Pessoas Idosas Através da Checklist da CIF-Adaptada

Conforme observa-se na **Tabela 2**, o perfil de instrução dos participantes é heterogêneo, não possui indivíduos aletrados, porém varia entre pessoas idosas que possuem o ensino fundamental incompleto, até indivíduos que possuem pós graduação.

Tabela 2 *Distribuição do Grau de Escolaridade*

Grau de Escolaridade	Frequência	
	Grupo 1	Grupo 2
Aletrados	0	0
Fundamental Incompleto	4	4
Fundamental Completo	3	2
Médio Incompleto	2	0
Médio completo	8	2
Superior Incompleto	4	1
Superior Completo	7	1
Pós Graduação	1	0

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Após análise do grau de escolaridade, observado na Tabela 2, verificou-se que as pessoas idosas do Grupo 1, apresentaram grau de escolaridade com maior prevalência de Ensino médio completo (N=8), enquanto que as pessoas idosas do Grupo 2, mostraram maior prevalência de Ensino Fundamental Incompleto (N=4). Neste aspecto, Skevington (2009) investigou a relação entre Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS), nível educacional e cultural e identificou que a QVRS nas dimensões física, psicológica, social e ambiental aumenta com o nível de escolaridade, especialmente até o ensino médio; porém, a dimensão ambiental segue melhorando até o ensino superior. De igual modo, Su e Wang (2019) observaram que quanto mais elevado o nível educacional, há uma melhora significativa na QV em pessoas idosas, mesmo após considerar outros fatores como doenças crônicas, solidão e idade.

Após responderem a *Checklist* da CIF-Adaptada, os participantes responderam mais três instrumentos de coleta de dados, conforme metodologia.

Análise Estatística Quantitativa

Prosseguindo com a análise dos dados, seguiu-se a análise estatística destes instrumentos. Os dados obtidos foram submetidos inicialmente ao estudo da Homocedasticidade das Variâncias⁶ por meio do Teste de *Levene* (Levene, 1960), conforme observa-se na Tabela 3.

Tabela 3 *Análise do Teste de LEVENE*

Instrumento	Fcalculado	Alfa	Ftabela	p-valor	Conclusão
MEEM	1,22	0,05	4,11	0,28	As Variâncias são homogêneas
WOQHOL	0,34	0,05	4,11	0,56	As Variâncias são homogêneas
IVCF-20	0,99	0,05	4,11	0,33	As Variâncias são homogêneas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

O teste de *Levene* demonstrou que todos os domínios analisados apresentaram homogeneidade das variâncias. Para o MEEM, observou-se $F_{cal} = 1,22$ ($p = 0,28$); para o WOQHOL, $F_{cal} = 0,34$ ($p = 0,56$); e para o IVCF-20, $F_{cal} = 0,99$ ($p = 0,33$). Em todos os casos, os valores de p foram superiores a 0,05, dessa forma, os dados atenderam ao pressuposto de igualdade das variâncias entre os grupos.

Estudos apontam que a verificação da homogeneidade das variâncias é uma etapa essencial em estudos comparativos, especialmente quando se avaliam construtos complexos como cognição e sintomas depressivos, que podem apresentar grande variabilidade entre indivíduos idosos (Field, 2018; Tabachnick & Fidell, 2019). Observa-se, ainda, que a transformação dos dados do BDI foi eficaz para estabilizar a variância, procedimento comumente recomendado em situações de assimetria moderada ou dispersão irregular dos escores (Hair et al., 2020).

Em sequência, foi realizado o estudo da Normalidade dos dados, por meio do teste de *Kolmogorov-Smirnov* (KS) (Kolmogorov, 1933; Smirnov 1939;1948), conforme **Tabela 4.**, indicando que os dados apresentaram distribuição normal nos três domínios avaliados. Para o MEEM, WOQHOL-BREF e IVCF-20, os valores de KS calculado (0,1729; 0,1287; 0,0950, respectivamente) foram inferiores ao valor crítico da tabela (0,2178), considerando $\alpha = 0,05$, confirmando que as distribuições são normais.

⁶ Refere-se à suposição de que a variância dos erros do modelo permanece constante ao longo dos valores das variáveis independentes.

Tabela 4 Avaliação do Teste de KOILOGOROV-SMIRNOV

Instrumento	KS Calculado	Alfa	KS tabelado	Conclusão
MEEM	0,1729	0,05	0,2178	Amostra tem distribuição normal
WOQHOL	0,1287	0,05	0,2178	Amostra tem distribuição normal
IVCF-20	0,0950	0,05	0,2178	Amostra tem distribuição normal

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A análise dos pressupostos estatísticos indicou que os dados apresentaram distribuição normal em todos os domínios avaliados, permitindo o uso de testes estatísticos paramétricos.

Ademais, foi realizado o estudo da Correlação entre os domínios, por meio do teste de Correlação de *Pearson*, para avaliar a relação linear entre as variáveis, conforme **Tabela 5**.

Tabela 5 Análise da Correlação entre os instrumentos estudados

Instrumentos	MEEM	WOQHOL
WOQHOL	-0,041625	
IVCF-20	0,1261	-0,58206

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A análise de correlação de *Pearson* revelou que os domínios MEEM e WOQHOL apresentaram correlação fraca e negativa ($r = -0,0416$), indicando ausência de relação linear entre as variáveis. Entre MEEM e IVCF-20, observou-se correlação fraca e positiva ($r = 0,1261$), sugerindo associação mínima entre os escores. A relação mais expressiva foi encontrada entre WOQHOL e IVCF-20, com correlação moderada e negativa ($r = -0,5821$), indicando que maiores valores em um domínio tendem a estar associados a menores valores no outro.

No que se refere às associações entre os domínios avaliados, observou-se que não houve correlação significativa entre o MEEM e o WHOQOL, indicando que o desempenho cognitivo dos participantes não se relacionou diretamente à percepção de QV. Esse resultado é compatível com estudos que sugerem que, em pessoas idosas independentes, a cognição tende a manter relativa autonomia em relação aos domínios subjetivos da QV (Fleck *et al.*, 2000; Neri & Yassuda, 2009).

De igual modo, foi encontrada uma correlação fraca e positiva entre o IVCF-20 e o MEEM, evidenciando que maior fragilidade funcional não esteve associada a pior desempenho cognitivo entre os participantes da pesquisa. Outros estudos afirmaram que essa relação pode variar conforme o nível de dependência e comorbidades, sendo mais forte em populações clínicas ou institucionalizadas (Fried *et al.*, 2001; Aprahamian *et al.*, 2011). Desta forma, a ausência de associação relevante pode indicar que os participantes ainda apresentam níveis moderados de autonomia funcional.

Por outro lado, a correlação negativa moderada entre IVCF-20 e WHOQOL demonstrou que maiores níveis de fragilidade estão associados a pior QV. Esse achado é amplamente consistente com outros estudos, que descreve a fragilidade como um importante preditor de redução da capacidade física, autonomia e participação social (Cesari *et al.*, 2016; Brigola *et al.*, 2019). Esse aspecto corrobora que o comprometimento funcional é um dos marcadores mais sensíveis do declínio da QV no envelhecimento.

A integração dos resultados mostra, portanto, que a fragilidade funcional é o fator que mais se relaciona à percepção física de QV, enquanto cognição não apresentou associações relevantes dentro desta amostra. Esses achados reforçam a necessidade de programas de intervenção voltados ao fortalecimento musculoesquelético, prevenção de quedas e estímulo à mobilidade, reconhecidamente eficazes para conter o avanço da fragilidade e melhorar o bem-estar global em pessoas idosas (Bouillon *et al.*, 2019; Organização Mundial da Saúde [OMS], 2015).

Posteriormente, seguiu-se o estudo da análise das variâncias (ANOVA), utilizado para verificar se há diferenças significativas entre as médias dos participantes de dança e instrumentos musicais, Grupos 1 e 2, respectivamente. Na **Tabela 6**, observa-se que a ANOVA não identificou diferenças estatisticamente significativas entre os tipos de atividades artísticas (dança e instrumentos musicais) nos escores dos domínios MEEM ($p = 0,585$), WOQHOL ($p = 0,303$) e IVCF-20 ($p = 0,876$).

Esses resultados indicam que, independentemente do tipo de atividade realizada, os participantes apresentaram desempenhos semelhantes nos aspectos cognitivos, de QV e funcionalidade. Observou-se ainda que os coeficientes de variação do MEEM e WOQHOL apresentaram alta precisão ($CV < 20\%$), enquanto o IVCF-20 mostrou elevada dispersão ($CV = 64,71\%$), refletindo maior heterogeneidade no nível de fragilidade das pessoas idosas.

Tabela 6 *Análise de variância para as dominâncias MEEM, WOQHOL, IVCF-20, nas atividades artísticas de dança e instrumentos musicais*

Atividade/Instrumentos	MEEM	WOQHOL	IVCF-20
Atividade Artística	1,5876 ns	280,46 ns	0,8666 ns
Erro	5,2391	257,84	35,09
p (fator)	0,585	0,303	0,876
CV%	8,89	17,20	64,71

ns= não significativo ao nível de 5% de probabilidade.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Tais resultados sugerem que, embora ambas as atividades envolvam estímulos sensório-motores, cognitivos e sociais, nenhuma das modalidades se sobressai à outra quanto à capacidade de promover melhores níveis de cognição, QV ou redução da fragilidade. Esses achados estão alinhados com estudos que demonstram que atividades artísticas, em geral, tendem a produzir benefícios semelhantes entre si, desde que envolvam engajamento ativo, interação social e estímulos mentais contínuos (Noice & Noice, 2009; Rehfeld *et al.*, 2018).

Apesar da ausência de diferenças significativas entre as modalidades artísticas, o coeficiente de variação revelou um aspecto importante: enquanto MEEM e WOQHOL apresentaram baixa dispersão ($CV < 20\%$), o IVCF-20 apresentou CV elevado (64,71%), indicando maior heterogeneidade do grupo em termos de fragilidade. Isso sugere que a amostra possui diferentes perfis funcionais, o que pode ter diluído possíveis efeitos específicos da intervenção artística. Estudos mostram que grupos heterogêneos em fragilidade tendem a responder de forma mais variável a estímulos físicos e cognitivos (Fried *et al.*, 2001; Hoogendijk *et al.*, 2019).

Embora a análise de variância tenha constatado não haver diferença significativa entre os domínios, no entanto, percebe-se valores altos para o coeficiente de variação, demonstrando que existem dados discrepantes entre si, dentro dos domínios. Assim, os dados foram submetidos a uma análise multivariada, no intuito de estudar-se os autovalores e autovetores, conforme Tabela 7. A análise multivariada é um conjunto de métodos estatísticos utilizados quando o pesquisador deseja analisar simultaneamente duas ou mais variáveis em um mesmo modelo, considerando as relações,

interdependências e padrões conjuntos entre elas. Diferentemente das análises univariadas (uma variável por vez) ou bivariadas (relação entre duas variáveis), a análise multivariada permite compreender fenômenos complexos de forma mais integrada, o que é especialmente relevante em pesquisas em saúde, psicologia e envelhecimento, nas quais múltiplos fatores atuam de maneira concomitante.

Em estudos com pessoas idosas, a análise multivariada permite examinar de forma integrada como cognição, estado emocional, condições clínicas e fatores sociodemográficos se relacionam entre si e contribuem para desfechos como qualidade de vida e funcionalidade. Assim, trata-se de uma abordagem essencial para a compreensão de fenômenos multidimensionais, oferecendo uma visão mais abrangente e robusta dos dados analisado (Hair et al., 2019). Neste estudo foi realizada a Análise de Componentes Principais (ACP/PCA), utilizada para redução de dimensionalidade, permitindo identificar as variáveis que explicam a maior parte da variabilidade dos dados. As variáveis incluídas foram:

- MEEM (cognição)
- WHOQOL-bref (qualidade de vida)
- IVCF-20 (fragilidade clínico-funcional)

Por meio da análise Multivariada observa-se que a qualidade de vida é o principal fator explicativo da variabilidade entre os participantes, a fragilidade funcional aparece como um fator secundário, ainda relevante, mas com menor impacto global, a cognição, embora clinicamente importante, não explica diferenças relevantes entre os participantes no contexto desta pesquisa. Esses achados corroboram as análises bivariadas, nas quais não houve associação significativa entre cognição e QV e onde a fragilidade funcional apresentou correlação negativa com a QV.

Ao observar o gráfico de dispersão (Scatter plot) observa-se que a sobreposição entre os grupos indica que não há separação clara entre as modalidades artísticas, reforçando que dança e instrumentos musicais produzem perfis semelhantes quanto à cognição, funcionalidade e qualidade de vida.

Tabela 7 *Análise Multivariada- Análise de Componentes Principais (PCA/ACP)*

SUMMARY

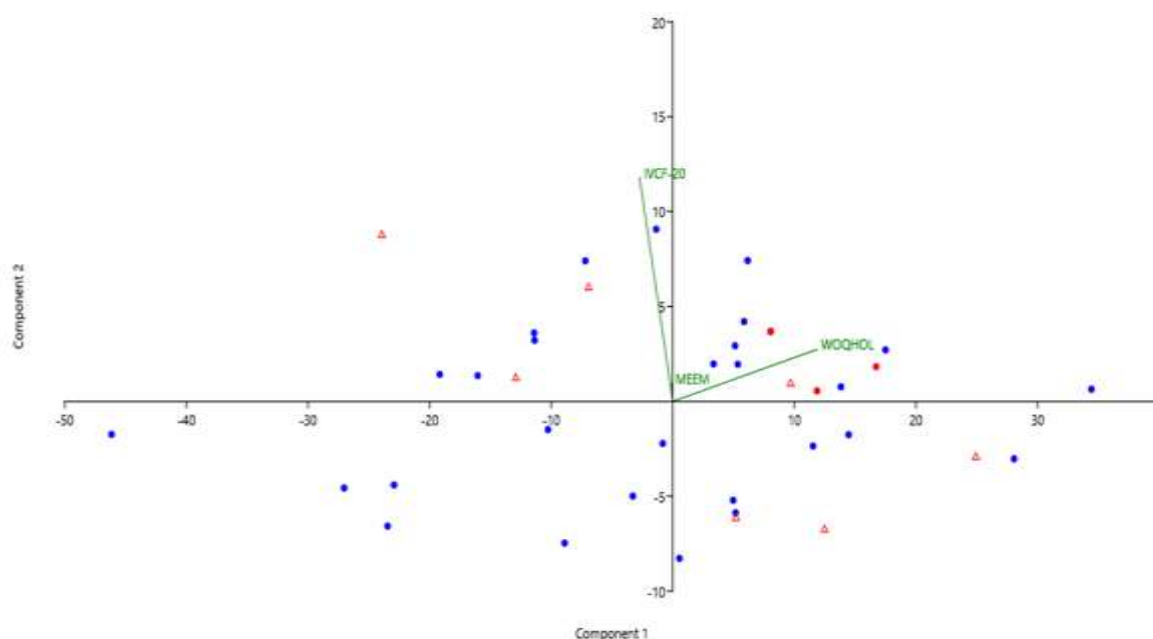
PC	<i>Eigenvalue</i>	<i>% variance</i>
1	271,087	91,04
2	21,6509	7,2711

3	5,02975	1,6892
---	---------	--------

LOADINGS

	PC 1	PC 2	PC 3
MEEM	-0.0069747	0.077703	0.99695
WOQHOL	0.97432	0.22491	-0.010714
IVCF-20	-0.22506	0.97128	-0.077277

SCATTER PLOT



Legenda: Azul/círculo: Grupo 1 (Dança); Vermelho/triângulo: Grupo 2 (Instrumentos musicais)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A Análise de Componentes Principais (PCA) permitiu identificar a estrutura subjacente de variabilidade entre as variáveis QV (WOQHOL), funcionalidade (IVCF-20) e cognição (MEEM). Os resultados demonstraram que o primeiro componente principal (PC1) apresentou autovalor de 271,087, explicando 91,04% da variância total. O segundo componente (PC2) explicou 7,27%, e o terceiro (PC3) apenas 1,69%, indicando que 98,3% da variância está concentrada nos dois primeiros componentes. Os *loadings* reforçam essa interpretação.

O WOQHOL apresentou contribuição marcante para o PC1 (0,97432), caracterizando-o como o eixo dominante de variação e evidenciando que os escores de QV foram os principais responsáveis pela diferenciação entre os participantes. O IVCF-20 contribuiu para esse eixo de maneira secundária e inversamente proporcional (–0,22506), enquanto o MEEM praticamente não influenciou o PC1.

No Componente principal 2 (PC2), observou-se predominância clara do IVCF-20 (0,97128), configurando um eixo específico ligado à funcionalidade, independente da variabilidade explicada pelo WOQHOL. O PC3, por sua vez, foi determinado quase exclusivamente pelo MEEM (0,99695), indicando que a cognição compõe uma dimensão própria, embora de baixa relevância dentro da estrutura global dos dados, dada a reduzida variância explicada (<2%).

Esses achados sugerem que a QV foi o principal elemento diferenciador entre os participantes, o que pode estar associado à relevância subjetiva e multidimensional desse constructo no envelhecimento. O fato de a funcionalidade emergir como segunda dimensão independente é coerente com a literatura, que reconhece a relação entre capacidade funcional e QV, embora no presente estudo a funcionalidade tenha exercido influência bem menor no padrão global de variabilidade.

A cognição se mostrou homogênea, como indicado pela baixa variância associada ao MEEM, o que pode decorrer de características da população estudada — participação em atividades artístico-culturais, que frequentemente selecionam indivíduos funcionalmente e cognitivamente preservados. Essa homogeneidade limita a capacidade da PCA de identificar a dimensão cognitiva como eixo relevante de diferenciação, mas também sugere que déficits cognitivos não foram predominantes no grupo analisado. Esses achados reforçam a importância de considerar indicadores subjetivos e funcionais ao avaliar benefícios associados à participação em atividades artístico-culturais, bem como sinalizam que contextos de engajamento social podem estar associados a perfis cognitivos mais homogêneos e preservados.

Análise do Perfil Cognitivo de Pessoas Idosas Praticantes de Atividade Artístico Cultural

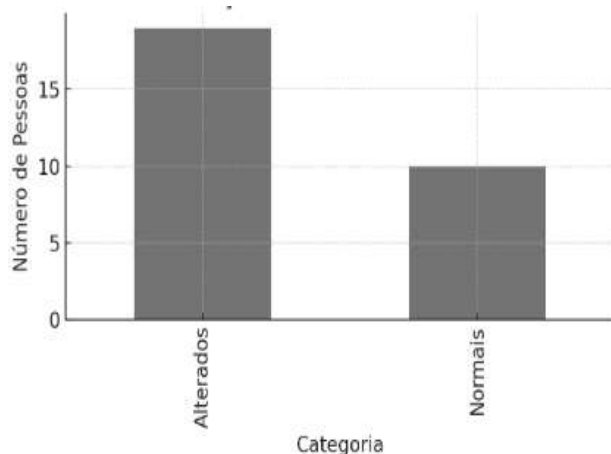
Para análise do perfil cognitivo foi utilizado o instrumento de rastreio cognitivo MEEM, conforme metodologia. Para estabelecer um padrão entre a pontuação obtida pelos participantes e um ponto de corte, foram adotados os pontos de corte de Brucki *et al.*, (2003), conforme abaixo:

Pontos de Corte por Escolaridade - MEEM

- Aletrados: 20 pontos.
- 1 a 4 anos de estudo: 25 pontos.
- 5 a 8 anos de estudo: 26,5 pontos.
- 9 a 11 anos de estudo: 28 pontos.
- Mais de 11 anos de estudo: 29 pontos - Brucki *et al*, (2003).

No que concerne as pessoas idosas praticantes de Dança, a avaliação cognitiva realizada por meio do MEEM revelou que, entre os 29 participantes avaliados, 58,6% apresentaram pontuações abaixo do ponto de corte esperado para sua faixa de escolaridade, indicando possível declínio cognitivo leve, predominando um padrão de 1 a 2 erros. Os demais, 41,4%, exibiram desempenho dentro da normalidade. A distribuição dos resultados demonstrou maior concentração de escores reduzidos entre participantes com escolaridade média e superior, sugerindo que, apesar do nível educacional mais elevado, há presença de alterações cognitivas leves, conforme **Gráfico 4**.

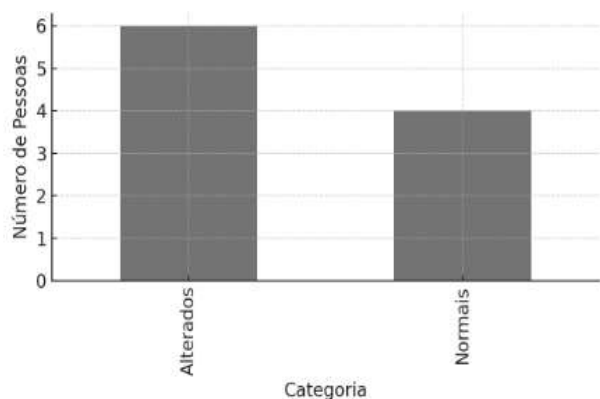
Gráfico 4 Distribuição do Ponto de Corte por Escolaridade através do MEEM - Dança



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Relacionado as pessoas idosas praticantes de instrumento musical, observou-se que 60% dos participantes apresentaram desempenho abaixo do ponto de corte no MEEM, configurando possível declínio cognitivo, conforme **Gráfico 5**.

Gráfico 5 Distribuição do Ponto de Corte por Escolaridade através do MEEM - Instrumento Musical



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Essa diferença entre os grupos pode refletir variações nos perfis educacionais entre as amostras, uma vez que estudos dos últimos cinco anos apontam que a escolaridade exerce impacto significativo no desempenho em testes cognitivos, influenciando tanto o escore obtido quanto a sensibilidade do MEEM para detectar alterações leves (Lima *et al.*, 2023; Bertola *et al.*, 2023). A maior frequência de escores alterados nos dois grupos pode estar relacionada a características contextuais específicas, incluindo condições sociodemográficas e possíveis fatores ambientais ou de saúde não avaliados.

Um estudo populacional conduzido na China com indivíduos com 55 anos ou mais reportou uma prevalência de comprometimento cognitivo de 12,2%, demonstrando que maior parte da amostra estudada não apresentava esta característica (Feng, *et al.*, 2014), o que configura um perfil cognitivo melhor em comparação a este estudo, onde o declínio cognitivo, apesar de leve, esteve presente em ambos os grupos com prevalência maior que 58% em ambos. No Reino Unido, um estudo populacional com idosos com 75 anos ou mais identificou uma prevalência significativamente maior, em torno de 50%, com as maiores taxas observadas nas faixas etárias mais avançadas (Docking, *et al.*, 2014), resultado que aproxima-se do encontrado neste estudo.

Nessa perspectiva, Ros *et al.* (2025) afirmaram que há uma influência substancial da educação no envelhecimento cognitivo da população brasileira, assim como, fatores cardiometabólicos como hipertensão e diabetes contribuem para o declínio cognitivo, dados que corroboram com os achados dessa pesquisa já anteriormente citados. Dessarte, o autor supracitado ressalta que as variáveis sociodemográficas como instabilidade econômica e insegurança social são DSS correlacionados com a saúde cognitiva, além de que isolamento social, *status* socioeconômico e educação são fatores de risco mais evidentes do que idade e sexo.

Ademais, observa-se possíveis limitações da presente investigação que devem ser mencionadas, especialmente aquelas relacionadas à amostragem (validade externa) e à escolaridade (validade interna). A amostra desta pesquisa não incluiu pessoas idosas de áreas rurais e com indicadores de declínio cognitivo significativo, o que limita a validade externa desta pesquisa. A validade interna foi limitada pelo fato de os anos de escolaridade constituírem a única informação coletada sobre a escolaridade. No Brasil, a qualidade da educação é uma variável igualmente importante quanto o tempo que as pessoas passaram na escola, e isso não foi mensurado (Melo e Barbosa, 2020).

Análise da Funcionalidade/Fragilidade em pessoas idosas praticantes e atividades artístico-culturais

Moraes *et al.* (2016) consideraram, como fragilidade, a redução da reserva homeostática ou da capacidade de adaptação do indivíduo a estressores biopsicossociais e consequente aumento da vulnerabilidade ao declínio funcional. Identificar condições sociodemográficas e de saúde da pessoa idosa que estejam correlacionadas ao declínio funcional, como em casos de fragilidade, contribui para reflexões sobre políticas públicas e intervenções que possam promover independência funcional e melhor qualidade de vida.

Para analisar a funcionalidade, foi utilizado o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) que contém 20 perguntas divididas em 8 sessões, sendo elas: idade, autopercepção de saúde, atividade de vida diária, cognição, humor, mobilidade, comunicação e comorbidades múltiplas, perfazendo o máximo de 40 pontos ao final do teste, desta forma, quanto mais alto o valor obtido, maior é o risco de vulnerabilidade clínico-funcional da pessoa idosa. Através da pontuação é possível correlacionar o risco de vulnerabilidade clínico-funcional ao declínio funcional (Moraes et al., 2016).

Pontos de corte:

- 0-6 pontos: idosos com baixo risco de vulnerabilidade clínico-funcional / ausência de declínio funcional (Idoso(a) ROBUSTO)
- 7-14 pontos: idosos com moderado risco de vulnerabilidade clínico-funcional / possível declínio funcional (Idoso(a) POTENCIALMENTE FRÁGIL)
- ≥ 15 pontos: idosos com alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional (Idoso(a) FRÁGIL)⁷

De acordo com a classificação acima, os participantes que responderam ao IVCF-20 foram classificados em idosos Robustos, Potencialmente Frágeis ou Frágeis, conforme **Tabela 8**.

Tabela 8 *Perfil Funcional – Grupo 1 (Dança) e Grupo 2 (Instrumentos musicais)*

	Grupo 1 (n)	Grupo 2 (n)
Potencialmente Frágil	14	4
Frágil	7	2
Robusto	8	3

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Nos praticantes de Dança, grupo 1, os Potencialmente Frágeis predominam (48,3%), acompanhados por proporções menores de Frágeis (24,1%) e Robustos (27,6%). De igual modo, nos praticantes de Instrumentos Musicais, grupo 2, há predominância dos indivíduos potencialmente frágeis (44,4%), seguido de valores bem distribuídos entre Frágeis (22,2%) e Robustos (33,3%). Observa-se, porém, uma redução na proporção de indivíduos robustos no Grupo 1, o que pode indicar uma população mais vulnerável, maior presença de comorbidades ou diferenças de perfil demográfico que justifiquem estes achados.

Se somados os resultados dos dois grupos, os participantes classificados como potencialmente frágeis e frágeis, perfazem 67,5% dos participantes da pesquisa, o que é um resultado expressivo, considerando que estas pessoas idosas são ativas, fazem aulas de oficinas artísticas e culturais, locomovem-se e alguns fazem uso de transporte público sozinhos, o que indica certo grau de independência funcional, ainda assim, os marcadores encontram-se presentes, o que revela potenciais riscos e agravos.

⁷ Rio Grande do Sul. Secretaria da Saúde. Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde. (2023). *Manual de aplicação do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20): orientações para profissionais da Atenção Primária à Saúde* (J. C. Ely & T. A. Bessa, Eds.). ESP/SES.

Dentre as Sessões do IVCF-20 que apresentaram maior quantidade de respostas indicando fragilidade da pessoa idosa e unificando os dois grupos, destacam-se observadas no **Quadro 1**.

Quadro 1 Sessões do IVCF-20 que obtiveram maior porcentagem de respostas indicativas de fragilidade

Sessão do IVCF-20	Pergunta realizada	Responderam “Sim” ao item
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVD)	<i>“Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?”</i>	30% (N=12)
COGNIÇÃO	<i>“Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?”</i>	50% (N=20)
COGNIÇÃO	<i>“Este esquecimento está piorando nos últimos meses?”</i>	70% (N=14) *(Considerando os 20 participantes que responderam “sim” à pergunta anterior)
COGNIÇÃO	<i>“Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano?”</i>	25% (N=5) *(Considerando os 20 participantes que responderam “sim” a primeira pergunta)
HUMOR	<i>“No último mês você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?”</i>	57,5% (N=23)
HUMOR	<i>“No último mês, você perdeu o interesse em atividades anteriormente prazerosas?”</i>	32,5% (N=13)
CAPACIDADE AERÓBICA:	<i>“Você tem alguma das quatro condições abaixo relacionadas?”</i> <i>1. Perda de peso não intencional de 4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano ou 6 kg nos últimos 6 meses ou 3kg no último mês?;</i> <i>2. Índice de Massa Corporal menor que 22 kg/m²?;</i> <i>3. Circunferência da panturrilha a < 31 cm?;</i> <i>4. Tempo gasto no teste de velocidade da marcha >5 segundos.”</i>	62,5% (N=25) (Tempo gasto no teste de velocidade de marcha o que obteve maior prevalência, seguido da circunferência da panturrilha <31 cm)
MOBILIDADE	<i>“Você teve duas ou mais quedas no último ano?”</i>	22,5% (N=9)
MOBILIDADE - CONTINÊNCIA ESFINCTERIANA	<i>“Você perde urina ou fezes, sem querer, em algum momento?”</i>	37,5% (N=15)
COMORBIDADES MÚLTIPLAS	<i>“Tem alguma das três condições relacionadas?”</i> <i>1. ‘cinco ou mais doenças crônicas’</i> <i>2. ‘uso de cinco ou mais medicamentos diferentes, todo dia?’</i> <i>3. ‘internação recente, nos últimos 6 meses’?</i>	20% (N=8) (não houve resposta para internação recente, nos últimos 6 meses; uso de cinco ou mais medicamentos diferentes todo dia foi a resposta com maior prevalência)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Os resultados da presente pesquisa, são coerentes com os achados nacionais e internacionais sobre a síndrome de fragilidade da pessoa idosa. Uma metanálise brasileira identificou prevalência média de 24% de fragilidade entre idosos comunitários, variando conforme o instrumento utilizado, o que confirma que taxas elevadas são esperadas em populações semelhantes (Melo et al., 2020). Estudos populacionais como o ELSI-Brasil⁸ reportaram prevalência de 13,5% de fragilidade, associada especialmente à baixa escolaridade, múltiplas comorbidades e limitação funcional, fatores que também podem explicar a elevada proporção de “potencialmente frágeis” observada neste estudo (Nunes et al., 2018).

De igual modo, O’Caoimh *et al.*, (2018) em revisão sistemática identificaram prevalência global de 17,4% de fragilidade e cerca de 49% de pré-fragilidade, reforçando que estados intermediários — semelhantes ao grupo “potencialmente frágil” — são altamente prevalentes no envelhecimento. No Brasil, estudo realizado no sul do país encontrou 15,8% de frágeis e 65,3% de pré-frágeis, valores que se aproximam do padrão observado no presente levantamento, especialmente pela predominância de indivíduos em risco de progressão (Confortin *et al.*, 2020).

Ademais, pesquisas brasileiras têm mostrado relação consistente entre fragilidade, polifarmácia, pior condição socioeconômica e comprometimento funcional e cognitivo (Silva *et al.*, 2020), fatores que podem contribuir potencialmente para a classificação de grande parte dos idosos como “potencialmente frágeis” nesta pesquisa.

Análise da Qualidade de Vida

Para melhor delimitar a percepção de QV os participantes da pesquisa responderam ao WOOQHOL-*bref*⁹ (Fleck, 2000), contendo 26 questões, sendo duas questões gerais de qualidade de vida e as demais 24 representam cada uma das 24 facetas que compõem o instrumento original.

⁸ O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil) é conduzido em amostra nacionalmente representativa de adultos com 50 anos ou mais residentes na comunidade. A primeira onda do ELSI-Brasil foi conduzida em 2015-16 e a segunda onda em 2019-21. Link: <https://elsi.cpqrr.fiocruz.br/>

⁹ O questionário WHOQOL-*bref* (versão abreviada do WHOQOL-100) - ([sigla para World Health Organization Quality of Life – BREF](#)) - é composto por 26 questões que avaliam a qualidade de vida em quatro domínios principais - Domínio Físico; Psicológico; Relações Sociais; Meio Ambiente. Os escores mais altos nos domínios do WHOQOL-*bref* indicam uma melhor qualidade de vida

Para melhor apreciação dos dados, comparou-se o desempenho dos Grupos 1 e 2 nos quatro domínios do WHOOQOL-bref e em cada faceta específica, conforme **Quadro 2**.

Quadro 2 *Análise das médias por domínio e facetas do WOQHOL-Bref*

	Pergunta	Faceta	Média	
			Grupo 1	Grupo 2
Percepção de Qualidade de Vida	Como você avaliaria sua qualidade de vida?		3,7	3,8
Satisfação com a saúde	Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde?		3,7	3,3
Domínio 1. Físico	Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa?	Dor e desconforto	3,8	4,4
	O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária?	Dependência de medicação ou tratamento	3	3,6
	Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia?	Energia e fadiga	3	3,6
	Quão bem você é capaz de se locomover?	Mobilidade	4	4
	Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?	Sono e repouso	3	3,6
	Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu dia-a-dia?	Atividade de Vida cotidiana	3,4	4
	Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho?	Capacidade de Trabalho	3,7	4
Domínio 2. Psicológico	O quanto você aproveita a vida?	Espiritualidade, religião, crenças pessoais	3,7	3,3
	Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?	Sentimentos positivos	3,8	4,2
	O quanto você consegue se concentrar?	Pensar, aprender, memória, concentração	3,1	3,4
	Você é capaz de aceitar sua aparência física?	Imagem Corporal e aparência	3,6	3,9

	Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo?	Auto estima	3,3	3,3
	Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão?	Sentimentos negativos	4,1	4,3
Domínio 3. Relações sociais	Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)?	Relações pessoais	3	3,7
	Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual?	Atividade sexual	3,8	4
	Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos?	Suporte (apoio) social	3,8	3,9
Domínio 4. Meio ambiente	Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária?	Segurança física e proteção	3,7	4,4
	Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)?	Ambiente físico	3,9	4,2
	Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?	Recursos financeiros	2,8	2,7
	Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia?	Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades	3,4	4
	Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer?	Participação em, e oportunidades de recreação/lazer	3,6	3,9
	Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora?	Ambiente no lar	3,4	3,1
	Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde?	Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade	3,6	3,7
	Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte?	Transporte	3,7	3,6

CLASSIFICAÇÃO:

- Necessita melhorar (1 até 2,9);
- Regular (3 até 3,9);

- Boa (4 até 4,9)
- Muito boa (5)- (FLECK et al, 2000)
- Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Quando observa-se a percepção geral da QV, nota-se que ambos os grupos apresentaram escores elevados, porém o Grupo 2 mostrou leve vantagem (3,8 vs. 3,7). No que concerne à Satisfação com a Saúde, o Grupo 1 apresentou melhor percepção (3,7 vs. 3,3).

A análise comparativa entre os dois grupos avaliados pelo WHOQOL-bref demonstra diferenças relevantes nos domínios físico, psicológico, social e ambiental. No que concerne ao Domínio Físico, o Grupo 2 exibiu menor impacto da dor, maior energia e melhor desempenho nas atividades de vida diária. Azevedo *et al.* (2024) identificaram que idosos com melhores condições ambientais apresentam até 30% mais chances de se manterem robustos segundo índices clínicos de vulnerabilidade. O padrão encontrado nas pessoas idosas do Grupo 2 reflete esse perfil: maior satisfação ambiental está alinhada a menor fragilidade funcional e a maior participação em atividades sociais, enquanto os escores das pessoas idosas do Grupo 1 são mais similares aos de idosos classificados como pré-frágeis ou frágeis.

No Domínio Psicológico, embora os dois grupos tenham apresentado valores semelhantes para autoestima, as pessoas idosas do Grupo 2 demonstraram melhor desempenho em sentimentos positivos e imagem corporal. Em uma análise transversal, Tasioudi *et al.* (2022) verificaram que idosos fisicamente ativos e socialmente inseridos apresentavam escores 15–22% maiores em indicadores de bem-estar psicológico, especialmente em “sentimentos positivos” e “imagem corporal”, o que reflete de forma semelhante os resultados observados no Grupo 2. No entanto, a maior frequência de sentimentos negativos no Grupo 2 sugere maior consciência emocional ou exposição a estressores sociais, um fenômeno também relatado por Alves *et al.* (2023), que identificaram que idosos com maior participação social podem relatar maior sensibilidade a experiências negativas, sem que isso reduza significativamente seu bem-estar global.

No Domínio Relações Sociais, as pessoas idosas do Grupo 2 novamente apresentaram melhores resultados, relatando maior satisfação com relações pessoais, vida sexual e apoio social. Confortin *et al.* (2020), avaliando mais de 6.000 idosos, observaram que o apoio social adequado aumenta em até 40% os escores em domínios sociais do WHOQOL-bref. Os resultados da presente análise mostram diferenças de magnitude semelhante entre os dois grupos, com o Grupo 2 aproximando-se do padrão observado em populações com maior integração comunitária.

Em relação ao Domínio Meio Ambiente, os achados demonstram que as pessoas idosas do Grupo 2 percebem melhor segurança, acesso à informação, lazer e qualidade do ambiente físico. Azevedo *et al.* (2024) identificaram que idosos com melhores condições ambientais apresentam até 30% mais chances de se manterem robustos segundo índices clínicos de vulnerabilidade. O padrão encontrado no Grupo 2 reflete esse perfil: maior satisfação ambiental está alinhada a menor fragilidade funcional e a maior participação em atividades sociais, enquanto os escores do Grupo 1 são mais similares aos de idosos classificados como pré-frágeis ou frágeis.

Quando comparados com pesquisas sobre fragilidade, os resultados reforçam que o domínio físico é o mais fortemente afetado em idosos mais vulneráveis (Melo *et al.*, 2020; Alves *et al.*, 2023). O desempenho inferior das pessoas idosas do Grupo 1 em energia, dor, mobilidade e dependência funcional coincide com o perfil descrito por Melo *et al.* (2020), que observaram reduções de até 35% nesses indicadores entre idosos frágeis. As pessoas idosas do Grupo 2 aproximam-se das descrições de idosos robustos, apresentando melhor funcionalidade física e melhor integração social — duas variáveis reconhecidamente protetoras contra a progressão da fragilidade (Azevedo *et al.*, 2024).

Ademais, os resultados demonstram que as pessoas idosas participantes da pesquisa de maneira geral percebem sua QV como moderada à boa, com aspectos positivos em algumas dimensões, mas também vulnerabilidades específicas, especialmente no domínio psicológico e ambiental. A variabilidade dos resultados aponta para a necessidade de estratégias de intervenção individualizadas, contemplando tanto a promoção da saúde física e psicológica quanto o fortalecimento das redes sociais e ambientais.

CONCLUSÕES

Após análise dos resultados, é possível sugerir que, entre pessoas idosas participantes de atividades artístico-culturais, a fragilidade funcional mostrou-se o principal fator associado à pior percepção de qualidade de vida, enquanto o desempenho cognitivo não apresentou relação significativa com esse desfecho. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as modalidades de dança e prática de instrumentos musicais, sugerindo que ambas favorecem o engajamento social e o bem-estar de forma semelhante.

Ademais, apesar de se tratar de uma população ativa, a elevada prevalência de fragilidade, pré-fragilidade e indicadores de vulnerabilidade funcional evidencia a influência dos determinantes sociais, das comorbidades e da escolaridade no envelhecimento. De igual modo, conclui-se que as atividades artísticas configuram estratégias promissoras de promoção da saúde no envelhecimento, devendo ser associadas a intervenções preventivas voltadas especialmente à funcionalidade, mobilidade, cognição e saúde emocional, assegurando melhor percepção de qualidade de vida nesta população.

Diante desses achados, destaca-se a necessidade de um direcionamento mais interventivo, no qual as atividades artístico-culturais sejam incorporadas de forma estruturada às ações de promoção da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De forma que as políticas públicas voltadas à saúde da pessoa idosa priorizem estratégias intersetoriais que integrem práticas culturais a intervenções multiprofissionais focadas na manutenção da funcionalidade, mobilidade e autonomia. Nesse contexto, iniciativas desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde, como grupos comunitários e oficinas terapêuticas, podem atuar como dispositivos potentes de cuidado, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Assim, a valorização e ampliação de espaços como centros culturais e programas de extensão universitária no SUS podem contribuir significativamente para a prevenção da fragilidade, promoção do envelhecimento ativo e melhoria da qualidade de vida, especialmente quando articuladas a ações de educação em saúde, acompanhamento clínico e suporte psicossocial contínuo.

PERSPECTIVAS

Os autores reconhecem as limitações da presente pesquisa, especialmente, no que concerne o tamanho da amostra. Desta forma, recomenda-se a realização de pesquisas futuras com amostras maiores, inclusão de variáveis de qualidade educacional, raças e etnias, assim como populações comunitárias, quilombolas, dentre outras; que explorem diferentes modalidades artísticas e comparem as intervenções, avaliando de forma integrada aspectos cognitivos e funcionais e seus impactos na qualidade de vida; assim como, análises longitudinais, a fim de aprofundar a compreensão dos efeitos das atividades artísticas e dos determinantes sociais sobre o envelhecimento saudável. Ressalta-se a relevância de pesquisas qualitativas neste domínio, podendo melhor explorar a fala dos participantes e as nuances apontadas nelas, que perpassam os questionamentos dos instrumentos de coleta de dados.

REFERÊNCIAS MANUSCRITO I

- Almeida, A. P. S. C., Nunes, B. P., Duro, S. M. S., & Facchini, L. A. (2020). A gestão do cuidado às doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária: Uma análise da trajetória no sistema de saúde. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 29(2), e2018272. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000200016>
- Ambegaonkar, J. P., Caswell, S. V., Cortes, N., & Caswell, A. M. (2022). Dance-based training and balance in older adults: A systematic review. *Journal of Aging and Physical Activity*, 30(1), 125–138. <https://doi.org/10.1123/japa.2020-0154>
- Aprahamian, I., et al. (2011). Cognitive impairment and frailty in older adults: A systematic review. *Clinics*, 66(10), 1829–1835.
- Azevedo, L. M. R., Cardoso, M. R., & Vieira, A. A. (2024). Fragilidade em idosos: Desafios e perspectivas no contexto brasileiro. *Geriatrics, Gerontology and Aging*, 18(1), 1–12.
- Bertola, L., Binder, M. I., Rosa, G. R., Mendes, S. M., & Fonseca, R. P. (2023). Cognition and aging in Brazil: Current challenges and perspectives. *Dementia & Neuropsychologia*, 17(3), 250–260.
- Brasil. Ministério da Saúde. (2013). Prevenção de quedas de pessoas idosas. Ministério da Saúde.
- Brigola, A. G., et al. (2019). Physical frailty and cognitive impairment in older adults: A systematic review. *Dementia & Neuropsychologia*, 13(3), 293–302.

Brucki, S. M. D., Nitrini, R., Caramelli, P., Bertolucci, P. H. F., & Okamoto, I. H. (2003). Sugestões para o uso do Mini-Exame do Estado Mental no Brasil. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 61(3B), 777–781.

Cesari, M., et al. (2016). Frailty: An emerging public health priority. *Journal of the American Medical Directors Association*, 17(3), 188–192.

Charchat-Fichman, H., et al. (2005). Declínio cognitivo no envelhecimento. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 27(2), 79–82.

Confortin, S. C., et al. (2020). Frailty in older adults in Brazil: ELSI-Brazil results. *Cadernos de Saúde Pública*, 36(12), e00056320. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00056320>

Cruz-Jentoft, A. J., et al. (2019). Sarcopenia: Revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, 48(1), 16–31. <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>

Dhillon, R. J., & Hasni, S. (2017). Pathogenesis and management of sarcopenia. *Clinics in Geriatric Medicine*, 33(1), 17–26.

Fancourt, D., & Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? World Health Organization.

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). Sage.

Fleck, M. P., Louzada, S., Xavier, M., et al. (2000). Aplicação da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100). *Revista de Saúde Pública*, 34(2), 178–183.

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients. *Journal of Psychiatric Research*, 12(3), 189–198.

Fried, L. P., et al. (2001). Frailty in older adults: Evidence for a phenotype. *The Journals of Gerontology: Series A*, 56(3), M146–M156.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.

Hammer, Ø., Harper, D. A. T., & Ryan, P. D. (2008). PAST: Paleontological statistics software package. *Palaeontologia Electronica*, 4(1), 1–9.

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2022). Censo Demográfico 2022: Resultados. IBGE.
- Kolmogorov, A. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 83–91.
- León, L. P., Mangin, J. P. L., & Ballesteros, S. (2020). Psychosocial determinants of quality of life and active aging: A structural equation model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(17), 6023. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176023>
- Leś, A., Guskowska, M., Piotrowska, J., & Rutkowska, I. (2019). Changes in perceived quality of life and subjective age in older women participating in Nordic walking and memory training classes. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 59(10), 1783–1790. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.19.09588-4>
- Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. In I. Olkin (Ed.), *Contributions to probability and statistics* (pp. 278–292). Stanford University Press.
- Livingston, G., et al. (2020). Dementia prevention, intervention, and care. *The Lancet*, 396(10248), 413–446.
- Melo, B. D., et al. (2020). Prevalence of frailty in older Brazilians: A systematic review and meta-analysis. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(12), 4823–4836.
- Meng, X., et al. (2020). Dancing and cognitive function in older adults: A meta-analysis. *Journal of the American Geriatrics Society*, 68(4), 812–820.
- Millán-Calenti, J. C., et al. (2010). Cognitive impairment as predictor of mortality in older adults. *Maturitas*, 65(3), 224–232.
- Moraes, E. N., et al. (2016). Frailty and elderly health: Perspectives from the IVCF-20. *Revista de Medicina de Minas Gerais*, 26(Suppl. 8), 1–6.
- Neri, A. L., & Yassuda, M. S. (2009). Cognição e envelhecimento. In A. L. Neri (Ed.), *Palavras e crenças sobre envelhecimento* (pp. 143–160). Alínea.
- Noice, H., & Noice, T. (2009). An arts intervention for older adults living in subsidized retirement homes. *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, 16(1), 56–79.
- O’Caoimh, R., et al. (2018). Prevalence of frailty in older adults across 62 countries. *The Lancet Public Health*, 3(7), e389–e398.
- Organização Mundial da Saúde. (2020a). Decade of healthy ageing 2020–2030. WHO.

- Organização Mundial da Saúde. (2020b). Mental health of older adults. WHO.
- Petersen, R. C., et al. (2018). Mild cognitive impairment. *Nature Reviews Disease Primers*, 4, 39.
- Rehfeld, K., et al. (2018). Dance training is superior to repetitive physical exercise in inducing brain plasticity in the elderly. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 10, 305.
- Sampaio, L. M. R., et al. (2024). Quality of life in older adults participating in community groups. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 27(2), e230121.
- Skevington, S. M. (2010). Qualidade de vida e envelhecimento. In N. Cachioni & L. D. Falcão (Eds.), *Envelhecimento bem-sucedido* (pp. 121–138). Papirus.
- Smirnov, N. (1939). On the estimation of the discrepancy between empirical curves of distribution. *Bulletin Moscow State University*, 2, 3–16.
- Stephoe, A., Deaton, A., & Stone, A. A. (2015). Subjective wellbeing, health, and ageing. *The Lancet*, 385(9968), 640–648. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61489-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61489-0)
- Su, K., & Wang, Y. (2019). Determinants of quality of life among community-dwelling older adults. *International Journal of Public Health*, 64(7), 995–1006.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.
- The WHOQOL Group. (1995). The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL). *Social Science & Medicine*, 41(10), 1403–1409.
- World Health Organization. (1995). The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. *Social Science & Medicine*, 41(10), 1403–1409.
- World Health Organization. (1998). The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. *Social Science & Medicine*, 46(12), 1569–1585.

6 MANUSCRITO 2

Ana Caroline Pereira da Silva MAMEDE¹; Carlúcia Ithamar Fernandes FRANCO¹.

¹ *Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde (PPGPS) - Universidade Estadual da Paraíba, 351 Baraúnas St., Bodocongó, Campina Grande-PB, 58429-500, BR*

Corresponding author: acpsilva02@gmail.com/ ana.caroline.silva@aluno.uepb.edu.br

COM O PASSAR DA MENTE: ESTADO EMOCIONAL E QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS IDOSAS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS

RESUMO

O acelerado envelhecimento populacional brasileiro demanda a adoção de estratégias que promovam saúde, autonomia e bem-estar na pessoa idosa. Este estudo teve como objetivo investigar o perfil cognitivo, estado emocional e a percepção da qualidade de vida em pessoas idosas praticantes de atividades artístico-culturais. Trata-se de uma pesquisa transversal, de abordagem quali-quantitativa, na qual foram analisadas informações sociodemográficas e condições de saúde por meio da *Checklist* da CIF - Adaptada, além da avaliação da cognição (Mini Exame do Estado Mental (MEEM), estado emocional (Inventário de Depressão de Beck – [BDI-II] / Escala de Ansiedade de Hamilton [HAM-A]) e da percepção da qualidade de vida (WHOQOL-BREF). Os resultados sugerem que os praticantes de instrumentos musicais apresentaram menores escores de sintomas depressivos e ansiosos. Ademais, os participantes de ambos os grupos obtiveram níveis satisfatórios de percepção de qualidade de vida, com benefícios específicos conforme a modalidade artística; além de possível declínio cognitivo leve em ambos os grupos. A prática da dança esteve associada a maior satisfação com a saúde, vitalidade e ambiente doméstico, enquanto a prática de instrumentos musicais apresentou melhores indicadores de mobilidade, desempenho nas atividades da vida diária, suporte social e estabilidade emocional. Conclui-se que a participação em práticas artístico-culturais pode contribuir significativamente, para a cognição, bem-estar emocional e a qualidade de vida de pessoas idosas, reforçando a relevância dessas atividades como estratégias de promoção da saúde, socialização e envelhecimento ativo.

Palavras-chave: envelhecimento; qualidade de vida; saúde mental; saúde do idoso.

ABSTRACT

The rapid population aging in Brazil demands the adoption of strategies that promote health, autonomy, and well-being among older adults. This study aimed to investigate the cognitive profile, emotional status, and perceived quality of life (QoL) in older adults engaged in artistic and cultural activities. This is a cross-sectional study with a mixed-methods (qualitative and quantitative) approach, in which sociodemographic data and health conditions were analyzed using the adapted International Classification of Functioning Checklist (ICF Checklist), along with assessments of cognition (Mini-Mental State Examination – MMSE), emotional status (Beck Depression Inventory – BDI-II and Hamilton Anxiety Scale – HAM-A), and quality of life perception (WHOQOL-BREF). The results suggest that participants engaged in musical instrument practice presented lower levels of depressive and anxiety symptoms. Additionally, participants in both groups demonstrated satisfactory levels of perceived quality of life, with specific benefits according to the type of artistic activity, as well as indications of mild cognitive decline in both groups. Dance practice was associated with greater satisfaction regarding health, vitality, and home environment, whereas musical instrument practice showed better indicators of mobility, performance in activities of daily living, social support, and emotional stability. It is concluded that participation in artistic and cultural practices may significantly contribute to cognition, emotional well-being, and quality of life in older adults, reinforcing the relevance of these activities as strategies for health promotion, social engagement, and active aging.

Keywords: aging; quality of life; mental health; health of the elderly.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um fenômeno biológico, social e psicológico inerente à condição humana, caracterizado por um processo contínuo e progressivo de mudanças morfofuncionais que afetam o organismo e a adaptação do indivíduo ao meio (Neri, 2019). Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, a população brasileira de pessoas com 60 anos ou mais, perfaz aproximadamente 32,1 milhões de pessoas, representando cerca de 15,6% da população total do país (IBGE, 2022). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que, até 2050, o número de pessoas idosas chegue a 2 bilhões – aproximadamente o dobro da estimativa atual, o que torna urgente o debate sobre políticas públicas e práticas voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida (QV) nessa faixa etária (OMS, 2022).

O processo de envelhecimento, embora fisiológico, é frequentemente acompanhado por declínios físicos, cognitivos e emocionais que podem comprometer a autonomia, bem-estar e QV da pessoa idosa (Papalia & Feldman, 2020). Dentre as alterações que comprometem a QV nestas pessoas, destacam-se os declínios cognitivos, caracterizados por alterações em domínios como a velocidade de processamento, memória episódica, atenção e funções executivas (Zhang, Zhang & Gao, 2025). Evidências indicam que parte do declínio cognitivo pode ser atribuída a modificações neurobiológicas próprias do envelhecimento cerebral, como redução da plasticidade sináptica e alterações estruturais, enquanto fatores educacionais, estilos de vida ativos e engajamento social atuam como elementos protetores, favorecendo a manutenção da cognição ao longo da velhice (López-Higes et al., 2025; Zou et al., 2024).

Ademais, a saúde mental das pessoas idosas é de suma importância, uma vez que transtornos como depressão, ansiedade e declínio cognitivo têm alta prevalência nesta população e impactam diretamente a funcionalidade e o bem-estar subjetivo (Lima *et al.*, 2016; World Health Organization [WHO], 2021). Além disso, fatores psicossociais, como o suporte familiar, a participação em grupos sociais e o engajamento em atividades cognitivas e culturais, mostram-se fundamentais para a manutenção da saúde mental e da sensação de propósito de vida (Ferreira *et al.*, 2018).

No que concerne à depressão e ansiedade, especificamente, observam-se inúmeros mecanismos patogênicos oriundos principalmente da redução na liberação dos neurotransmissores nas sinapses neuronais, dentre eles a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. A diminuição da norepinefrina e dopamina estão relacionadas à perda de

energia, atenção, motivação e à perda do prazer. A serotonina conhecida como o neurotransmissor do bem estar, quando deplecionada estaria correlacionada aos estados ansiosos e a forte relação entre depressão e ansiedade (Martens-Mantai *et al.*, 2015).

Em pessoas idosas, a depressão afeta principalmente aqueles com doenças crônicas e comprometimento cognitivo, culminando por vezes em sofrimento psíquico, ruptura familiar e incapacidade funcional, além de piorar os resultados de diversas doenças e, conseqüentemente, aumentar a mortalidade (Alexopoulos, 2005). Além da depressão, estudos recentes associaram a ansiedade e seus distúrbios na pessoa idosa ao aumento da morbidade e mortalidade, especialmente, relacionados a uma maior carga cardiovascular, reduzindo a funcionalidade e aumentando o declínio cognitivo (Andreescu e Lee, 2020).

A ansiedade em pessoas idosas constitui um importante problema de saúde pública, frequentemente subdiagnosticado e subtratado, apesar de sua alta prevalência nessa faixa etária. Estudos indicam que sintomas ansiosos são comuns durante o envelhecimento, podendo resultar de múltiplos fatores, como perdas afetivas, declínio funcional, doenças crônicas, isolamento social e medo da dependência ou da morte (Blazer, 2020; Gonçalves & Andrade, 2021).

Esses sintomas interferem significativamente na QV, comprometendo o sono, o apetite, a cognição e a interação social da pessoa idosa (Beekman *et al.*, 2015). Além disso, a ansiedade tende a coexistir com outras condições psiquiátricas, como depressão, o que dificulta o diagnóstico diferencial e o manejo clínico (Lenze *et al.*, 2019). Evidências mostram que estratégias psicossociais — como o fortalecimento de vínculos sociais, a prática regular de atividade física e o envolvimento em atividades culturais ou artísticas — têm efeito protetor sob a saúde mental, reduzindo níveis de ansiedade e favorecendo o envelhecimento ativo e equilibrado (Ferreira *et al.*, 2018; [WHO], 2021).

Ademais, observou-se que dentre as maiores preocupações das pessoas idosas ativas, estão a solidão e o esquecimento diário, estudos sugeriram que os transtornos afetivos e depressivos têm um impacto negativo na QV (Hussenoeder, *et al.*, 2020). De igual modo, a interação e o apoio social estão relacionados à satisfação com a vida e ao bem-estar físico e mental (Marsillas, *et al.*, 2017), e que as relações sociais adequadas podem determinar o sucesso pessoal associado à felicidade e QV (Lés, *et al.*, 2019; Leon, Mangin e Ballesteros, 2020; Gargaccio, *et al.*, 2022).

Estudos prévios mostraram que intervenções psicossociais e atividades de lazer, como dança, música, artesanato e prática de instrumentos musicais, exercem papel protetor sobre o bem-estar emocional e cognitivo de pessoas idosas, favorecendo o envelhecimento ativo (Tavares *et al.*, 2021; Oliveira & Santos, 2022). Essas atividades estimulam a neuroplasticidade, promovem interação social e fortalecem o senso de pertencimento, elementos centrais para o enfrentamento de perdas típicas dessa fase (Silva & Neri, 2020).

Nesse contexto, a QV emerge como um indicador multidimensional que abrange aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais, refletindo a percepção do indivíduo sobre sua própria existência (Fleck *et al.*, 2008). A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1997) definiu QV como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais vive e em relação a seus objetivos, expectativas e preocupações.

A qualidade de vida constitui, portanto, um desfecho central em saúde, sendo compreendida não apenas como um indicador de bem-estar, mas também como o objetivo último das intervenções em saúde. Nesse contexto, a Psicologia da Saúde destaca-se por seu enfoque nos estilos de vida e no processo saúde–doença, buscando compreender de que modo variáveis psicológicas influenciam a manutenção da saúde, o desenvolvimento de agravos e os comportamentos a eles associados (Ribeiro, 2011).

Considerando a QV como um desfecho central em saúde e o enfoque da Psicologia da Saúde nos estilos de vida e nos fatores psicossociais envolvidos no processo saúde–doença, a prática da dança em pessoas idosas tem sido amplamente investigada como uma intervenção multidimensional capaz de promover benefícios físicos, cognitivos, emocionais e sociais. Evidências provenientes de ensaios clínicos e revisões sistemáticas indicam que programas regulares de dança estão associados à melhora do equilíbrio, da coordenação motora, da mobilidade funcional e da resistência muscular, contribuindo para a redução do risco de quedas e para o aumento da autoconfiança motora (Keogh *et al.*, 2009; Meng *et al.*, 2020). Além disso, a dança tem demonstrado efeitos positivos sobre a cognição, especialmente nos domínios da atenção, da memória e das funções executivas, sugerindo um potencial neuroprotetor, inclusive entre idosos com comprometimento cognitivo leve (Coubard *et al.*, 2011; Zhang *et al.*, 2021).

Neste aspecto as intervenções musicais também têm se mostrado uma alternativa com potencial auxiliar no tratamento das questões que afetam a saúde mental. Leubner e Hinterberger (2017) em seu estudo de revisão de pesquisas originais que utilizam música

como intervenção para tratar participantes com sintomas depressivos, analisaram 28 estudos com um total de 1.810 participantes que foram distinguidos entre a audição passiva de música (gravação de um CD ou música ao vivo), e cantar, tocar ou improvisar com instrumentos, obtendo como resultado que em 26 estudos, uma redução estatisticamente significativa nos níveis de Depressão foi encontrada ao longo do tempo no grupo experimental (intervenção musical), e que em particular, as pessoas idosas mostraram melhorias significativas quando ouviram música ou participaram de alguma atividade que envolvesse a música.

Ler música (partitura) e tocar um instrumento musical são atividades complexas que compreendem a integração motora e multissensorial (auditiva, visual e somatossensorial) de forma singular. A música também tem um impacto bem elucidado sob o Estado Emocional, podendo ser uma atividade motivadora. Por essas razões, o treinamento musical tornou-se uma atividade útil para estudar a plasticidade cerebral, podendo inclusive aumentar a espessura de estruturas corticais envolvidas nessa prática (Seinfeld *et al* 2013; Worcherch *et al* 2022).

Os Modelos Multidimensionais Globais de Envelhecimento Ativo fazem uso de modelos distintos, tais como: QV, cognição, saúde mental e autoavaliação da saúde física; saúde física, suporte social, saúde psicológica e a prática de atividades de lazer; ambientes favoráveis ao envelhecimento, dentre outros (Hsu, 2020; Gargaccio, *et al*, 2022). Do ponto de vista psicossocial, a participação em grupos de atividades artísticas e culturais promove interação social, intergeracionalidade, expressividade emocional e bem-estar subjetivo, reduzindo sintomas de depressão e ansiedade (Eyigor *et al.*, 2009; Hui *et al.*, 2009). Tais evidências reforçam que as atividades artísticas e culturais são uma estratégia não farmacológica eficaz para o envelhecimento ativo, pois integra movimento, cognição e afetividade (Kattenstroth *et al.*, 2013; Rehfeld *et al.*, 2018).

Nesse sentido, compreender a percepção da qualidade de vida, bem como os aspectos da saúde mental da população idosa e os fatores que os influenciam, mostra-se fundamental para orientar a efetividade, a funcionalidade e a adequação das Políticas Públicas em Saúde às demandas reais do envelhecimento no contexto brasileiro. Assim, torna-se pertinente investigar de que maneira os múltiplos aspectos do envelhecimento — incluindo fatores individuais, sociais e culturais — interferem na qualidade de vida e na saúde mental de pessoas idosas. Tal compreensão pode subsidiar a formulação e o aprimoramento de políticas públicas, intervenções comunitárias e práticas profissionais

voltadas à promoção do envelhecimento ativo, da autonomia e da saúde integral da pessoa idosa.

Apesar do crescente interesse na temática, ainda são limitadas as investigações que avaliam de forma integrada a cognição, o estado emocional e a qualidade de vida em pessoas idosas praticantes de atividades artístico-culturais, especialmente no contexto brasileiro. Assim, torna-se relevante desenvolver estudos que explorem essas relações de maneira conjunta, contribuindo para o fortalecimento do corpo de evidências científicas e subsidiando a formulação de políticas públicas, programas comunitários e práticas profissionais voltadas à promoção do envelhecimento ativo, saudável e socialmente participativo.

OBJETIVOS

Geral

Investigar a correlação entre cognição, estado emocional e a percepção da qualidade de vida em pessoas idosas praticantes de atividades artístico-culturais.

Específicos

- Caracterizar as informações sociodemográficas e situação de saúde;
- Avaliar o perfil da Cognição; Estado Emocional; e a percepção da QV;
- Avaliar a correlação entre o Estado Emocional e a QV;
- Avaliar a correlação entre a Cognição e a QV;

METODOLOGIA

Tipo de Pesquisa

Esta pesquisa foi realizada segundo uma abordagem qualiquantitativa, através de estudo transversal, populacional.

Delimitação dos Participantes da Pesquisa

A amostra foi não probabilística, dada por acessibilidade (Setia, 2016; Andrade, 2021) e composta por pessoas idosas participantes de Atividades Artístico-Culturais do CAC da ProCult/UEPB, compondo 39 participantes.

“O pesquisador recruta os participantes que são facilmente acessíveis em um ambiente clínico (...). Além disso, em tal ambiente clínico, o pesquisador abordará todos os pacientes que encontrar. Eles são

informados sobre o estudo e todos aqueles que consentem em participar do estudo são avaliados quanto à elegibilidade. Se eles atenderem aos critérios de inclusão (e não precisarem ser excluídos de acordo com os critérios), eles serão recrutados para o estudo.” (Setia, 2016).

CrITÉRIOS de Inclusão

- IndivÍduos com 60 anos ou mais, do sexo feminino e do sexo masculino;
- Participantes de atividades artístico-culturais do CAC/UEPB;

CrITÉRIOS de Exclusão

Serão excluídos os idosos que apresentarem os seguintes aspectos:

- Disfunção visual, auditiva, linguagem e/ ou funcional que impedissem a realização dos instrumentos;
- Patologias psiquiátricas associadas que impedissem a realização dos instrumentos.

Local de Realização da Pesquisa

Foi realizada na sede do Centro Artístico Cultural (CAC) da ProCult/UEPB, na Avenida Getúlio Vargas, Nº44, Centro de Campina Grande/PB.

O Centro Artístico e Cultural da Universidade Estadual da Paraíba (CAC/UEPB) configura-se como um importante espaço de promoção da cultura, da educação e da inclusão social, integrando ações de ensino, pesquisa e extensão. Por meio da oferta de oficinas e atividades artístico-culturais, como dança, música, teatro e artes visuais, o centro proporciona oportunidades de expressão, aprendizado e socialização para diferentes públicos, com destaque para a população idosa. Nesse contexto, o CAC/UEPB desempenha papel relevante na promoção da saúde e do bem-estar, ao estimular aspectos cognitivos, emocionais e funcionais dos participantes, além de fortalecer vínculos sociais e valorizar as experiências e trajetórias de vida dos indivíduos envolvidos.

Instrumentos de Coleta de Dados

Para realização da Pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos:

- **Checklist da CIF- Adaptada** ; Trata-se de uma *Checklist* das categorias principais da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde. Consiste de uma ferramenta prática para extrair

e registrar informação sobre a funcionalidade e a incapacidade de um indivíduo. Foi utilizado nesta pesquisa as partes da *Checklist* que referem-se à Informação Sociodemográfica e Situação de Saúde (*Checklist* da CIF © OMS, Setembro 2003). (Apêndice 1).

- ***Mini Exame de Estado Mental (MEEM)*** – É um teste de triagem amplamente utilizado para avaliar a função cognitiva por ser rápido, de fácil aplicação, não requerendo material específico. Avalia os seguintes domínios: orientação espacial, temporal, memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho. O MEEM é um somatório de pontos de 7 categorias que podem variar de 0 a 30, sendo os maiores escores relacionados a melhores desempenhos cognitivos (pontos de corte para esta pesquisa: 20 pontos para aletrados; 25 pontos para idosos com um a quatro anos de estudo; 26,5 pontos para idosos com cinco a oito anos de estudo; 28 pontos para aqueles com 9 a 11 anos de estudo 29 pontos para aqueles com mais de 11 anos de estudo - Bruck *et al*, 2003) (Fostein *et al*. 1975). (Anexo 1).
- ***Inventário de Depressão de Beck (BDI-II)*** - Consiste de uma escala de auto-relato, para levantamento da intensidade dos sintomas depressivos, composta por 21 itens e é um instrumento utilizado tanto para mensuração da depressão em pacientes psiquiátricos como na população em geral. A primeira versão do Inventário de Depressão de Beck (BDI) foi desenvolvida por Beck, Ward, Mendelson, Moch e Erbaugh em 1961, tendo sido adaptada à população brasileira por Cunha em 2001. Sua referência é o consenso clínico sobre os sintomas diagnósticos da depressão definidos pelo DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) (Gandini, *et al*, 2007). (Anexo 2)
- ***Escala de Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)*** - Instrumento utilizado para identificação do grau de sinais de ansiedade, desenvolvida por Max Hamilton (1959), é um método de análise objetiva da ansiedade de fácil aplicação e amplamente disponível, composta por 14 itens. Constitui uma medida explícita, ou seja, depende do auto relato do indivíduo (Hamilton, 1959). (Anexo 3).
- ***World Health Organization Quality of Life” – BREF (WHOQOL – BREF)*** - Trata-se da versão abreviada do instrumento de avaliação da percepção de qualidade de vida desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Composto por 26 itens, ele abrange quatro domínios: físico, psicológico, relações

sociais e meio ambiente. (Fleck et al, 2000 - Referência da versão validada para o Brasil) (Anexo 3).

Procedimentos de Coleta de Dados

Visando melhor organização das atividades a serem executadas na pesquisa, o procedimento de coleta de dados será dividido em quatro etapas:

- **Etapa I:** Apresentação da Pesquisa e assinatura do Termo de Autorização Institucional para Uso e Coleta de Dados em Arquivos (TAICDA) por parte da Coordenadora do CAC da PROCULT/UEPB, e, uma vez que, a equipe de pesquisa tendo acesso a lista de matriculados no CAC com seus contatos de email e/ou telefone, os participantes das CAC serão convidados para participar da pesquisa. Prosseguindo, foi realizada a apresentação da pesquisa aos participantes das atividades artísticas do CAC e apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
- **Etapa II:** Após anuência ao TCLE foram aplicados os instrumentos: *Checklist* da CIF– Modificado (Informação Socioemográfica e Situação de Saúde); Mini Exame de Estado Mental (MEEM).
- **Etapa III:** Aplicação do instrumento BDI-II;
- **Etapa IV:** Aplicação do instrumento HAM-A;
- **Etapa V:** Aplicação do instrumento *World Health Organization Quality of Life* – *BREF (WHOQOL – BREF)*

Análise dos Dados

Os dados obtidos foram analisados por meio da Estatística Descritiva. As variáveis qualitativas nominais foram expressas em frequência e porcentagem e apresentadas por meio de gráficos e tabelas; as variáveis qualitativas ordinais foram apresentadas através de porcentagem e mediana, por meio de gráficos e *Boxplot*, respectivamente; para as variáveis quantitativas contínuas foi feito a média, desvio padrão e erro padrão da média; por fim, as variáveis quantitativas discretas foram analisadas por meio do teste ANOVA e Teste de Médias. Para as análises específicas foram feitas Análises Multivariadas, através da Análise de Componentes Principais (PCA).

As análises quantitativas foram processados através do *Software* estatístico *Palaeontological Statistics* (PaSt), versão 1.81 (Hammer et al., 2008).

Aspectos Éticos da Pesquisa

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB (CEP-UEPB) e, qualquer coleta de dados só foi realizada mediante a aprovação do projeto por parte do CEP-UEPB. Os participantes receberam explicações a respeito do estudo e, ao concordarem com a participação, preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme a Resolução N° 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde/MS que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos informando e garantido a confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos.

O participante da pesquisa recebeu pessoalmente o TCLE e após preenchimento deste em concordância com a participação, incluído na pesquisa. O Registro de Aceite do TCLE foi fornecidos mediante preenchimento de formulário nas salas de aulas do CAC/UEPB, a via do participante foi ofertada mediante cópia das respostas no momento seguinte em que respondeu ao questionário.

Ressalta-se que o convite para participar da pesquisa foi individual e esclarecido ao candidato a participante de pesquisa, os riscos e benefícios da mesma, a saber os riscos mínimos de cansaço ao responder aos questionários, o que seria minimizado pela divisão da coleta de dados em etapas, assim como o risco de que as perguntas de determinados testes pudessem trazer ao participante emoções delicadas/negativas, sendo esclarecido que nenhuma pergunta era de resposta obrigatória e que ele poderia retirar-se da pesquisa a qualquer momento caso se sentisse desconfortável. No que concerne os benefícios, para o participante: poder conhecer, por meio da resposta a instrumentos validados, como encontrava-se seu perfil cognitivo, estado emocional e percepção de qualidade de vida; e para a comunidade científica, contribuir na realização da pesquisa com dados que podem nortear futuras intervenções nos domínios estudados. Antes de responder às perguntas do pesquisador, era necessário a sua anuência ao TCLE, desta forma o participante de pesquisa teve acesso às perguntas somente depois de dado o seu consentimento.

Tendo em vista que os dados (*Email/Telefone*) para acesso aos participantes foram adquiridos junto à Coordenação do CAC da PROCULT/UEPB, os pesquisadores responsáveis também garantiram a assinatura do Termo De Autorização Institucional Para Uso e Coleta De Dados Em Arquivos (TAICDA). Visando garantir a total confidencialidade dos contatos dos participantes, estes ficaram em posse apenas dos pesquisadores responsáveis, sem haver qualquer tipo

de divulgação externa destes dados. É do conhecimento dos pesquisadores que o acesso não autorizado a essas informações caracteriza uma violação de dados, resultando em roubo de identidade ou violação de requisitos de conformidade frente ao governo ou a setores regulatórios.

Foi garantido ao participante de pesquisa o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo também se retirar da pesquisa a qualquer momento. Visando resguardar a confiabilidade dos participantes, os dados publicados serão com a utilização de um sistema de classificação alfanumérico (letras, números), não contendo nome dos participantes e a divulgação dos resultados será feita em eventos e/o publicações.

Foi assinado, o Termo de Compromisso do Pesquisador Responsável, em que o mesmo assume cumprir fielmente as diretrizes regulamentadoras emanadas das Resoluções Nº 466/12 e No 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, ao (s) sujeito(s) da pesquisa e do Estado. O pesquisador responsável também assinou a Declaração de Concordância com Projeto de Pesquisa, em que compromete-se verificar o desenvolvimento do projeto e cumprir os itens dispostos na Resolução Nº466 sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos. Quanto à autorização do local para realização da pesquisa, foi assinado o Termo de Autorização Institucional (TAI) pelo (a) responsável pela ProCult/UEPB, além da assinatura do Termo de Autorização Institucional para Uso e Coleta de Dados em Arquivos (TAICDA) por parte da Coordenadora do CAC da ProCult/UEPB.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Análise do perfil sociodemográfico através da *Checklist* da CIF Adaptada em Pessoas Idosas Participantes de Atividades Artísticas Culturais

Após a análise dos dados, constatou-se a participação de 39 pessoas idosas na pesquisa, as quais, após esclarecimento e consentimento por meio do TCLE, responderam à Checklist da CIF Adaptada, instrumento que abrangeu informações sociodemográficas e condições de saúde. Observou-se predominância do sexo feminino e de indivíduos autodeclarados brancos, conforme apresentado na Tabela 9. Os participantes estavam distribuídos em duas modalidades de atividades artístico-culturais: dança e prática de instrumentos musicais. Entre os praticantes de dança, 6,9% eram do sexo masculino e 93,1% do sexo feminino; já entre os participantes das atividades com instrumentos musicais, 20% eram homens e 80% mulheres.

Tabela 9 *Caracterização das Informações Sociodemográficas*

Variável	Categoria	Frequência (n)	(%)
Sexo	Feminino	35	89,74
	Masculino	4	10,26
Cor	Branca	22	56,41
	Parda	17	43,59
Moradia	Própria	32	80,05
	Alugada	7	17,95

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Os achados desta pesquisa, no que se refere à distribuição por sexo dos participantes, estão em consonância com os dados apresentados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2023), os quais apontam para a persistente feminização do envelhecimento no país. Esse cenário pode ser parcialmente explicado pela maior expectativa de vida das mulheres, que, em média, vivem entre cinco e sete anos a mais que os homens. Essa diferença impacta diretamente a estrutura etária da população brasileira. De acordo com o Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2022), entre os indivíduos com 60 anos ou mais, as mulheres correspondem a 56% da população (17,8 milhões), enquanto os homens representam 44% (14,2 milhões), reforçando a predominância feminina nas faixas etárias mais avançadas.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2020) ressalta que condições inadequadas de moradia — como instabilidade residencial, custo excessivo com aluguel e exposição a ambientes inseguros — estão associadas a pior qualidade de vida, maior risco de isolamento social, declínio cognitivo e distúrbios do sono. No que diz respeito aos dados obtidos acerca da moradia, os dados dessa pesquisa mostram-se relevantes, uma vez que estudos nacionais, como o de Camarano e Kanso (2021), destacaram que pessoas idosas que vivem de aluguel e dependem de renda fixa são mais suscetíveis à insegurança habitacional e às repercussões negativas sobre a saúde. Essas informações reforçam a importância social do elevado percentual de moradores proprietários encontrado nos participantes desta pesquisa, que reflete um aspecto positivo concernente aos Determinantes Sociais em Saúde (DSS).

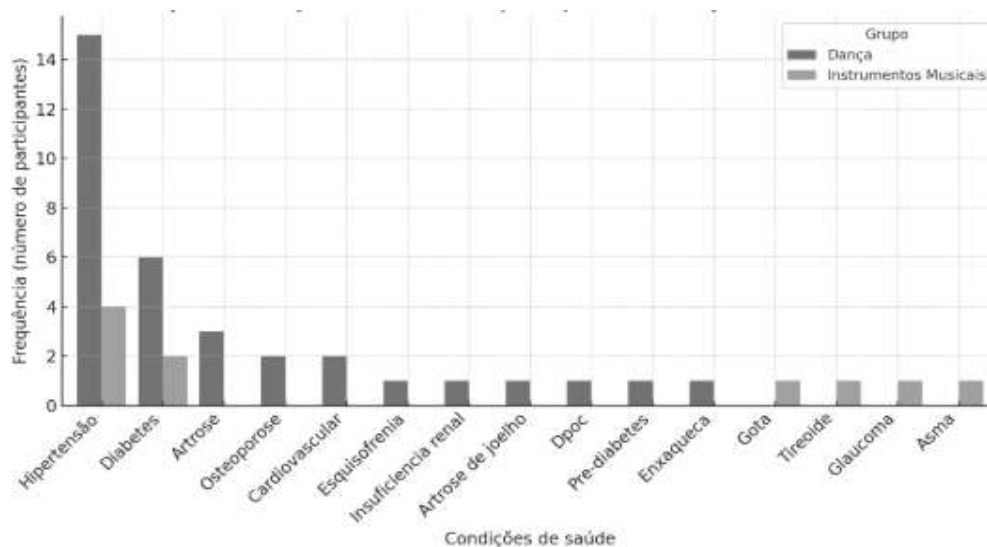
A média de idade dos participantes foi de 70,71 anos, o que os caracteriza, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), como idosos. Entretanto, o grupo contemplou indivíduos entre 60 e 88 anos, a mediana de 69,5 anos e o desvio padrão de 7,093 indicam uma distribuição etária relativamente homogênea. Dentre os que praticavam Dança, a média de idade foi de 70,8 anos; para aqueles que praticavam instrumentos musicais a média de idade ficou em 69,7. Estudos prévios com populações idosas engajadas em atividades físicas, culturais ou sociais apresentam perfil semelhante. A metanálise conduzida por Rehfeld *et al.* (2018) sobre intervenções baseadas em dança com pessoas idosas evidenciaram médias etárias próximas a 70 anos e predominância feminina entre os participantes, o que converge com os resultados observados nesta pesquisa. Do mesmo modo, a Organização das Nações Unidas (ONU) (2020) destacou que mulheres tendem a participar mais de atividades comunitárias e culturais na velhice, o que também se reflete na maior proporção feminina neste estudo.

Análise da Situação de saúde através da Checklist da CIF-Adaptada em Pessoas Idosas Participantes de Atividades Artísticas Culturais

Para as etapas subsequentes da análise dos dados, os participantes foram organizados em dois grupos. O Grupo 1 (Dança) foi composto pelas pessoas idosas que participavam de alguma modalidade de dança como atividade artístico-cultural, totalizando 29 integrantes, o Grupo 2 (Instrumentos Musicais) reuniu os participantes envolvidos em aulas de aprendizagem e prática instrumental, contabilizando 10 indivíduos, sendo oito matriculados em aula de violão e dois em aula de pandeiro.

No que se refere a situação de saúde, especificamente à presença de doenças crônicas, a Hipertensão Arterial (HAS) foi a doença com maior prevalência nos dois grupos (Grupo 1: 48,27%; Grupo 2: 40%) seguida pela *Diabetes Mellitus* (DM) (Grupo 1: 24,13%; Grupo 2: 20%), conforme observa-se no **Gráfico 6**.

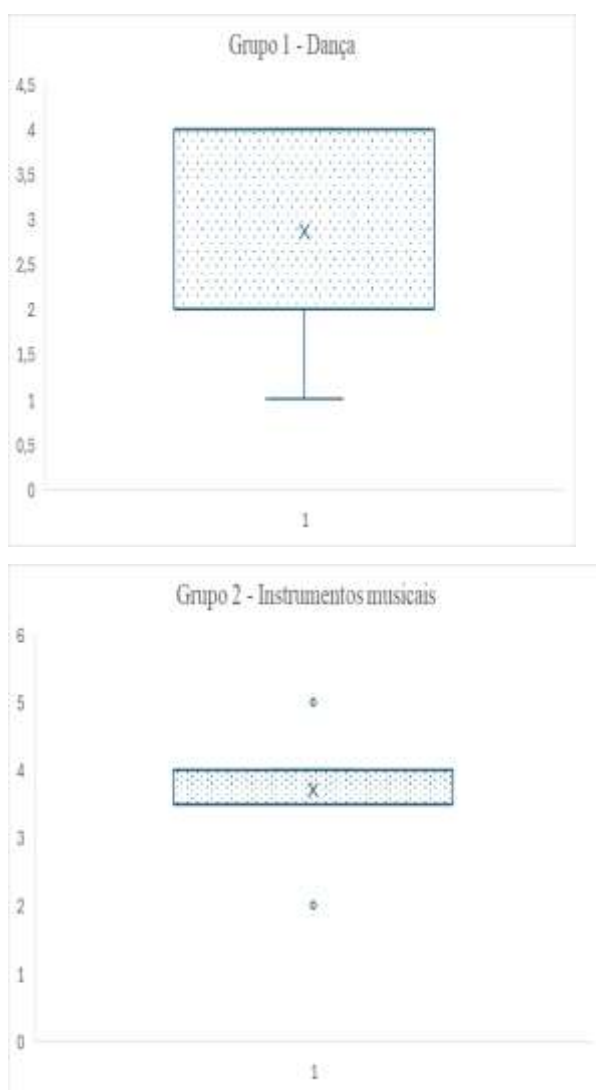
Gráfico 6 Distribuição de Condição de saúde



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Estudos científicos recentes evidenciam a existência de uma relação bidirecional e consistente entre doenças cardiometabólicas crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM), e a presença de transtornos mentais comuns, especialmente ansiedade e depressão. Pesquisas de caráter observacional e longitudinal demonstram que indivíduos acometidos por HAS e DM apresentam maior frequência e risco de desenvolver sintomas ansiosos e depressivos. Em contrapartida, tais manifestações estão associadas a um controle menos eficaz dos níveis pressóricos e glicêmicos, redução na adesão ao tratamento e aumento da ocorrência de complicações clínicas (Mezuk et al., 2020; Atlantis & Baker, 2021; Hackett & Steptoe, 2022).

Desta forma, os participantes da pesquisa também foram questionados acerca da sua autopercepção de saúde mental, como observado no **Gráfico 7**.

Gráfico 7 Avaliação da Autopercepção de Saúde Mental

Legenda: Escore: 1 = Ruim= 1/ Regular=2/ Moderada=3/ Boa=4/ Muito Boa=5)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

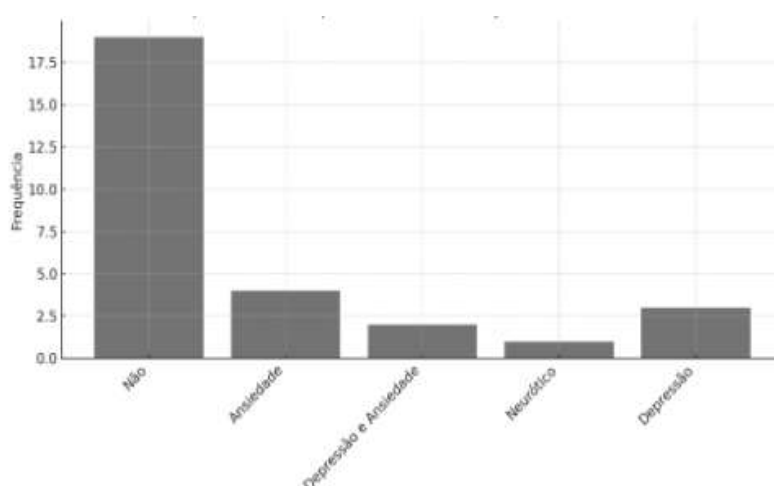
Os resultados evidenciam que as pessoas idosas de ambos os grupos apresentaram autopercepção de saúde mental predominantemente positiva, embora com padrões distintos de dispersão. Dentre as pessoas idosas do Grupo 1 (Dança), observou-se maior variabilidade das respostas, com valores oscilando entre 1 (Ruim) e 4 (Boa), e a média estando em 3. Esse comportamento sugere que, apesar da heterogeneidade inicial, a participação em atividades de dança tende a favorecer estados emocionais e percepção de bem-estar. Similarmente, estudos verificaram benefícios da dança para regulação emocional, autoestima e redução de sintomas depressivos em pessoas idosas (Keogh et al., 2020; Pereira et al., 2021).

Por outro lado, as pessoas idosas do Grupo 2 (Instrumentos Musicais) apresentaram distribuição mais homogênea, com a maioria dos participantes relatando

saúde mental “Boa”, com baixos valores extremos e média de 3,5. Concomitantemente, pesquisas mostraram que o engajamento musical pode promover maior estabilidade emocional, redução de estresse e fortalecimento cognitivo, favorecendo autopercepções mais consistentes entre os participantes (Creech *et al.*, 2016; Franco *et al.*, 2021). Assim, as evidências do presente estudo corroboram achados prévios ao demonstrar que práticas artísticas — embora com dinâmicas diferentes — contribuem para percepções positivas de saúde mental entre pessoas idosas, reforçando o papel dessas atividades na promoção do bem-estar psicológico e da QV.

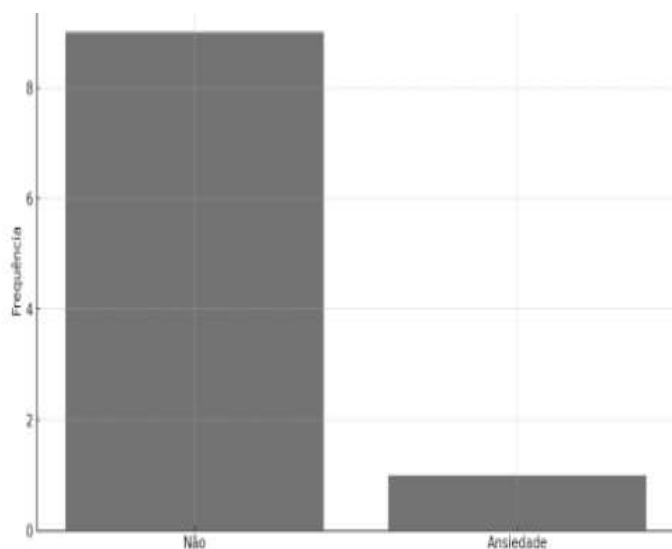
Quando questionados se possuíam diagnósticos médicos de transtornos mentais, os resultados podem ser observados no **Gráfico 8**. Evidenciou-se predominância destes diagnósticos nas pessoas idosas participantes de dança (Grupo 1), com prevalência para Ansiedade, seguido de Depressão e número expressivo de indivíduos com diagnóstico clínico de Ansiedade e Depressão. Por outro lado, observou-se que as pessoas idosas praticantes de instrumentação musical (Grupo 2), apenas um indivíduo relatou possuir ansiedade.

Gráfico 8 *Análise da Frequência de condições de Saúde Mental*
Dança



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Instrumentos Musicais



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Esses achados sugerem que os participantes envolvidos em atividades musicais apresentaram percepção mais estável e positiva do estado emocional, enquanto os praticantes de dança exibiram maior variabilidade, ainda que com presença expressiva de respostas indicando ausência de transtornos. Da mesma forma, estudos apontaram que a prática musical regular está associada à redução de sintomas depressivos e ansiosos, favorecendo regulação emocional, sensação de propósito e engajamento social mais estruturado (Creech *et al.*, 2016; Franco *et al.*, 2021).

Por outro lado, embora a dança também seja amplamente, reconhecida como promotora de bem-estar psicológico, melhora do humor e redução de estresse, estudos indicaram que grupos que buscam atividades de dança podem ter, inicialmente, maior heterogeneidade emocional e maior prevalência de sintomas leves a moderados, utilizando essas práticas como estratégia de enfrentamento e expressão afetiva (Keogh *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2021). Assim, os resultados do presente estudo dialogam com a literatura ao demonstrar que tanto a dança quanto a música desempenham papel relevante na saúde mental de pessoas idosas, embora com padrões distintos de impacto e perfil emocional dos participantes.

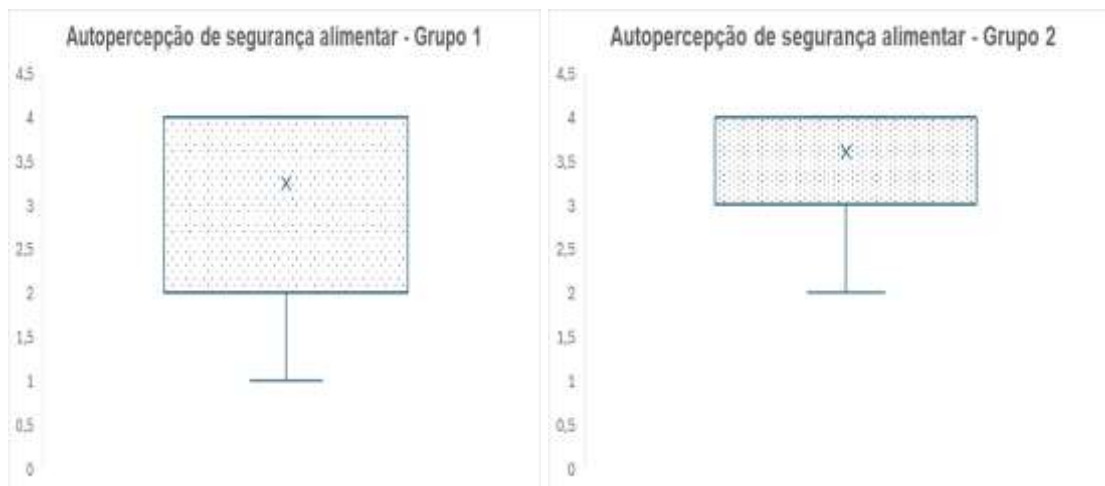
Determinantes sociais em saúde através da Checklist da CIF – Adaptada m Pessoas Idosas Participantes de Atividades Artísticos Culturais

Ao serem questionados sobre a percepção de segurança alimentar — um aspecto relevante no contexto da fragilidade da pessoa idosa e dos determinantes sociais da saúde (DSS) — observou-se que os participantes do Grupo 1 apresentaram média de 3,24,

situando-se entre moderada e boa. Já no Grupo 2, a média foi de 3,6, permanecendo na mesma faixa de classificação, porém mais próxima de uma condição considerada boa, enquanto o Grupo 1 se manteve mais próximo de moderada, conforme ilustrado no Gráfico 9.

Gráfico 9 *Auto Percepção de Segurança Alimentar*

(Referência: Mínimo de 3 refeições diárias nos últimos 30 dias antes da coleta dos dados)



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Legenda: Ruim= 1/ Regular=2/ Moderada=3/ Boa=4/ Muito Boa=5.

Pérez-Zepeda et al. (2016) categorizaram a segurança alimentar em quatro níveis — segurança, insegurança leve, moderada e grave — e identificaram que os níveis moderado e grave estão significativamente associados à fragilidade em pessoas idosas. Com base nessa classificação, observa-se que os participantes deste estudo se enquadram, em sua maioria, nas categorias de “segurança alimentar” ou “insegurança leve”. No contexto brasileiro, o direito à alimentação é assegurado pela Constituição Federal e respaldado pela Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, cabendo ao Estado a implementação de políticas públicas e ações que garantam esse direito à população.

Em relação ao acesso aos serviços de saúde, constatou-se que o uso do Sistema Único de Saúde (SUS) foi predominante em ambos os grupos, correspondendo a 65,61% no Grupo 1 e 80% no Grupo 2, enquanto os demais participantes relataram utilizar planos de saúde suplementares ou atendimento particular. Evidências da literatura indicam que pessoas idosas residentes em áreas urbanas tendem a utilizar mais os serviços formais de saúde, sendo o nível de escolaridade um fator determinante nesse processo, uma vez que maiores níveis de instrução favorecem a busca por cuidados de saúde (Travassos & Viacava, 2020; Costa et al., 2021). Esses achados estão em consonância com os resultados do presente estudo, reforçando a importância da escolaridade como variável relevante, conforme apresentado na Tabela 2.

Análise do Grau de Instrução das pessoas idosas através da Checklist da CIF – Adaptada m Pessoas Idosas Participantes de Atividades Artísticos Culturais

Conforme observa-se na **Tabela 10**, o perfil de instrução dos participantes é heterogêneo, não possui indivíduos aletrados, estando este perfil educacional entre pessoas idosas que possuem o ensino fundamental incompleto, até indivíduos que possuem pós graduação.

Tabela 10 *Distribuição de acordo com o Grau de Escolaridade*

Grau de Escolaridade	Frequência	
	Grupo 1 Dança	Grupo 2 Música
Aletrados	0	0
Fundamental Incompleto	4	4
Fundamental Completo	3	2
Médio Incompleto	2	0
Médio completo	8	2
Superior Incompleto	4	1
Superior Completo	7	1

Pós Graduação

1

0

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Após a análise do nível de escolaridade, conforme apresentado na Tabela 2, observa-se que, no Grupo 1, houve maior frequência de indivíduos com ensino médio completo (N=8), incluindo participantes com formação até o nível de pós-graduação. Já no Grupo 2, predominou o ensino fundamental incompleto (N=4), sendo o ensino superior o nível mais elevado identificado nesse grupo. Tais diferenças mostram-se relevantes, uma vez que a escolaridade configura-se como um dos determinantes sociais mais importantes no processo de envelhecimento, estando relacionada à autonomia, à participação social, à capacidade funcional e ao uso adequado dos serviços de saúde (Camargos et al., 2020; Mendes et al., 2021).

Após responderem a *Checklist* da CIF-Adaptada, os participantes responderam a mais quatro instrumentos de coleta de dados, conforme metodologia.

Análise estatística Quantitativa

Para prosseguir com a análise estatística destes instrumentos, os dados obtidos foram submetidos inicialmente ao estudo da Homocedasticidade das Variâncias por meio do Teste de *Levene* (Levene, 1960), conforme observa-se na Tabela 11.

Tabela 11 Avaliação da Homocedasticidade das Variâncias

Instrumentos	Fcalculado	Alfa	Ftabela	p-valor	Conclusão
MEEM	1,22	0,05	4,11	0,28	As Variâncias são homogêneas
WOQHOL	0,34	0,05	4,11	0,56	As Variâncias são homogêneas
BDI*	2,92	0,05	4,11	0,10	As Variâncias são homogêneas
HAMILTON	2,21	0,05	4,11	0,15	As Variâncias são homogêneas

Obs.:BDI* dados transformados em raiz quadrada.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A análise de homogeneidade das variâncias, realizada por meio do Teste de *Levene*, demonstrou que todos os domínios avaliados — MEEM, WHOOQOL-Bref, BDI (transformado por raiz quadrada) e HAM-A — apresentaram variâncias homogêneas entre os grupos. Os valores de p variaram entre 0,10 e 0,56, todos superiores ao nível de significância de 5%, indicando ausência de diferenças significativas na variabilidade dos

escores entre os grupos. Ademais, em todos os casos o $F_{\text{calculado}}$ permaneceu abaixo do valor crítico especificado ($F_{\text{tabela}} = 4,11$), confirmando a homocedasticidade dos dados.

Estudos apontam que a verificação da homogeneidade das variâncias é uma etapa essencial em estudos comparativos, especialmente quando se avaliam construtos complexos como cognição e sintomas depressivos, que podem apresentar grande variabilidade entre indivíduos idosos (Field, 2018; Tabachnick & Fidell, 2019). Observa-se, ainda, que a transformação dos dados do BDI foi eficaz para estabilizar a variância, procedimento comumente recomendado em situações de assimetria moderada ou dispersão irregular dos escores (Hair et al., 2020).

Estudo da Normalidade dos dados – Teste de *KOLMOGOROV-SMIRNOV*

Seguidamente, foi realizado o estudo da Normalidade dos dados, por meio do teste de *Kolmogorov-Smirnov* (KS) (Kolmogorov, 1933; Smirnov 1939;1948), conforme **Tabela 12**.

Tabela 12 *Teste de KOLMOGOROV-SMIRNOV*

Instrumentos	KS Calculado	Alfa	KS tabelado	Conclusão
MEEM	0,1729	0,05	0,2178	Amostra tem distribuição normal
WOQHOL	0,1287	0,05	0,2178	Amostra tem distribuição normal
BDI*	0,0799	0,05	0,2178	Amostra tem distribuição normal
HAMILTON	0,0879	0,05	0,2178	Amostra tem distribuição normal

Obs.:BDI* dados transformados em raiz quadrada - para a estabilização da variância e a redução da assimetria, reforçando a validade dos pressupostos estatísticos.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Os resultados do teste de normalidade de *Kolmogorov-Smirnov* (KS) indicaram que todos os domínios analisados através dos instrumentos: MEEM, WHOOQOL-BREF, BDI (transformado por raiz quadrada) e HAM-A — apresentaram distribuição compatível com a normalidade. Em todos os casos, o KS calculado apresentou valores inferiores ao KS tabelado (0,2178) ao nível de significância de 5%, confirmando que não há evidências estatísticas de que as amostras violem a suposição de normalidade. A análise dos

pressupostos estatísticos indicou que os dados apresentaram distribuição normal em todos os domínios avaliados, permitindo o uso de testes estatísticos paramétricos.

Correlação entre os domínios analisados – Cognição (MEEM), Estado emocional (BDI-II e HAM-A) e QV (WOOQHOL-Bref)

Ademais, foi realizado o estudo da Correlação entre os domínios, por meio do teste de Correlação de *Pearson*, para avaliar a relação linear entre as variáveis, conforme **Tabela 13**.

Tabela 13 *Análise da correlação das variáveis - Correlação de Pearson*

Instrumentos	MEEM	WOQHOL- BREF	BDI
WOQHOL- BREF	-0,041625		
BDI	-0,081908	-0,53717	
HAMILTON	0,044307	-0,56145	0,69871

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

De modo geral, observou-se que a maioria das correlações foram fracas, com exceção das relações entre o estado emocional e QV, que apresentaram coeficientes moderados a fortes.

No que se refere à cognição, as correlações com QV ($r = -0,04$) e Depressão ($r = -0,08$), ambas foram negativa e fraca. Na correlação da cognição com a Ansiedade ($r = 0,04$) foi positiva e fraca. Da mesma forma, verificou-se ausência de associação significativa entre desempenho cognitivo e as demais variáveis avaliadas. Esses achados sugerem que, nos participantes da pesquisa, a função cognitiva não variou de maneira consistente com os níveis de humor, ansiedade ou percepção de QV dos participantes, o que é compatível com estudos que apontam que, em idosos ativos e comunitários, a cognição frequentemente se mantém preservada independentemente de variações leves em indicadores emocionais (Souza *et al.*, 2021; Lima & Yassuda, 2020).

Por outro lado, verificou-se correlação negativa moderada entre Depressão e QV ($r = -0,54$) e entre Ansiedade e QV ($r = -0,56$). Esses valores indicam que escores mais altos de Depressão e Ansiedade se associam a pior percepção de QV. Essa relação é

amplamente documentada cientificamente, e destaca que sintomas psicológicos impactam diretamente os domínios físico, psicológico e social da QV de pessoas idosas (Oliveira & Silva, 2022; Santos *et al.*, 2020).

Além disso, a correlação dos sintomas de Depressão e Ansiedade apresentaram correlação positiva forte ($r = 0,69$), demonstrando que maiores níveis de sintomas depressivos estão relacionados a maiores níveis de ansiedade. A coexistência de sintomas depressivos e ansiosos é um fenômeno bem descrito em populações idosas, sendo frequentemente atribuída à sobreposição de fatores biológicos, psicossociais e comportamentais (Gomes *et al.*, 2021; Castro *et al.*, 2019).

Análise das Variâncias entre as médias dos Grupos para os Domínios analisados – ANOVA

Posteriormente, seguiu-se o estudo da análise das variâncias (ANOVA), utilizado para verificar se há diferenças significativas entre as médias dos praticantes de dança (Grupos 1) e os praticantes de instrumento musical (Grupo 2). Na Tabela 14, observa-se que a ANOVA constatou não haver diferença significativa entre os domínios, no entanto, percebe-se valores altos para o coeficiente de variação, demonstrando que existem dados discrepantes entre si, dentro dos domínios.

Tabela 14 *Análise de Variância*

Atividade/Instrum entos	MEEM	WOQHOL	BDI	HAMILTO N
Atividades Artísticas	1,5876 ns	280,46 ns	7,5383 ns	323,23 ns
Erro	5,2391	257,84	2,2314	104,12
p (fator)	0,585	0,303	0,074	0,086
CV%	8,89	17,20	39,15	56,37

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A ausência de significância estatística pode estar relacionada ao número de participantes, especialmente, no grupo 2 referente aos praticantes de instrumentos musicais, o que reduz o poder estatístico da ANOVA e dificulta a detecção de diferenças reais — fenômeno amplamente discutido na literatura metodológica (Field, 2020;

Campbell & Swinscow, 2019). Além disso, os coeficientes de variação (CV%) demonstraram variabilidade moderada a alta nos domínios psicológicos de Depressão (39,15%) e Ansiedade (56,37%), indicando grande heterogeneidade emocional entre os participantes, o que também pode ter contribuído para a ausência de significância.

Estudos mostram que tanto a dança quanto a prática musical são capazes de promover benefícios psicossociais e cognitivos de maneira semelhante em populações idosas, o que pode explicar a homogeneidade encontrada entre os grupos. Pesquisas apontam que atividades artísticas, independentemente, da modalidade, ativam mecanismos comuns de integração social, expressão emocional e estimulação cognitiva, favorecendo a saúde mental e o bem-estar geral (Chen et al., 2021; Franco et al., 2023; Li et al., 2022). Dessa forma, ainda que diferenças estatísticas não tenham sido observadas, os achados corroboram evidências de que distintos tipos de práticas artísticas podem gerar efeitos convergentes entre idosos ativos.

No conjunto, os resultados indicam que a modalidade artística praticada não foi um fator determinante para variações significativas nos domínios avaliados, sugerindo que a participação em atividades artísticas, seja dança ou música, pode favorecer benefícios similares na saúde cognitiva e emocional das pessoas idosas.

Análise Multivariada Análise de componentes Principais (ACP/PCA)

Para melhor explorar estas evidências, os dados foram submetidos a uma análise multivariada visando compreender os autovalores e autovetores, conforme observa-se na Tabela 7. A análise multivariada é um conjunto de métodos estatísticos utilizados quando o pesquisador deseja analisar simultaneamente duas ou mais variáveis em um mesmo modelo, considerando as relações, interdependências e padrões conjuntos entre elas. Diferentemente das análises univariadas (uma variável por vez) ou bivariadas (relação entre duas variáveis), a análise multivariada permite compreender fenômenos complexos de forma mais integrada, o que é especialmente relevante em pesquisas em saúde, psicologia e envelhecimento, nas quais múltiplos fatores atuam de maneira concomitante.

Em estudos com pessoas idosas, a análise multivariada permite examinar de forma integrada como cognição, estado emocional, condições clínicas e fatores sociodemográficos se relacionam entre si e contribuem para desfechos como qualidade de vida e funcionalidade. Assim, trata-se de uma abordagem essencial para a

compreensão de fenômenos multidimensionais, oferecendo uma visão mais abrangente e robusta dos dados analisados.

A Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada para examinar simultaneamente as relações entre cognição (MEEM), qualidade de vida (WHOQOL-bref) e sintomas depressivos, avaliados pelo BDI e pela Escala de Hamilton, identificando os principais eixos responsáveis pela variabilidade dos dados e reduzindo a complexidade do conjunto de variáveis analisadas.

Na Tabela 15 observa-se os resultados da Análise Multivariada com os dados desta pesquisa, em que nota-se que PC1 explica 81,26% da variância total, configurando-se como o principal eixo explicativo do modelo. O PC2 acrescenta 17,08%, elevando a variância explicada acumulada para aproximadamente 98,3%. Os PC3 e PC4 apresentam contribuição residual (<2%), indicando que os dois primeiros componentes são suficientes para representar adequadamente a estrutura dos dados. As cargas fatoriais (*loadings*) indicam o peso de cada variável em cada componente principal, permitindo identificar o significado conceitual de cada PC:

- WHOQOL-bref apresenta *loading* elevado e positivo, indicando que o PC1 representa essencialmente a qualidade de vida.
- A Escala de Hamilton contribui de forma negativa moderada, sugerindo que maiores níveis de sintomas depressivos estão associados a pior QV.
- O BDI e o MEEM apresentam contribuição mínima.

Desta forma, o PC1 pode ser interpretado como um eixo de bem-estar global, no qual melhor qualidade de vida se opõe à presença de sintomas ansiosos, captados pela Escala de Ansiedade de Hamilton. O PC2 é fortemente determinado pela Escala de Hamilton, caracterizando um eixo específico relacionado à intensidade dos sintomas ansiosos. Este padrão é frequentemente identificado em populações idosas, nas quais o bem-estar subjetivo e os sintomas emocionais apresentam forte interdependência (Fagerström & Borglin, 2021; Li *et al.*, 2022).

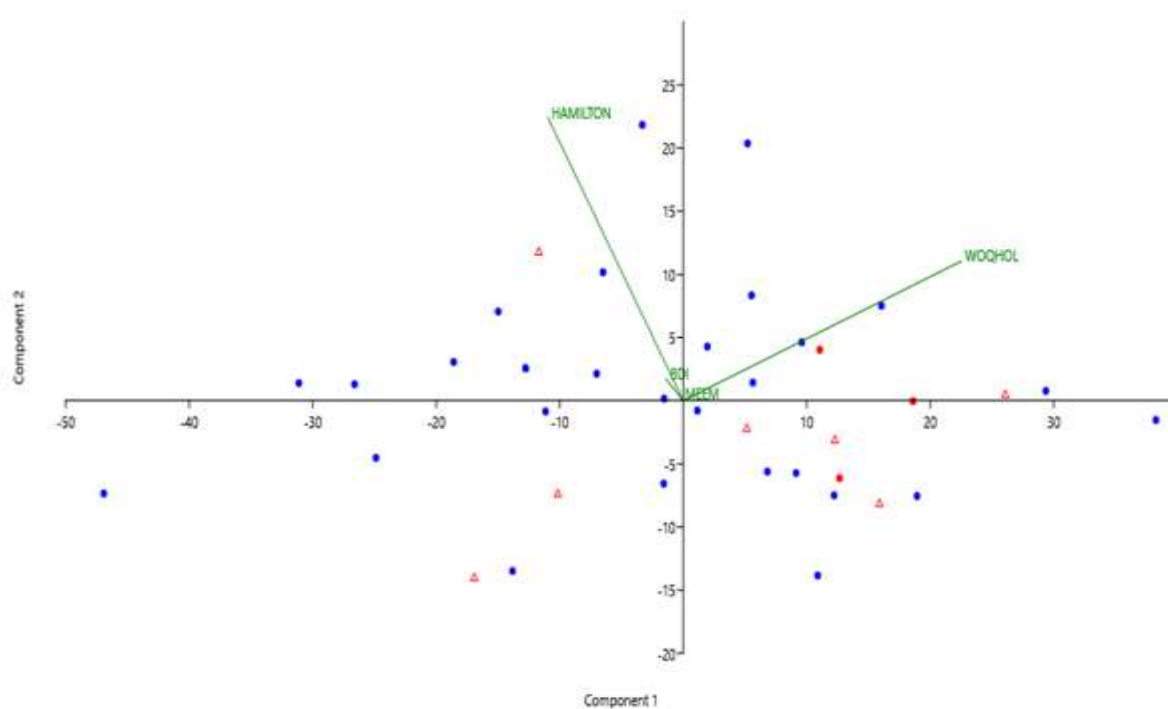
O gráfico de dispersão (*Scatter Plot*) demonstra sobreposição entre os grupos de dança e instrumentos musicais, sem formação de agrupamentos distintos ao longo dos principais componentes. Isso indica que não há separação multivariada clara entre as modalidades artísticas.

Tabela 15 *Análise Multivariada – Análise dos Componentes Principais (PCA)***SUMÁRIO**

PC	Eigenvalue	% variance
1	305,402	81,259
2	64,173	17,075
3	5,17185	1,3761
4	1,09222	0,29061

LOADINGS

	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4
MEEM	-0.0060177	0.0043105	0.99496	0.099968
WOQHOL	0.89745	0.44065	0.0014991	0.020102
BDI	-0.055683	0.068538	-0.10021	0.99104
HAMILTON	-0.43754	0.89505	0.0021436	-0.086267

SCATTER PLOT

Legenda: Azul/círculo: Grupo 1 (Dança); Vermelho/triângulo: Grupo 2 (Instrumentos musicais)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Em conjunto, os resultados do PCA indicam que o primeiro componente principal (PC1), fortemente associado aos escores do *WHOOQOL-Bref*, sugere que a qualidade de vida emerge como o eixo central de variabilidade da amostra. Esse achado corrobora a literatura que aponta a QV como um desfecho global e integrador da saúde no envelhecimento, refletindo não apenas condições físicas, mas também aspectos emocionais, sociais e funcionais. A expressiva contribuição da QV para a variância total indica que as experiências subjetivas relacionadas ao bem-estar desempenham papel fundamental na diferenciação dos participantes, independentemente do tipo de atividade artística praticada.

Seguindo, o segundo componente (PC2), predominantemente associado à ansiedade (HAM-A), evidencia a relevância do estado emocional na caracterização do perfil das pessoas idosas. A ansiedade, frequentemente subdiagnosticada nessa população, tem sido relacionada a pior percepção de saúde, menor engajamento social e redução da funcionalidade. A emergência desse componente de forma independente reforça a importância de considerar a saúde mental como dimensão central nos estudos sobre envelhecimento ativo, especialmente em contextos de práticas culturais e coletivas.

Essa análise multivariada reforça a natureza multidimensional da saúde da pessoa idosa, destacando como aspectos cognitivos, emocionais e de QV se relacionam, mas também preservam especificidades estruturais. Os achados são consistentes com pesquisas onde demonstraram que intervenções artísticas ou socioculturais tendem a impactar de maneira diferenciada dimensões emocionais, cognitivas e funcionais (Franco et al., 2023; Chen et al., 2021).

Análise de Sintomas Depressivos Atraves do Inventário de Depressão de Beck-II (BDI-II) em Pessoas Idosas Praticantes de Atividades Artísticos Culturais

A análise de sintomas depressivos foi realizada por meio do BDI-II conforme metodologia. Ressalta-se que para esta pesquisa o teste foi aplicado por uma psicóloga que fez parte da equipe de pesquisa. No instrumento a pontuação total (de 0 a 63) indica a intensidade da depressão, com pontuações mais altas associadas a sintomas mais graves.

Foi evidenciado que as pessoas idosas praticantes de dança (Grupo 1), composto por 29 participantes, apresentaram estado emocional heterogêneo com presença significativa de sofrimento psíquico. A média geral foi de 17,17 pontos, cujo valor sugere depressão leve segundo os critérios do instrumento. Essa média, entretanto, não representa uniformidade no grupo, uma vez que as pontuações individuais variaram amplamente entre 0 e 46 pontos, indicando perfis emocionais bastante distintos.

Relacionado a distribuição das pessoas idosas por níveis de gravidade, observou-se que 44,8% dos participantes apresentaram sintomas mínimos (0–13 pontos), evidenciando preservação relativa do bem-estar emocional. No entanto, 17,2% foram classificadas com depressão leve (14–19 pontos), 20,7% com depressão moderada (20–28 pontos) e 17,2% com depressão grave (29 ou mais pontos). Essa divisão mostra que mais da metade dos participantes do Grupo 1 (55,2%) apresentou algum grau de sintomatologia depressiva, e que 37,9% encontram-se nos níveis moderado e grave.

Os escores elevados, especialmente, nos níveis moderado e grave, sugerem impacto significativo no estado emocional e cotidiano desses indivíduos. As pontuações mais altas observadas, como as dos participantes que alcançaram entre 34 e 46 pontos, apontam para a possível presença de sentimentos intensificados de desesperança, autocrítica exacerbada, retraimento social e manifestações somáticas relevantes. Esses casos demandam atenção clínica especializada, considerando o risco aumentado de agravamento dos sintomas e possíveis prejuízos ao funcionamento global.

No que refere-se as pessoas idosas praticantes de instrumentos musicais (Grupo 2), verificou-se que a média foi 8,2 pontos por participante, situando o grupo na faixa de depressão mínima segundo os critérios de classificação estabelecidos pelo instrumento. A distribuição individual das pontuações variou entre 1 e 18 pontos, indicando que, embora a média geral seja baixa, há discrepância em relação à presença de sintomas depressivos. A maioria dos participantes apresentaram escores reduzidos, característicos de ausência ou mínima intensidade de sintomas depressivos. Entretanto, alguns casos específicos merecem destaque. O caso com maior pontuação (18 pontos) enquadra-se na categoria de depressão leve (14–19 pontos), sugerindo a presença de sintomas emocionais mais consistentes, como variações de humor, autocrítica, irritabilidade ou alterações somáticas perceptíveis.

Outros participantes deste grupo alcançaram pontuações entre 11 e 12 pontos, que, embora ainda dentro da classificação mínima, encontram-se próximos ao limiar superior, indicando vulnerabilidade para desenvolvimento de sintomas mais intensos, mediante

estímulos estressores. A análise da distribuição por níveis de gravidade revelou que 80% do grupo 2 apresentaram sintomas mínimos, enquanto 20% se enquadraram na categoria de depressão leve. Não foram identificados casos nas categorias de depressão moderada ou grave.

É importante destacar que a interpretação dos sinais e sintomas sugestivos de depressão através da BDI-II em populações idosas requer cautela, uma vez que podem estar relacionados a condições fisiológicas comuns à faixa etária, e não exclusivamente à depressão. Da mesma forma, aspectos culturais podem levar pessoas idosas a minimizar ou subnotificar emoções como tristeza ou desesperança, o que pode influenciar o padrão de respostas e, conseqüentemente, a pontuação final. Assim, a avaliação deve ser contextualizada, integrando elementos clínicos, sociais e funcionais.

As diferenças observadas entre os grupos podem ser explicadas, em parte, pelas características específicas de cada tipo de atividade por eles praticada. Estudos mostraram que a prática musical ativa, como tocar instrumentos, estimula múltiplos sistemas cerebrais — cognitivo, motor e emocional — contribuindo para melhor regulação do humor e fortalecimento da autoestima (Särkämö et al., 2014). Além disso, atividades musicais frequentemente favorecem evocação de memórias autobiográficas positivas e maior sensação de pertencimento, fatores associados à diminuição da sintomatologia depressiva em pessoas idosas (Cuddy et al., 2015).

Em relação à dança, embora esta seja reconhecida como prática promotora de bem-estar físico e emocional, seu impacto pode variar conforme a condição funcional dos participantes. Estudos demonstraram que atividades corporais intensas podem gerar frustração, especialmente em pessoas idosas com limitações motoras, dor crônica ou baixa capacidade de desempenho, influenciando negativamente a percepção emocional e aumentando pontuações em instrumentos de autorrelato como o BDI-II (Keogh et al., 2009).

Foi enfatizado que a dança apresenta importantes efeitos positivos para a saúde mental, sobretudo quando adaptada às condições físicas dos participantes, melhorando humor, mobilidade e interação social (Koch et al., 2014). Contudo, tais benefícios tendem a ser variáveis e dependentes do nível de esforço físico exigido e do perfil dos envolvidos, o que pode explicar a maior amplitude de pontuações encontrada no Grupo 1.

Portanto, quando comparados, as pessoas idosas dos Grupo 1 e do Grupo 2, observou-se perfis distintos: os participantes do grupo de instrumentos musicais mostraram menor variabilidade emocional e níveis reduzidos de depressão, enquanto que,

os participantes do grupo de dança apresentaram maior heterogeneidade e maior percentual de sintomas depressivos. Esses achados são coerentes com estudos, uma vez que, afirmaram que intervenções musicais tendem a produzir efeitos mais consistentes e estáveis na redução da depressão, enquanto, as intervenções com dança podem gerar benefícios amplos, porém mais dependentes de fatores físicos, motores e motivacionais (Fancourt & Finn, 2019).

Análise de Sintomas de Ansiedade através Escala de Ansiedade de Hamilton em Pessoas Idosas Praticantes de Atividades Artísticas Culturais

Os sintomas de Ansiedade foram interpretados com base na HAM-A, que considera escore com variação de 0 a 24, sendo classificadas da seguinte forma: ≤ 7 = mínima; 8–14 = leve; 15–23 = moderada; ≥ 24 = grave. Após análise dos sintomas de ansiedade, evidenciou-se diferenças relevantes entre os dois grupos avaliados. As pessoas idosas praticantes de Dança apresentaram maior intensidade de sintomas ansiosos, com média aproximada de 19,8 pontos e mediana de 21 pontos, valores compatíveis com a categoria clínica de ansiedade moderada, enquanto que, as pessoas idosas praticantes de Instrumentos Musicais apresentaram média de 13,2 pontos e mediana próxima de 11–12 pontos, situando-se predominantemente, na categoria de ansiedade leve.

Continuando, foi evidenciado que as pessoas idosas do Grupo 1 apresentaram maior amplitude e variabilidade dos escores, incluindo participantes com sintomas mínimos e outros com sintomas mais elevados, configurando maior heterogeneidade interna. Da mesma forma, observou-se que as pessoas idosas do Grupo 2, embora a Intensidade geral dos sintomas tenha sido menor, também foi identificado casos isolados com escores mais altos. Em síntese, sugere-se que no Grupo 1 concentra-se a maioria de participantes com estado emocional de ansiedade com potencial impacto sobre o cotidiano, enquanto que, os participantes do Grupo 2 apresentam, em sua maioria, escores menos elevados, sugerindo menor comprometimento funcional associado à ansiedade.

Estudos mostraram que a música reduz atividade fisiológica ligada ao estresse (Fancourt & Finn, 2019); diminui estados de ansiedade através de foco atencional, respiração cadenciada e regulação emocional (MacDonald et al., 2012); promove sensação de competência e pertencimento, com impacto direto no bem-estar (Hallam & Creech, 2016); melhora humor e reduz ansiedade em idosos, particularmente em atividades grupais (Cohen et al., 2006; Daykin et al., 2018). Dados estes, corroboram

fortemente com os resultados da pesquisa, no qual os praticantes de instrumentos apresentaram os menores escores de ansiedade entre os participantes avaliados, confirmando e reforçando a literatura, evidenciando que atividades musicais são eficazes na modulação emocional e no enfrentamento da ansiedade.

No que refere-se a dança, a literatura reforçou que contribui para a melhora da autoestima, humor e engajamento social (Keogh et al., 2009); reduz ansiedade e sintomas depressivos com a prática regular e prolongada (Koch et al., 2019; Cruz-Ferreira et al., 2015); favorece expressão corporal e integração grupal; porém também reforça que estes efeitos da dança são altamente dependentes do tempo de exposição, do tipo de dança, da familiaridade do praticante com movimentos corporais e do ambiente social do grupo (Burkhardt & Brennan, 2012). Desta forma, embora a dança seja uma atividade reconhecida por seus benefícios, os participantes que a praticavam apresentaram maiores níveis de ansiedade em comparação ao grupo musical, esse padrão não contradiz diretamente a literatura, mas reforça a ideia de que os efeitos da dança não são uniformes e podem variar amplamente.

Desta forma, sugere-se que futuras pesquisas considerem variáveis moderadoras, tais como o tipo de dança, tempo de prática, motivação, histórico clínico, contexto social, de forma a melhor compreender a funcionalidade da dança como uma estratégia não farmacológica para melhorar sintomas de ansiedade em pessoas idosas.

Análise da Percepção da Qualidade de Vida através Whooqol-Breff em Pessoas Idosas Praticantes de Atividades Artísticas Culturais

Conforme metodologia, para análise da QV foi utilizado o Whooqol-Breff, estando os resultados expressos no Quadro 3.

Quadro 3 *Análise da Distribuição da percepção da Qualidade de Vida (QV)*

Perguntas	Faceta	Grupo 1 ($\bar{x}$)	Grupo 2 ($\bar{x}$)
Como você avaliaria sua qualidade de vida?	Qualidade de vida	3,72	3,8
Quão satisfeito(a) você está com sua saúde?	Satisfação com a saúde	3,68	3,3
Em que medida a dor impede atividades?	Dor e desconforto	3,8	4,4

Dependência de medicação ou tratamento	Dependência de medicação	3	3,6
Você tem energia suficiente?	Energia e fadiga	3	3,6
Quão bem você é capaz de se locomover?	Mobilidade	4	4
Quão satisfeito(a) com seu sono?	Sono e repouso	3	3,6
Satisfação com atividades diárias	AVDs	3,4	4
Satisfação com capacidade de trabalho	Capacidade de trabalho	3,7	4
O quanto você aproveita a vida?	Aproveitamento da vida	3,7	3,3
Sua vida tem sentido?	Sentimentos positivos	3,8	4,2
Consegue se concentrar?	Pensar/memória	3,1	3,4
Aceitação da aparência física	Imagem corporal	3,6	3,9
Quão satisfeito(a) consigo mesmo?	Autoestima	3,3	3,3
Sentimentos negativos	Sentimentos negativos	4,1	4,3
Satisfação com relações pessoais	Relações pessoais	3	3,7
Satisfação com a vida sexual	Atividade sexual	3,8	4
Apoio social recebido	Suporte social	3,8	3,9
Sentimento de segurança	Segurança física	3,7	4,4
Ambiente físico saudável	Ambiente físico	3,9	4,2
Recursos financeiros suficientes	Recursos financeiros	2,8	2,7
Disponibilidade de informações	Informações e habilidades	3,4	4
Oportunidades de lazer	Lazer	3,6	3,9
Satisfação com ambiente no lar	Ambiente no lar	3,4	3,1
Acesso aos serviços de saúde	Acesso à saúde	3,6	3,7
Satisfação com transporte	Transporte	3,7	3,6

Legenda: 1= Muito ruim / Muito insatisfeito / Nunca; 2= Ruim / Insatisfeito / Pouco; 3= Regular / Nem ruim nem bom; 4= Bom / Satisfeito; 5= Muito bom / Muito satisfeito / Sempre

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A análise comparativa entre as pessoas idosas praticantes de dança (Grupo 1) e as pessoas idosas praticantes de em atividades musicais (Grupo 2) evidenciou diferenças

sutis, porém relevantes, nos domínios de QV. A análise das médias das facetas do WHOQOL-bref indica que ambos os grupos percebem sua qualidade de vida como predominantemente regular a boa, conforme a classificação proposta por Fleck et al. (2000). De modo geral, observa-se que o Grupo 2 (instrumentos musicais) apresentou médias ligeiramente superiores em maior número de facetas, especialmente nos domínios físico, social e ambiental, enquanto o Grupo 1 (dança) apresentou melhor percepção em aspectos relacionados à satisfação com a saúde e aproveitamento da vida.

No que refere a percepção de Qualidade de Vida Global, as pessoas idosas do Grupo 2 mostraram média ligeiramente superior (3,8) quando comparado ao Grupo 1 (3,72), sugerindo melhor percepção geral. Este achado converge com literatura que destaca que a participação em atividades musicais, sobretudo aquelas que requerem envolvimento ativo e cognitivo, está associada a maior engajamento com a vida, satisfação geral e bem-estar emocional em adultos e idosos (Coffman, 2020; Creech et al., 2014).

No tocante à Satisfação com a Saúde, as pessoas idosas do Grupo 1 apresentaram valores maiores (3,69) do que o Grupo 2 (3,3). Tal resultado pode refletir o impacto benéfico da dança sobre a percepção subjetiva de saúde, possivelmente devido a seus efeitos diretos sobre capacidade cardiorrespiratória, mobilidade global, equilíbrio e sensação de vitalidade, conforme amplamente evidenciado em ensaios clínicos e revisões sistemáticas (Keogh et al., 2019; Rodrigues-Krause, Krause & Reischak-Oliveira, 2019).

No domínio físico, observou-se bom desempenho em facetas como mobilidade, que apresentou média elevada e equivalente em ambos os grupos (4,0), indicando preservação da capacidade de locomoção. O Grupo 2 apresentou escores superiores em dor e desconforto, energia e fadiga e sono e repouso, sugerindo melhor percepção dessas condições físicas entre os participantes que praticam instrumentos musicais. Em contrapartida, a dependência de medicação ou tratamento apresentou valores moderados nos dois grupos, com médias ligeiramente mais altas no Grupo 2, o que pode refletir maior adaptação ao tratamento de condições crônicas.

No que se refere ao Domínio Psicológico, ambos os grupos apresentaram médias satisfatórias em aproveitamento da vida, sentimentos positivos, autoestima e imagem corporal, com destaque para o Grupo 2, que apresentou escores mais elevados em sentimentos positivos (4,2) e imagem corporal (3,9). A faceta pensar/memória apresentou médias moderadas em ambos os grupos, sugerindo percepção intermediária da função cognitiva autorreferida. Os sentimentos negativos apresentaram escores elevados nos dois

grupos ($\geq 4,1$), indicando menor impacto desses sentimentos na percepção de qualidade de vida, após a recodificação do item.

No Domínio Relações Sociais, o Grupo 2 apresentou médias superiores em relações pessoais, atividade sexual e suporte social, sugerindo maior satisfação com os vínculos interpessoais e com o apoio recebido. Ainda assim, o Grupo 1 também apresentou valores compatíveis com uma percepção positiva dessas relações, reforçando o papel das atividades coletivas no fortalecimento do convívio social.

Quanto ao Domínio Ambiental, ambos os grupos relataram boa percepção de segurança física, ambiente físico saudável, acesso aos serviços de saúde, transporte e oportunidades de lazer, com escores consistentemente mais altos no Grupo 2. Em contrapartida, a faceta recursos financeiros apresentou as menores médias em ambos os grupos (2,8 no Grupo 1 e 2,7 no Grupo 2), indicando uma percepção menos favorável dessa dimensão, o que é compatível com achados frequentes em populações idosas brasileiras. A satisfação com o ambiente no lar mostrou médias moderadas, ligeiramente superiores no Grupo 1.

Em síntese, evidenciou-se que a participação em atividades artístico-culturais está associada a uma percepção global positiva da qualidade de vida, com o Grupo 2 apresentando, de modo geral, escores ligeiramente superiores em diversos domínios, especialmente nos aspectos físicos, emocionais e ambientais. Esses achados reforçam o potencial dessas práticas como estratégias de promoção da qualidade de vida no envelhecimento.

CONCLUSÕES

O presente estudo investigou a relação entre cognição, estado emocional e qualidade de vida em pessoas idosas participantes de atividades artístico-culturais, especificamente, dança e prática instrumental. O perfil sociodemográfico dos participantes refletiu características recorrentes do envelhecimento no Brasil, como a feminização da velhice e a influência dos determinantes sociais na percepção de bem-estar. No que refere-se ao perfil cognitivo, verificou-se que mais de 50% dos participantes da pesquisa apresentaram sinais de declínio cognitivo leve; no que concerne a autopercepção de saúde, apesar da presença de doenças crônicas com HAS e DM ser predominante, os participantes da pesquisa em sua maioria referiram sua autopercepção de saúde como sendo de moderada a boa.

Quanto aos aspectos emocionais, ambos os grupos apresentaram percepção positiva da saúde mental, sendo observada maior estabilidade emocional no grupo de instrumentos musicais e maior variabilidade, incluindo maior prevalência de sintomas ansiosos e depressivos, no grupo de dança. A ausência de diferenças significativas entre os grupos sugere que, apesar das particularidades emocionais, as práticas artísticas apresentam impacto global semelhante sobre cognição, qualidade de vida e humor. Portanto, é possível concluir que a participação em atividades artístico-culturais mostrou-se favorável à promoção da saúde biopsicossocial da pessoa idosa, contribuindo para o engajamento social, a estimulação cognitiva e a regulação emocional, com nuances específicas entre dança e prática instrumental.

Diante desses achados, destaca-se a relevância de incorporar atividades artístico-culturais como estratégias interventivas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na atenção primária e nas políticas voltadas à saúde da pessoa idosa. A inclusão de oficinas de dança, música e outras práticas culturais em serviços como Centros de Convivência, Unidades Básicas de Saúde e programas de promoção do envelhecimento ativo pode contribuir para a prevenção de declínio cognitivo, redução de sintomas ansiosos e depressivos e fortalecimento da funcionalidade e autonomia. Além disso, tais intervenções apresentam baixo custo, potencial de alta adesão e favorecem a socialização, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa ao promover cuidado integral, prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida dessa população.

PERSPECTIVAS

Reconhece-se como principal limitação o tamanho reduzido da amostra, especialmente no grupo de instrumentos musicais, o que pode ter afetado o poder estatístico das análises. Além disso, instrumentos de autorrelato podem sofrer influência de fatores culturais, somáticos e emocionais que variam conforme o perfil dos participantes.

Sugere-se que pesquisas futuras ampliem o número de participantes, estratifiquem grupos por níveis funcionais e investiguem longitudinalmente os efeitos das atividades artísticas, permitindo observar mudanças ao longo do tempo. Estudos que integrem medidas fisiológicas, funcionais e neuropsicológicas também podem enriquecer a compreensão dos mecanismos envolvidos. Ademais, os resultados deste estudo reforçam

a importância das práticas artístico-culturais como instrumentos potentes de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida entre pessoas idosas, contribuindo para políticas públicas e ações interdisciplinares que valorizem o envelhecimento ativo e a participação social. Além da realização de pesquisas qualitativas, dando maior ênfase a fala dos indivíduos que pode trazer informações que por vezes não são captadas pelos instrumentos.

REFERÊNCIAS

- ALEXOPOULOS, G. S. (2005). Depression in the elderly. *The Lancet*, 365(9475), 1961–1970. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)66665-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66665-2)
- ANDREESCU, C., & LEE, S. (2020). Anxiety disorders in the elderly. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 22(1), 35–45.
- ATLANTIS, E., & BAKER, M. (2021). Bidirectional associations between depression and cardiovascular disease: A systematic review. *Heart, Lung and Circulation*, 30(2), 207–215. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2020.09.012>
- BEARD, C., MILLNER, A. J., FORGEARD, M. J., FRIED, E. I., HSU, K. J., TREADWAY, M. T., LEONARD, C. V., KERTZ, S. J., & BJÖRGVINSSON, T. (2016). Network analysis of depression and anxiety symptom relationships in a psychiatric sample. *Psychological Medicine*, 46(16), 3359–3369. <https://doi.org/10.1017/S0033291716002300>
- BECK, A. T., STEER, R. A., & BROWN, G. K. (1996). *Manual for the Beck Depression Inventory-II*. Psychological Corporation.
- BEEKMAN, A. T. F., BREMMER, M. A., DEEG, D. J. H., VAN BALKOM, A. J. L. M., SMIT, J. H., DE BEURS, E., VAN DYCK, R., & VAN TILBURG, W. (1998). Anxiety disorders in later life: A report from the Longitudinal Aging Study Amsterdam. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 13(10), 717–726. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1166\(199810\)13:10<717::AID-GPS857>3.0.CO;2-M](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1166(199810)13:10<717::AID-GPS857>3.0.CO;2-M)
- BLAZER, D. G. (2020). Depression in late life: Challenges and opportunities. *Biological Psychiatry*, 87(7), 659–666. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.11.019>
- BRUCK, J. I., et al. (2003). Sleep disturbances in depression. *Journal of Clinical Psychiatry*, 64(9), 1120–1127.
- BURKHARDT, J., & Brennan, C. (2012). The effects of recreational dance interventions on the health and well-being of older adults. *Arts & Health*, 4(3), 201–218. <https://doi.org/10.1080/17533015.2012.665367>

- CAMARANO, A. A., & Kanso, S. (2021). *Envelhecimento da população brasileira: Desafios e consequências sociais*. IPEA.
- CAMARGOS, M. C. S., PERPÉTUO, I. H. O., & MACHADO, C. J. (2020). Escolaridade, condições de saúde e funcionalidade entre idosos brasileiros. *Revista de Saúde Pública*, 54, e1793. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054001793>
- CAMPBELL, M. J., & SWINSCOW, T. D. V. (2019). *Statistics at square one* (11th ed.). Wiley-Blackwell.
- CASTRO, C. M., et al. (2019). Psychological factors and aging. *Aging & Mental Health*, 23(6), 715–723.
- CHEN, X., HUANG, Y., & CHEN, Y. (2021). Effects of music and dance interventions on health outcomes in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Geriatric Nursing*, 42(6), 1418–1427. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2021.08.003>
- COFFMAN, D. (2020). Music participation and well-being in older adults.
- COHEN, G. D., et al. (2006). The impact of professionally conducted cultural programs on the physical health, mental health, and social functioning of older adults. *The Gerontologist*, 46(6), 726–734.
- COSTA, M. F. S., BARROS, A. D. S., & MOURA, A. M. M. (2021). Acesso e utilização de serviços de saúde por pessoas idosas no Brasil: Revisão integrativa. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 24(5), e210138. <https://doi.org/10.1590/1981-22562021024.210138>
- COUBARD, O. A., DURETZ, S., LEFEBVRE, V., LAPALUS, P., & FERRUFINO, L. (2011). Practice of contemporary dance improves cognitive flexibility in aging. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 3, 13. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2011.00013>
- CREECH, A., HALLAM, S., VARVARIGOU, M., & MCQUEEN, H. (2014). *Active music making in later life*.
- CREECH, A., HALLAM, S., VARVARIGOU, M., McQueen, H., & Gaunt, H. (2016). The role of musical participation in promoting well-being among older adults. *Arts & Health*, 8(3), 197–212. <https://doi.org/10.1080/17533015.2015.1032259>
- CRUZ-FERREIRA, A., et al. (2015). Effects of dance on anxiety in older adults. *Complementary Therapies in Medicine*, 23(2), 160–166. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2015.01.001>
- CUDDY, L. L., SIKKA, R., & VANSTONE, A. (2015). Preservation of musical memory and engagement in healthy aging and dementia. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1337(1), 223–231.

- DAYKIN, N., et al. (2018). Music, mental health, and wellbeing: A systematic review. *Arts & Health*, 10(3), 205–226.
<https://doi.org/10.1080/17533015.2017.1295097>
- EYIGOR, S., KARAPOLAT, H., DURMAZ, B., IBISOGLU, U., & Cakir, S. (2009). A randomized controlled trial of Turkish folkloric dance on physical performance, balance, depression and quality of life in older women. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 48(1), 84–88.
<https://doi.org/10.1016/j.archger.2007.10.008>
- FAGERSTRÖM, C., & BORGLIN, G. (2021). Happiness, well-being, and their relation to quality of life in older adults. *BMC Geriatrics*, 21, 1–14.
<https://doi.org/10.1186/s12877-021-02035-y>
- FANCOURT, D., & FINN, S. (2019). *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?* World Health Organization.
- FERREIRA, L. M. B., COUTO, A. M., & MELO, R. C. (2018). Fatores psicossociais associados à saúde mental e qualidade de vida de idosos. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 21(3), 310–321.
<https://doi.org/10.1590/1981-22562018021.170194>
- FIELD, A. P. (2020). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE.
- FLECK, M. P. A., et al. (2000). Desenvolvimento da versão em português do WHOQOL-BREF. *Revista de Saúde Pública*, 34(2), 178–183.
- FLECK, M. P. A., et al. (2008). Aplicação da versão em português do WHOQOL-bref. *Revista de Saúde Pública*, 34(2), 178–183.
- FRANCO, R., SOARES, A., & Rodrigues, C. (2021). Music engagement and mental health in older adults. *Aging & Mental Health*, 25(7), 1285–1294.
- FRANCO, M. R., SHERRINGTON, C., TIEDEMANN, A., & PEREIRA, L. S. M. (2023). Creative art-based interventions for older adults. *The Gerontologist*, 63(1), 45–57. <https://doi.org/10.1093/geront/gnac060>
- GANDINI, D., et al. (2007). Depression in the elderly: Clinical aspects. *Journal of Geriatric Psychiatry*.
- GONÇALVES, D. C., & ANDRADE, L. H. (2021). Anxiety disorders in older adults. *Current Psychiatry Reports*, 23(10), 62–71.
- HACKETT, R. A., & STEPTOE, A. (2022). Type 2 diabetes mellitus and psychological stress. *Nature Reviews Endocrinology*, 18, 547–560.
<https://doi.org/10.1038/s41574-022-00684-3>
- HAIR, J. F., BLACK, W. C., BABIN, B. J., & ANDERSON, R. E. (2020). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- HALLAM, S., & CREECH, A. (2016). *Music education and wellbeing*. Oxford University Press.

- HUI, E., CHUI, B. T., & WOO, J. (2009). Effects of dance on physical and psychological well-being in older persons. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 49(1), e45–e50. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2008.08.006>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2022). *Censo Demográfico 2022*.
- KEOGH, J. W. L., KILDING, A., PIDGEON, P., ASHLEY, L., & Gillis, D. (2009). Physical benefits of dancing for healthy older adults. *Journal of Aging and Physical Activity*, 17(4), 479–500.
- KEOGH, J. W. L., et al. (2019). Physical benefits of dance for older adults.
- KOCH, S. C., et al. (2014). Dance movement therapy in aging. *The Arts in Psychotherapy*, 41(1), 46–64.
- KOCH, S. C., et al. (2019). Dance movement therapy and psychological outcomes. *The Arts in Psychotherapy*, 41(1), 46–64.
- LENZE, E. J., et al. (2019). Elevated cortisol in older adults with generalized anxiety disorder. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 17(8), 754–762.
- LI, X., ZHANG, Q., & WANG, Y. (2022). Art-based activities and psychological wellbeing in older adults. *Aging & Mental Health*, 26(3), 480–492. <https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1861219>
- LIMA, M. C. P., et al. (2016). Transtornos mentais comuns e qualidade de vida em idosos. *Cadernos de Saúde Pública*, 32(9).
- LÓPEZ-HIGES, R., et al. (2025). Cognitive performance among older adults with subjective cognitive decline. *Geriatrics*, 10(2), 39. <https://doi.org/10.3390/geriatrics10020039>
- MACDONALD, R., KREUTZ, G., & MITCHELL, L. (Eds.). (2012). *Music, health and wellbeing*. Oxford University Press.
- MENG, X., et al. (2020). Effects of dance intervention on cognition. *Aging Clinical and Experimental Research*, 32(1), 7–19. <https://doi.org/10.1007/s40520-019-01128-3>
- MENDES, J. D., RIBEIRO, A. P., & GIACOMIN, K. C. (2021). Determinantes sociais do envelhecimento. *Saúde em Debate*, 45(130), 1001–1016.
- MEZUK, B., EATON, W. W., Albrecht, S., & Golden, S. H. (2020). Depression and type 2 diabetes over the lifespan. *Diabetes Care*, 43(8), 1679–1686. <https://doi.org/10.2337/dc19-2255>
- NERI, A. L. (2019). *O envelhecimento no século XXI*. Papirus.
- OLIVEIRA, J. S., & SANTOS, P. F. (2022). Atividades artísticas e saúde mental de idosos. *Revista Kairós Gerontologia*, 25(1), 13–28.
- Organização Mundial da Saúde. (2021). *Mental health of older adults*.
- Organização Mundial da Saúde. (2022). *World report on ageing and health*.
- Organização Pan-Americana da Saúde. (2020). *Decade of Healthy Ageing: Baseline report*.

- PAPALIA, D. E., & FELDMAN, R. D. (2020). *Desenvolvimento humano* (14^a ed.). AMGH.
- PEREIRA, C., FRANÇA, C., & FERREIRA, M. (2021). Dance-based interventions and psychological outcomes. *Arts & Health, 13*(3), 213–227.
- REHFELD, K., et al. (2018). Dance training is superior to repetitive exercise in brain plasticity. *Frontiers in Human Neuroscience, 12*, 305.
<https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00305>
- SACZYNSKI, J. S., ZUELSendorff, M., & KOSCIK, R. (2020). Cognition and mental health in aging. *Annual Review of Clinical Psychology, 16*, 295–321.
- SÄRKÄMÖ, T., et al. (2014). Benefits of musical activities in dementia. *Aging & Mental Health, 18*(6), 706–716.
- SILVA, C. R., & NERI, A. L. (2020). Atividades de lazer e bem-estar psicológico. *Psicologia: Reflexão e Crítica, 33*, 8.
- TAVARES, L. F., SOUZA, M. R., & Pereira, J. A. (2021). Dança, música e cognição. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 24*(2).
- TRAVASSOS, C., & VIACAVA, F. (2020). Acesso e uso de serviços de saúde no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva, 25*(5), 1799–1810.
- ZHANG, Y., et al. (2021). Dance interventions in mild cognitive impairment. *Aging & Mental Health, 25*(9), 1616–1626.
- ZHANG, W., ZHANG, J., & GAO, N. (2025). Social isolation and cognitive decline in older adults. *BMC Geriatrics, 25*, 775. <https://doi.org/10.1186/s12877-025-06430-6>
- ZOU, C., et al. (2024). Home-based lifestyle interventions and cognition. *BMC Geriatrics, 24*, 200. <https://doi.org/10.1186/s12877-024-04798-5>
-

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou investigar as repercussões biopsicossociais da participação de pessoas idosas em atividades artístico-culturais, especificamente dança e prática instrumental, analisando seus efeitos sobre cognição, estado emocional, funcionalidade e qualidade de vida. Além disso, descreveu o perfil sociodemográfico, hábitos de vida e condições de saúde dos participantes, bem como as inter-relações entre desempenho cognitivo, sintomas depressivos e ansiosos, fragilidade funcional e percepção de qualidade de vida.

A caracterização da amostra evidenciou um perfil consonante com o cenário brasileiro do envelhecimento: predominância feminina, elevada presença de doenças crônicas e vulnerabilidades determinadas pelos determinantes sociais da saúde. Mesmo entre pessoas idosas ativas e independentes, verificou-se prevalência expressiva de fragilidade e pré-fragilidade, além de proporção relevante de participantes com desempenho cognitivo inferior ao esperado para a escolaridade. Esses achados reforçam a complexidade do envelhecimento e a coexistência de independência funcional com riscos latentes, associados à multimorbidade, escolaridade reduzida e polifarmácia. O estado emocional também mostrou-se modulado, especialmente no grupo de Dança, apresentando maior prevalência de sintomas sugestivos de depressão e ansiedade. O que interferiu diretamente na percepção de qualidade de vida destas pessoas idosas.

Os resultados permitem concluir que as práticas artístico-culturais — dança e música — constituem estratégias efetivas de promoção do envelhecimento ativo, favorecendo engajamento social, estímulos cognitivos e regulação emocional. Entretanto, também evidenciam que esses benefícios são influenciados por determinantes sociais, nível funcional, histórico emocional e características individuais. A ausência de diferenças estatísticas entre as modalidades reforça a ideia de que o mais relevante não é o tipo de atividade, mas a oportunidade contínua de participação cultural, expressão subjetiva e interação social.

Como limitações, destacam-se principalmente o tamanho reduzido da amostra, especialmente do grupo de instrumentos musicais, e o uso de instrumentos de autorrelato, susceptíveis a variações emocionais, culturais e somáticas. Recomenda-se que pesquisas futuras ampliem o número de participantes, adotem desenhos longitudinais, estratifique grupos por níveis funcionais e integrem medidas fisiológicas e neuropsicológicas para

aprofundar a compreensão dos mecanismos envolvidos. Além da realização de pesquisas do tipo qualitativas, com foco na fala/discurso dos participantes.

Por fim, os achados deste estudo reforçam a necessidade de políticas públicas e ações interdisciplinares que ampliem o acesso às práticas artístico-culturais, reconhecendo-as como ferramentas de grande potencial para a promoção da saúde, prevenção da fragilidade e fortalecimento da qualidade de vida no envelhecimento. Trata-se de uma estratégia socialmente acessível, culturalmente relevante e cientificamente respaldada para a construção de um envelhecimento mais saudável, participativo e significativo, podendo ser amplamente instaurada no âmbito do SUS e das Políticas de saúde voltadas para a pessoa idosa.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, J. A., COPPOTELLI, G., ROLO, A. P., et al. (2022). Mitochondrial and metabolic dysfunction in ageing and age-related diseases. *Nature Reviews Endocrinology*, 18(4), 243–258. <https://doi.org/10.1038/s41574-021-00626-7>
- BALTES, P. B., & BALTES, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In P. B. Baltes & M. M. Baltes (Eds.), *Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences* (pp. 1–34). Cambridge University Press.
- BJORKSTEN, J. (1968). The crosslinkage theory of aging. *Journal of the American Geriatrics Society*, 16(4), 408–427.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2006). *Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa*.
- DA COSTA, J. P., VITORINO, R., SILVA, G. M., VOGEL, C., DUARTE, A. C., & ROCHA-SANTOS, T. (2016). A synopsis on aging—Theories, mechanisms and future prospects. *Ageing Research Reviews*, 29, 90–112. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2016.06.005>
- DE MARCO, M. A., et al. (2003). O modelo biopsicossocial na prática clínica. *Revista Brasileira de Educação Médica*.
- EFFROS, R. B. (2005). The role of the immune system in aging. *Immunology Reviews*, 205, 8–19.
- FREUND, A. M., & BALTES, P. B. (2002). Life-management strategies of selection, optimization, and compensation: Measurement by self-report and construct validity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(4), 642–662. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.4.642>
- GARBACCIO, J. L., et al. (2022). Aging and quality of life of elderly people in rural areas. *Revista Brasileira de Enfermagem*.
- HARADA, C. N., NATELSON LOVE, M. C., & TRIEBEL, K. L. (2013). Normal cognitive aging. *Clinics in Geriatric Medicine*, 29(4), 737–752.
- HARMAN, D. (1993). Free radical theory of aging. *Mutation Research*, 275(3–6), 257–266.
- HOU, Y., DAN, X., BABBAR, M., et al. (2019). Ageing as a risk factor for neurodegenerative disease. *Nature Reviews Neurology*, 15, 565–581.

- HSU, H.-C. (2020). Associations of active aging in municipal and age-friendliness with welfare among older adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), 4303. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124304>
- HUSSENOEDER, F. S., JENTZSCH, D., MATSCHINGER, H., et al. (2020). Depression and quality of life in old age. *European Journal of Ageing*. <https://doi.org/10.1007/s10433-020-00573-8>
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (2022). Censo demográfico 2022.
- KRUK, P. A., et al. (1995). Telomeres and aging. *Journal of Gerontology*.
- LEON, L. P., MANGIN, J. P. L., & BALLESTEROS, S. (2020). Psychosocial determinants of quality of life and active aging. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(17), 6023.
- LÉS, A., GUSZKOWSKA, M., PIOTROWSKA, J., & RUTKOWSKA, I. (2019). Changes in perceived quality of life in older women. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 59, 1783–1790.
- LIVINGSTON, G., HUNTLEY, J., SOMMERLAD, A., et al. (2020). Dementia prevention, intervention, and care. *The Lancet*, 396(10248), 413–446.
- MARSILLAS, S., DE DONDER, L., KARDOL, T., et al. (2017). Does active aging contribute to life satisfaction? *European Journal of Ageing*, 14, 295–310.
- MARTIN, P., KELLY, N., KAHANA, B., KAHANA, E., WILLCOX, B. J., WILLCOX, D. C., & POON, L. W. (2015). Defining successful aging: A tangible or elusive concept? *The Gerontologist*, 55(1), 14–25. <https://doi.org/10.1093/geront/gnu044>
- MENDES, E. V. (1996). Um novo paradigma sanitário: a produção social da saúde. In *Uma agenda para a saúde* (pp. 237–250). Hucitec.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. (1947). Constitution of the World Health Organization.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. (2001). Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. (2015). World report on ageing and health.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. (2020). Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. (2021). Social determinants of health.

- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. (2020). Década do Envelhecimento Saudável 2020–2030.
- RATTAN, S. I. S. (2006). Theories of biological aging: Genes, proteins, and free radicals. *Free Radical Research*, 40(12), 1230–1238.
- RIBEIRO, J. L. P. (2011). Psicologia da saúde e intervenções comportamentais. *Psicologia, Saúde & Doenças*.
- STEPTOE, A., DEATON, A., & STONE, A. A. (2015). Subjective wellbeing, health, and ageing. *The Lancet*, 385(9968), 640–648.
- TIELAND, M., TROUWBORST, I., & CLARK, B. C. (2017). Skeletal muscle performance and ageing. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 9(1), 3–19.
- WARNER, H. R., et al. (1987). Genetic determinants of senescence. *Experimental Gerontology*.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2020). Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines.

APÊNDICE A - *CHEKLIST DA CIF- ADAPTADA*

(Acrescentadas as questões que referem-se aos Determinantes Sociais em Saúde)

INFORMAÇÕES SÓCIODEMOGRÁFICAS, HÁBITOS DE VIDA E CONDIÇÕES DE SAÚDE - RELATO PRÓPRIO

Nome: _____ Data de Nascimento: _____

Sexo Biológico: ☐ Feminino ☐ Masculino Idade: _____ Cor: _____ Raça: _____

Grau de Escolaridade:

Aletrado ☐ Fundamental Incompleto ☐ Fund. Completo ☐ Médio Incompleto ☐ Médio Completo ☐ Superior Incompleto ☐ Superior Completo ☐

Outro: _____

Endereço: _____

Quantas pessoas moram na residência? _____

Quais as condições de moradia?

Própria ☐ Alugada ☐ Outro: _____

Renda Individual: _____

Renda mensal familiar: _____ É o principal contribuinte ? ☐

Possui alguma Religião? _____

Como você avalia sua saúde física no último mês?

Muito boa ☐ Boa ☐ Moderada ☐ Ruim ☐ Muito ruim ☐

Você possui alguma Doença Crônica?

☐ NÃO ☐ SIM

Se sim, qual/quais? _____

Como você avalia sua saúde mental e emocional no último mês?

Muito boa ☐ Boa ☐ Moderada ☐ Ruim ☐ Muito ruim ☐

Você possui alguma Patologia Psiquiátrica? (Ex.: Ansiedade, Depressão, etc.)

☐ NÃO ☐ SIM

Se sim, qual? _____

Você está tomando algum medicamento (seja prescrito ou por conta própria)?

☐ NÃO ☐ SIM

Se SIM, por favor especifique os medicamentos principais _____

Caso faça uso de medicação, tem acesso regularmente a ela? Se sim, Como? _____

Você consome álcool ou drogas? ☐ NÃO ☐ SIM

Se SIM, por favor especifique quantidade média diária

Tabaco: _____

Álcool: _____

Drogas: _____

Como é sua alimentação?

Muito boa ☐ Boa ☐ Moderada ☐ Ruim ☐ Muito ruim ☐

(Considere como referência uma alimentação balanceada/saudável e com três refeições principais – Café, Almoço e Jantar)

Você tem acesso facilmente aos Serviços de Saúde Públicos (SUS) ou Privados (Planos de Saúde e/ou Convênios)?

☐ NÃO ☐ SIM

Se SIM, por favor, especifique se utiliza majoritariamente o Serviço Público ou privado _____

Informação adicional significativa sobre sua saúde passada e presente: _____

APÊNDICE B - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: ATIVIDADES ARTÍSTICO CULTURAIS: REPERCUSSÕES SOB OS ASPECTOS BIOPSIKOSSOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS IDOSAS

Eu, Carlúcia Ithamar Fernandes Franco, Professora Doutora Associada C, da Universidade Estadual da Paraíba portador(a) do CPF 309.063.774-04 declaro que estou ciente do referido Projeto de Pesquisa e comprometo - me em acompanhar seu desenvolvimento no sentido de que se possam cumprir integralmente as Diretrizes da Resolução nº 466 de 2012 e/ou Resolução nº 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos.

Campina Grande, Outubro de 2023.



Pesquisador Responsável (Orientador)

Orientando

**APÊNDICE C - TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR
RESPONSÁVEL EM CUMPRIR OS TERMOS DA RESOLUÇÃO nº 466 de 2012
e / ou RESOLUÇÃO nº 510 de 2016 DO CONEP/CNS/MS (TCPR)**

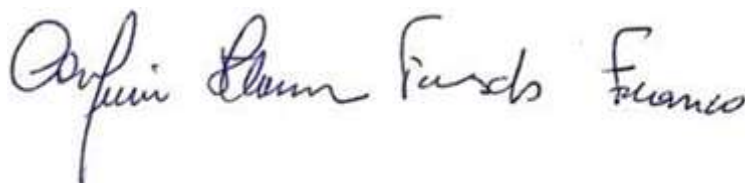
**Título do Projeto: ATIVIDADES ARTÍSTICO CULTURAIS: REPERCUSSÕES
SOB OS ASPECTOS BIOPSISSOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA EM
PESSOAS IDOSAS**

Eu, Carlúcia Ithamar Fernandes Franco, Professor(a) do Curso de Fisioterapia, da Universidade Estadual da Paraíba, portador(a) do RG: 688452 e CPF: 309.063.774-04, comprometo-me em cumprir integralmente as diretrizes da Resolução nº. 466 de 2012 e / ou Resolução nº 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos.

Estou ciente das penalidades que poderei sofrer caso infrinja qualquer um dos itens da referida resolução.

Por ser verdade, assino o presente compromisso.

Campina Grande, Agosto de 2023



Assinatura do(a) Pesquisador responsável Orientador(a)

**APÊNDICE D - TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE
DADOS DE ARQUIVO OU PRONTUÁRIOS (TCDA)**

**Título do Projeto: ATIVIDADES ARTÍSTICO CULTURAIS: REPERCUSSÕES
SOB OS ASPECTOS BIOPSISSOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA EM
PESSOAS IDOSAS**

Pesquisador responsável: Carlúcia Ithamar Fernandes Franco (Orientadora)

Nome dos Pesquisadores participantes: Ana Caroline Pereira da Silva Mamede
(Mestranda)

Banco de dados do: Centro Artístico Cultural (CAC) da Pró-Reitoria de Cultura da
Universidade Estadual da Paraíba (ProCult-UEPB).

Coletados no CAC-ProCult-UEPB.

O(s) pesquisador(es) do projeto acima identificado(s) assume(m) o compromisso de:

I Preservar a privacidade dos pacientes cujos dados serão coletados;

II Assegurar que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução
do projeto em questão;

III Assegurar que as informações somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo
usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o participante da
pesquisa.

De modo que, tais compromissos estão em conformidade com as Diretrizes previstas na
Resolução nº 466 de 2012 e / ou na Resolução nº 510 de 2016 do Conselho Nacional de
Saúde do Ministério da Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que dispõe sobre
Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos.

Campina Grande, Agosto de 2023

Assinar o nome legível de todos os pesquisadores:



Pesquisador Responsável (Orientador)



Orientador

ANEXO A - MINI EXAME DE ESTADO MENTAL (MEEM)

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL

(Folstein, Folstein & McHugh, 1975)

Paciente: _____

Data da Avaliação: ____/____/____ Avaliador: _____

ORIENTAÇÃO

- Dia da semana (1 ponto) ()
- Dia do mês (1 ponto) ()
- Mês (1 ponto) ()
- Ano (1 ponto) ()
- Hora aproximada (1 ponto) ()
- Local específico (apartamento ou setor) (1 ponto) ()
- Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto) ()
- Bairro ou rua próxima (1 ponto) ()
- Cidade (1 ponto) ()
- Estado (1 ponto) ()

MEMÓRIA IMEDIATA

- Fale 3 palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras. Dê 1 ponto para cada resposta correta ()
- Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante você irá perguntá-las novamente.

ATENÇÃO E CÁLCULO

- (100 - 7) sucessivas, 5 vezes sucessivamente (1 ponto para cada cálculo correto) ()
- (alternativamente, soletrar MUNDO de trás para frente)

EVOCAÇÃO

- Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente (1 ponto por palavra) ()

LINGUAGEM

- Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos) ()
- Repetir "nem aqui, nem ali, nem lá" (1 ponto) ()
- Comando: "pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão" (3 pontos) ()
- Ler e obedecer: "feche os olhos" (1 ponto) ()
- Escrever uma frase (1 ponto) ()
- Copiar um desenho (1 ponto) ()

SCORE: (____/30)



ANEXO B - INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK-II (BDI-II)

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve **melhor** a maneira que você tem se sentido na **última semana, incluindo hoje**. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. **Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha.**

1	0 Não me sinto triste 1 Eu me sinto triste 2 Estou sempre triste e não consigo sair disto 3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar	7	0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo 1 Estou decepcionado comigo mesmo 2 Estou enojado de mim 3 Eu me odeio
2	0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro 1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 2 Acho que nada tenho a esperar 3 Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar	8	0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 1 Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros 2 Eu me culpo sempre por minhas falhas 3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece
3	0 Não me sinto um fracasso 1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 2 Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos 3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso	9	0 Não tenho quaisquer idéias de me matar 1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria 2 Gostaria de me matar 3 Eu me mataria se tivesse oportunidade
4	0 Tenho tanto prazer em tudo como antes 1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes 2 Não encontro um prazer real em mais nada 3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo	10	0 Não choro mais que o habitual 1 Choro mais agora do que costumava 2 Agora, choro o tempo todo 3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, mesmo que o quera
5	0 Não me sinto especialmente culpado 1 Eu me sinto culpado grande parte do tempo 2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 3 Eu me sinto sempre culpado	11	0 Não sou mais irritado agora do que já fui 1 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava 2 Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 3 Não me irrita mais com coisas que costumavam me irritar
6	0 Não acho que esteja sendo punido 1 Acho que posso ser punido 2 Creio que vou ser punido 3 Acho que estou sendo punido	12	0 Não perdi o interesse pelas outras pessoas 1 Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar 2 Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 3 Perdi todo o interesse pelas outras pessoas

13	0 Tomo decisões tão bem quanto antes 1 Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 2 Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 3 Absolutamente não consigo mais tomar decisões	18	0 O meu apetite não está pior do que o habitual 1 Meu apetite não é tão bom como costumava ser 2 Meu apetite é muito pior agora 3 Absolutamente não tenho mais apetite
14	0 Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes 1 Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo 2 Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que me fazem parecer sem atrativo 3 Acredito que pareço feio	19	0 Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum recentemente 1 Perdi mais do que 2 quilos e meio 2 Perdi mais do que 5 quilos 3 Perdi mais do que 7 quilos Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: Sim ____ Não ____
15	0 Posso trabalhar tão bem quanto antes 1 É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 2 Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 3 Não consigo mais fazer qualquer trabalho	20	0 Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o habitual 1 Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do estômago ou constipação 2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa 3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer outra coisa
16	0 Consigo dormir tão bem como o habitual 1 Não durmo tão bem como costumava 2 Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil voltar a dormir 3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir	21	0 Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo 1 Estou menos interessado por sexo do que costumava 2 Estou muito menos interessado por sexo agora 3 Perdi completamente o interesse por sexo
17	0 Não fico mais cansado do que o habitual 1 Fico cansado mais facilmente do que costumava 2 Fico cansado em fazer qualquer coisa 3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa		

NOTA: Os valores básicos são: 0-9 indicam que o indivíduo não está deprimido, 10-18 indicam depressão leve a moderada, 19-29 indicam depressão moderada a severa e 30-63 indicam depressão severa. Valores maiores indicam maior severidade dos sintomas depressivos.

ANEXO C - ESCALA DE ANSIEDADE DE HAMILTON

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE DE HAMILTON

Nome: _____ Data: ____/____/____

Categoria I – Ansiedade psíquica	Ausente 0	Leve 1	Moderada 2	Frequente 3	Muito frequente 4
Humor ansioso (Preocupações, previsão do pior, antecipação temerosa, irritabilidade...)					
Tensão (Sensações de tensão, fadiga, reação de sobressalto, comove-se facilmente, tremores, incapacidade para relaxar e agitação)					
Medos (De escuro, de estranhos, de ficar sozinho, de animais, de trânsito, de multidões, etc)					
Insônia (Dificuldade em adormecer, sono interrompido, insatisfeito e fadiga ao despertar, pesadelos, terrores noturnos...)					
Dificuldades intelectuais (Dificuldade de concentração, falhas de memória, etc)					
Humor depressivo (Perda de interesse, falta de prazer nos passatempos, depressão, despertar precoce, oscilação do humor...)					
Categoria II – Ansiedade Somática					
Sintomas musculares (Dores musculares, rigidez muscular, contrações espásticas, contrações involuntárias, etc)					
Sintomas sensoriais (Ondas de frio ou calor, sensações de fraqueza, visão turva, sensação de picadas, formiguelo, câibras, dormências, zumbidos, etc)					
Sintomas cardiovasculares (Taquicardia, palpitações, dores torácicas, sensação de desmaio, vertigem, etc)					
Sintomas respiratórios (Sensações de opressão ou constrição no tórax, sensações de sufocamento ou asfixia, suspiros...)					
Sintomas genito-urinários (Urgência miccional, amenorreia, menorragia, ereção incompleta, ejaculação precoce, impotência, diminuição da libido, etc)					
Sintomas do sistema nervoso autônomo (Boca seca, rubor, palidez, tendência a sudorese, mãos molhadas, inquietação, tensão, dor de cabeça, pêlos eriçados, tonturas, etc)					

Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 1960;23(56):56-62.

Araújo RHS. Adaptação transcultural da GRID Hamilton Rating Scale for Depression (GRID-HAMD) para o português brasileiro e avaliação do impacto de um treinamento sobre a confiabilidade interavaliadores [dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia, 2011.

ANEXO D - WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE” – BREF (WHOQOL – BREF)

Por favor, tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações. Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas semanas. As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas últimas duas semanas.

		muito ruim	ruim	ruim nem boa	boa nem	muito boa
1	Como você avaliaria sua qualidade de vida?	1	2	3	4	5

		muit o insatisfeito	insatisfeito	nem satisfeito nem insatisfeito	satisfeito	muito satisfeito
2	Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde?	1	2	3	4	5

As questões seguintes são sobre **o quanto** você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.

		nada	muito pouco	mais ou menos	bastante	extremamente
3	Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa?	1	2	3	4	5
4	O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária?	1	2	3	4	5
5	O quanto você aproveita a vida?	1	2	3	4	5
6	Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?	1	2	3	4	5

7	O quanto você consegue se concentrar?	1	2	3	4	5
8	Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária?	1	2	3	4	5
9	Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)?	1	2	3	4	5

As questões seguintes perguntam sobre **quão completamente** você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas.

		nada	muito pouco	médio	muito	completamente
10	Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia?	1	2	3	4	5
11	Você é capaz de aceitar sua aparência física?	1	2	3	4	5
12	Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?	1	2	3	4	5
13	Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia?	1	2	3	4	5
14	Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer?	1	2	3	4	5

As questões seguintes perguntam sobre **quão bem ou satisfeito** você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.

24	Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde?	1	2	3	4	5
25	Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte?	1	2	3	4	5

As questões seguintes referem-se a **com que frequência** você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas semanas.

		nunca	algumas vezes	frequentemente	muito frequentemente	sempre
26	Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão?	1	2	3	4	5

